

Bunga Rampai

ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA

**Pada Keluarga Dengan Anggota Yang Menderita
Tuberkulosis Paru**

Nur Fadhilah • Ardila Lailatul Barik • Anis Rosyiatul Husna
Christine Bernadette Maria Rumokoy • Faisal Ibnu

Editor: Iskandar



BUNGA RAMPAI: ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA PADA KELUARGA DENGAN ANGGOTA YANG MENDERITA TUBERKULOSIS PARU

Penulis:

Nur Fadhilah, S.Kep., M.Kes., Ph.D
Ns. Ardila Lailatul Barik, S.Kep., M.Kep
Anis Rosyiatul Husna, S.Kep.Ns., M.Kes
Christine Bernadette Maria Rumokoy, S.Kep., Ns., M.Kep
Dr. Faisal Ibnu, S.Pd.S.Kep.Ns.M Kes.

Editor:

Iskandar, SKM., MKM

Bunga Rampai: Asuhan Keperawatan Keluarga Pada Keluarga Dengan Anggota Yang Menderita Tuberkulosis Paru

Penulis:

Nur Fadhilah, S.Kep., M.Kes., Ph.D
Ns. Ardila Lailatul Barik, S.Kep., M.Kep
Anis Rosyiatul Husna, S.Kep.Ns., M.Kes
Christine Bernadette Maria Rumokoy, S.Kep., Ns., M.Kep
Dr. Faisal Ibnu, S.Pd.S.Kep.Ns.M Kes.

Editor: Iskandar, SKM., MKM

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Helmi Syaukani, S.Pd.

ISBN: 978-634-7756-38-1

Cetakan Pertama: Juni, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan kemudahan-Nya sehingga bunga rampai yang berjudul “Asuhan Keperawatan Keluarga pada Keluarga dengan Anggota yang Menderita Tuberkulosis Paru” ini dapat disusun dengan baik. Kehadiran buku ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran keluarga dalam mendukung keberhasilan perawatan, pengobatan, pencegahan penularan, serta pemulihan anggota keluarga yang menderita Tuberkulosis Paru.

Tuberkulosis Paru masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian serius. Penyakit ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisik penderita, tetapi juga memengaruhi aspek psikologis, sosial, ekonomi, serta dinamika kehidupan keluarga. Oleh karena itu, pendekatan keperawatan keluarga menjadi sangat penting karena keluarga merupakan lingkungan terdekat yang berperan dalam mengenali masalah kesehatan, mengambil keputusan, memberikan perawatan, menciptakan lingkungan yang sehat, serta memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan secara tepat.

Bunga rampai ini disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai asuhan keperawatan keluarga pada kasus Tuberkulosis Paru. Pembahasan dalam buku ini mencakup konsep keluarga dan Tuberkulosis, tugas kesehatan keluarga dalam merawat anggota keluarga dengan TB Paru, pengkajian keperawatan keluarga dan kondisi lingkungan rumah, edukasi mengenai kepatuhan minum obat, etika batuk, pemenuhan nutrisi, serta pentingnya ventilasi rumah. Selain itu, buku ini juga membahas pemberdayaan keluarga dalam mencegah penularan dan memberikan dukungan terhadap proses pemulihan pasien TB Paru.

Penyusunan buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, serta masyarakat yang memiliki perhatian terhadap upaya pengendalian Tuberkulosis Paru berbasis keluarga. Melalui buku ini, pembaca diharapkan mampu memahami bahwa keberhasilan penanggulangan TB Paru tidak hanya bergantung pada terapi medis, tetapi juga pada keterlibatan aktif keluarga dalam mendukung kepatuhan pengobatan, membangun perilaku hidup bersih dan sehat, serta menciptakan lingkungan rumah yang aman dan mendukung pemulihan.

Kami menyadari bahwa bunga rampai ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi isi, penyajian, maupun kedalaman pembahasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan karya ini pada masa

mendatang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi, dan masukan dalam proses penyusunan buku ini.

Akhir kata, semoga bunga rampai ini dapat memberikan manfaat, memperkaya wawasan, serta menjadi kontribusi positif dalam pengembangan ilmu keperawatan keluarga, khususnya dalam upaya perawatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis Paru di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Juni 2026

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v

CHAPTER 1 KONSEP KELUARGA DAN TUBERKOLOSIS 1

Nur Fadhilah, S.Kep., M.Kes., Ph.D.....	1
A. Pendahuluan	1
B. Konsep Keluarga.....	2
C. Konsep Tuberkulosis	31
D. Referensi	39

CHAPTER 2 TUGAS KESEHATAN KELUARGA DALAM PERAWATAN ANGGOTA KELUARGA DENGAN TB PARU 42

Ns. Ardila Lailatul Barik, S.Kep., M.Kep	42
A. Pendahuluan	42
B. Tugas Kesehatan Keluarga pada Pasien TB Paru	43
C. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Keluarga dalam Merawat Pasien TB Paru	50
D. Hambatan Keluarga dalam Menjalankan Tugas Perawatan Pasien TB Paru....	53
E. Simpulan	56
F. Referensi	57
G. Glosarium	60

CHAPTER 3 PENGKAJIAN KEPERAWATAN KELUARGA DAN KONDISI LINGKUNGAN RAMAH 61

Anis Rosyiatul Husna, S.Kep., Ns., M.Kes	61
A. Pendahuluan	61
B. Pengertian Pengkajian Keperawatan Keluarga.....	62
C. Metode Pengumpulan Data	62
D. Fokus Pengkajian Keperawatan Keluarga.....	64
E. Kondisi Lingkungan Rumah	70
F. Pemeriksaan Fisik	71
G. Referensi	73
H. Glosarium	74

CHAPTER 4 EDUKASI KEPATUHAN MINUM OBAT, ETIKA BATUK, NUTRISI DAN VENTILASI RUMAH..... 76

Christine Bernadette Matia Rumokoy, S.Kep., Ns., M.Kep.....	76
A. Pendahuluan	76
B. Edukasi Kepatuhan Minum Obat.....	76
C. Etika Batuk	82
D. Nutrisi	83
E. Ventilasi Rumah	86
F. Simpulan.....	87
G. Referensi	88
H. Glosarium	90

CHAPTER 5 PEMBERDAYAAN KELUARGA DALAM PENCEGAHAN PENULARAN DAN DUKUNGAN PEMULIHAN PASIEN TB PARU 91

Dr. Faisal Ibnu, S.Pd., S.Kep.NS., M.Kes.....	91
A. Pendahuluan	91
B. Konsep Dasar TB Paru.....	92
C. Konsep Pemberdayaan Keluarga.....	93
D. Simpulan	106
E. Penutup.....	107
F. Referensi	108
G. Glosarium	109

PROFIL PENULIS..... 111

CHAPTER 1

KONSEP KELUARGA DAN TUBERKOLOSIS

Nur Fadhillah, S.Kep., M.Kes., Ph.D

A. Pendahuluan

Tuberkulosis (TBC) hingga saat ini masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang paling kompleks dan menantang, tidak hanya di tingkat global tetapi juga di Indonesia. Tingginya angka kejadian, keterlambatan penemuan kasus, ketidakpatuhan pengobatan, stigma sosial, hingga munculnya resistensi obat menunjukkan bahwa TBC bukan sekadar persoalan penyakit infeksi, melainkan persoalan multidimensional yang melibatkan aspek biologis, psikologis, sosial, budaya, ekonomi, dan keluarga. Dalam konteks tersebut, keluarga memiliki posisi yang sangat strategis sebagai sistem pendukung utama dalam pencegahan, perawatan, pengobatan, dan keberhasilan pengendalian TBC secara berkelanjutan.

Keberhasilan penatalaksanaan TBC tidak dapat hanya bergantung pada pelayanan kesehatan formal dan pendekatan kuratif semata. Dibutuhkan keterlibatan aktif keluarga sebagai unit terkecil masyarakat yang memiliki fungsi pemeliharaan kesehatan, pengambilan keputusan, dukungan emosional, serta pengawasan terapi terhadap anggota keluarga yang sakit. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai konsep keluarga dan keterkaitannya dengan masalah tuberkulosis menjadi landasan penting dalam praktik keperawatan keluarga yang holistik, komprehensif, dan berorientasi pada pemberdayaan.

Materi pada bagian ini disusun untuk memberikan pemahaman konseptual dan ilmiah mengenai keluarga serta kaitannya dengan penanggulangan TBC. Pembahasan tidak hanya menitikberatkan pada definisi dan tipe keluarga, tetapi juga menyoroti dinamika, fungsi, peran, serta kemampuan keluarga dalam menghadapi masalah kesehatan, khususnya tuberkulosis. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis evidence-based practice, materi ini diharapkan mampu menjadi fondasi bagi mahasiswa, tenaga kesehatan, maupun pembaca dalam memahami pentingnya intervensi keperawatan keluarga pada kasus TBC.

Lebih jauh, pembahasan ini diharapkan dapat membangun kesadaran kritis bahwa pengendalian TBC bukan hanya tanggung jawab individu yang sakit, melainkan tanggung jawab bersama yang harus dimulai dari keluarga. Keluarga yang memiliki pengetahuan, kepedulian, dan kemampuan adaptasi yang baik akan menjadi kekuatan utama dalam memutus rantai penularan, meningkatkan

keberhasilan terapi, serta memperbaiki kualitas hidup pasien. Dengan demikian, penguatan keluarga merupakan salah satu strategi paling fundamental dalam mewujudkan eliminasi TBC di masa depan.

B. Konsep Keluarga

1. Definisi Keluarga

Berbagai pakar telah mengemukakan definisi keluarga dengan pendekatan konseptual yang beragam, mencerminkan perbedaan sudut pandang teoretis, sosial, dan budaya dalam memahami institusi keluarga. Perbedaan perspektif ini menunjukkan bahwa keluarga merupakan entitas yang kompleks dan multidimensional, sehingga definisinya tidak dapat disederhanakan dalam satu pengertian tunggal, melainkan perlu dipahami secara komprehensif melalui kontribusi berbagai ahli.

a. Undang-undang No. 52 Tahun 2009

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

b. Depkes RI (2016)

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

c. Friedman (2019)

Keluarga adalah dua orang atau lebih yang disatukan oleh kebersamaan dan kedekatan emosional serta mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari keluarga.

d. Lancaster dan Stanhope (2020)

Keluarga adalah dua orang atau lebih individu yang berasal dari kelompok keluarga yang sama atau yang berbeda dan saling mengikutsertakan dalam kehidupan yang terus menerus, biasanya bertempat tinggal dalam satu rumah, mempunyai ikatan emosional dan adanya pembagian tugas antara satu dengan yang lainnya.

e. Menurut Duvall (1985)

Keluarga merupakan sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adopsi dan kelahiran yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan social dari setiap anggota.

f. Menurut Salvicion G.Bailon dan Aracelis Maglaya (1989)

Keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang bergabung karena hubungan darah, perkawinan, atau adopsi, yang hidup dalam satu rumah tangga, saling berinteraksi satu sama lainnya dalam perannya, serta menciptakan dan mempertahankan satu budaya.

g. Menurut Kaakinen (2018)

Menurut Kaakinen, keluarga tidak hanya dipandang sebagai kumpulan individu yang memiliki hubungan biologis atau legal, tetapi sebagai suatu sistem sosial yang dinamis. Keluarga didefinisikan sebagai sekelompok individu yang memiliki hubungan emosional, saling berinteraksi secara berkelanjutan, serta menjalankan fungsi dan peran tertentu dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan anggotanya. Lebih lanjut, Kaakinen menekankan beberapa aspek kunci dalam definisi keluarga, yaitu:

- 1) Keluarga sebagai sistem: setiap anggota saling memengaruhi satu sama lain; perubahan pada satu anggota akan berdampak pada seluruh sistem keluarga.
- 2) Hubungan emosional dan komitmen: ikatan keluarga tidak selalu harus berbasis darah atau hukum, tetapi juga dapat terbentuk melalui kedekatan emosional dan komitmen jangka panjang.
- 3) Fungsi kesehatan keluarga: keluarga berperan penting dalam menjaga, mempromosikan, dan memulihkan kesehatan anggotanya.
- 4) Keberagaman bentuk keluarga: konsep keluarga bersifat inklusif, mencakup berbagai bentuk keluarga modern sesuai konteks sosial dan budaya.

Berdasarkan berbagai definisi keluarga yang telah dikemukakan oleh para ahli, penulis menyimpulkan bahwa keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari dua orang atau lebih yang terikat oleh hubungan darah, perkawinan, atau adopsi, yang hidup bersama atau tidak dalam satu rumah tangga,, memiliki ikatan emosional yang kuat, menjalankan peran serta fungsi secara timbal balik, dan berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan serta mengembangkan kesejahteraan fisik, psikologis, sosial, dan budaya setiap anggotanya.

2. Tipe Keluarga

Perawat dituntut memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai tipologi keluarga sebagai dasar dalam merancang intervensi yang efektif dan kontekstual, khususnya dalam mendorong partisipasi aktif keluarga terhadap upaya peningkatan derajat kesehatan. Keluarga sebagai unit terkecil

dalam masyarakat memiliki karakteristik, struktur, dan dinamika yang beragam, sehingga pendekatan keperawatan tidak dapat bersifat seragam. Secara umum, pembagian tipe keluarga tidak berasal dari satu teori tunggal, melainkan merupakan hasil pengembangan dari berbagai disiplin ilmu, terutama keperawatan keluarga dan sosiologi.

Berdasarkan kajian para ahli, tipe keluarga secara umum diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu keluarga tradisional dan keluarga modern (non-tradisional), yang masing-masing memiliki pola peran, fungsi, serta mekanisme adaptasi yang berbeda dalam menghadapi masalah kesehatan. Friedman, Bowden, dan Jones (2003) mengklasifikasikan keluarga menjadi keluarga tradisional dan non-tradisional berdasarkan struktur dan fungsi keluarga. Selanjutnya, Kaakinen et al. (2018) mengembangkan konsep tersebut dengan memperkenalkan istilah *contemporary family* yang mencerminkan dinamika perubahan sosial modern. Sementara itu, Stanhope dan Lancaster (2020) mengkaji tipe keluarga dalam perspektif kesehatan masyarakat, khususnya pada kelompok rentan. Pendekatan ini diperkuat oleh teori sosiologi dari Macionis (2012) yang menjelaskan variasi bentuk keluarga sebagai respons terhadap perubahan sosial dan budaya.

a. Tradisional

Tipe keluarga tradisional dicirikan oleh struktur yang relatif stabil, terorganisasi secara jelas, dan mempertahankan pola peran yang telah mengakar dalam nilai-nilai budaya. Bentuk keluarga ini umumnya menunjukkan keutuhan sistem keluarga dengan pembagian fungsi yang cenderung tetap dari waktu ke waktu. Dalam konteks sosial-budaya, tipe keluarga tradisional lebih dominan dijumpai pada masyarakat di kawasan timur yang masih menjunjung tinggi norma, adat istiadat, serta ikatan kekerabatan yang kuat. Secara konseptual, tipe keluarga tradisional dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, antara lain sebagai berikut:

1) Keluarga Inti (*Nuclear Family*)

Keluarga inti adalah unit keluarga dasar yang terdiri dari pasangan suami-istri dengan atau tanpa anak yang tinggal dalam satu rumah tangga. Anak dalam keluarga ini dapat berupa anak kandung maupun anak adopsi.

2) Keluarga Tanpa Anak (*Dyad Family/ The Childless Family*)

Keluarga dyad atau keluarga tanpa anak (*childless family*) adalah unit keluarga yang terdiri dari dua individu dewasa, umumnya pasangan suami-istri, yang hidup bersama tanpa kehadiran anak. Kondisi ini dapat terjadi sebagai hasil pilihan sadar (*voluntary childless*), faktor biologis

seperti infertilitas, maupun berbagai kondisi sosial lainnya yang memengaruhi keputusan atau kemungkinan untuk memiliki anak.

3) Keluarga Adopsi (*Adoptive Family*)

Keluarga adopsi adalah keluarga yang memperoleh anak melalui proses adopsi secara legal, di mana orang tua angkat mengambil alih tanggung jawab pengasuhan, perlindungan, dan pendidikan dari orang tua biologis.

4) Keluarga Besar (*Extended Family*)

Keluarga yang terdiri dari anggota keluarga inti (ayah, ibu, dan anak) disertai paman, tante, orang tua keponakan, dan lain-lain. Keluarga besar ini merupakan gabungan dari beberapa generasi yang hidup bersama dalam satu rumah.

5) Keluarga Orang Tua Tunggal (*Single-Parent Family*)

Keluarga orang tua tunggal adalah keluarga yang terdiri dari satu orang tua (ayah atau ibu) yang menjalankan fungsi pengasuhan anak tanpa pasangan, akibat perceraian, kematian, kelahiran di luar nikah, atau sebab lainnya.

6) Keluarga Besar (*Extended Family*)

Keluarga besar adalah keluarga yang terdiri dari keluarga inti yang tinggal bersama atau berdekatan dengan anggota keluarga lain seperti kakek-nenek, paman, bibi, dan kerabat lainnya, sehingga mencakup lebih dari satu generasi. (Tidak harus selalu tinggal dalam satu rumah, bisa juga dalam satu lingkungan sosial yang dekat)

7) *Commuter Family*

Commuter family adalah keluarga di mana pasangan suami-istri tinggal terpisah secara geografis karena tuntutan pekerjaan atau alasan tertentu, namun tetap mempertahankan hubungan keluarga dan menjalankan peran keluarga secara berkala.

8) *Multigenerational Family*

Keluarga multigenerasi adalah keluarga yang terdiri dari tiga generasi atau lebih (misalnya kakek-nenek, orang tua, dan anak) yang hidup dalam satu rumah tangga atau dalam hubungan yang sangat erat

9) *Kin-Network Family*

Kin-network family adalah jaringan keluarga yang terdiri dari beberapa keluarga inti yang hidup berdekatan dan saling berinteraksi serta berbagi sumber daya, dukungan sosial, dan fungsi tertentu meskipun tidak selalu tinggal dalam satu rumah.

10) Keluarga Campuran (*Blended Family*)

Keluarga campuran adalah keluarga yang terbentuk dari pernikahan kembali, di mana salah satu atau kedua pasangan membawa anak dari hubungan sebelumnya, sehingga terbentuk struktur keluarga baru dengan hubungan peran yang kompleks.

11) Dewasa Lajang yang Tinggal Sendiri (*Single Adult*)

Single adult adalah individu dewasa yang hidup sendiri tanpa pasangan dan anak, baik karena pilihan, belum menikah, perceraian, maupun ditinggal pasangan. Secara teori, ini sering disebut sebagai household, tetapi tetap dimasukkan dalam klasifikasi tipe keluarga modern.

12) Keluarga Binuklir

Keluarga binuklir adalah struktur keluarga yang terbentuk setelah perceraian, di mana anak menjadi bagian dari dua unit keluarga inti yang berbeda (keluarga ayah dan keluarga ibu) dan tetap memiliki hubungan dengan keduanya.

b. Non Tradisional (Modern)

Bentuk keluarga nontradisional, yang sering juga disebut sebagai keluarga modern, merupakan manifestasi dari dinamika perubahan sosial yang berkembang seiring dengan transformasi nilai, norma, dan struktur masyarakat. Keluarga dalam bentuk ini dapat terbentuk melalui mekanisme yang diakui secara hukum (legal) maupun yang tidak memiliki legitimasi formal (non-legal), namun tetap berfungsi sebagai unit sosial yang menjalankan peran-peran keluarga pada umumnya.

Terbentuknya keluarga modern dipengaruhi oleh berbagai faktor multidimensional, termasuk kebutuhan individu untuk menjalin kedekatan emosional, berbagi sumber daya, serta membangun interaksi dan relasi sosial yang bermakna. Selain itu, aspek kesepakatan antarindividu menjadi landasan penting dalam pembentukan struktur keluarga ini, yang mencerminkan adanya otonomi dan kebebasan dalam menentukan bentuk kehidupan berkeluarga di luar pola konvensional. Dalam konteks kontemporer, bentuk keluarga nontradisional yang paling umum dijumpai meliputi:

1) *The Unmarried Teenage Mother*

Keluarga yang terdiri dari seorang ibu remaja yang belum menikah dan anaknya, biasanya terbentuk akibat kehamilan di luar pernikahan. Struktur keluarga ini umumnya bersifat *single parent*, dengan dukungan keluarga asal yang bervariasi.

2) *Reconstituted Nuclear*

Keluarga yang terbentuk melalui pernikahan kembali (remarriage), di mana salah satu atau kedua pasangan membawa anak dari hubungan sebelumnya, dan dapat juga memiliki anak dari pernikahan yang baru.

3) *The Step Parent Family*

Keluarga yang terdiri dari orang tua tiri (stepparent), yaitu ketika salah satu pasangan menjadi orang tua bagi anak dari pasangan sebelumnya melalui pernikahan..

4) *Commune Family*

Keluarga yang terdiri dari beberapa individu atau pasangan (tidak harus memiliki hubungan darah) yang hidup bersama dalam satu tempat tinggal, berbagi sumber daya, tanggung jawab, serta pengasuhan anak secara kolektif berdasarkan kesepakatan bersama.

5) *The Nonmarital Heterosexual Cohabiting Family* (Keluarga Heteroseksual)

Keluarga yang terdiri dari pasangan heteroseksual yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, namun menjalani fungsi keluarga seperti pasangan menikah (emosional, ekonomi, dan sosial)..

6) *Gay and Lesbian Families*

Keluarga yang dibentuk oleh pasangan dengan orientasi seksual sesama jenis (homoseksual), baik dengan atau tanpa anak, yang menjalankan fungsi keluarga seperti pasangan pada umumnya.

7) *Cohabiting Family*

Dua orang dewasa yang hidup bersama dalam satu rumah tanpa ikatan pernikahan, dengan hubungan yang biasanya bersifat intim atau menyerupai hubungan pasangan.

8) *Group-Marriage Family*

Keluarga yang terdiri dari lebih dari dua orang dewasa yang hidup bersama dalam hubungan yang menyerupai pernikahan, berbagi tanggung jawab rumah tangga, hubungan intim, serta pengasuhan anak secara kolektif.

9) *Group Network Family*

Sekelompok keluarga inti yang hidup berdekatan dan menjalin hubungan sosial yang erat, berbagi sumber daya, layanan, serta saling mendukung dalam pengasuhan anak dan aktivitas sehari-hari.

10) *Foster Family*

Keluarga yang menerima anak dari luar keluarga biologis untuk dirawat sementara waktu (foster care), biasanya karena orang tua kandung tidak

mampu menjalankan perannya, dengan tujuan anak dapat kembali ke keluarga asal atau mendapatkan penempatan permanen.

11) *Institutional Living*

Individu (anak atau dewasa) yang tinggal dalam institusi seperti panti asuhan, panti jompo, atau lembaga sosial lainnya, karena kehilangan keluarga, keterbatasan dukungan keluarga, atau alasan sosial tertentu.

12) *Homeless Family*

Keluarga yang tidak memiliki tempat tinggal tetap (permanen), sehingga hidup dalam kondisi tidak stabil, sering berpindah-pindah, atau tinggal di tempat penampungan sementara akibat faktor ekonomi, sosial, atau kesehatan mental..

13) *Gang Family*

Kelompok sosial (biasanya remaja atau dewasa muda) yang membentuk ikatan emosional menyerupai keluarga, namun sering berkembang dalam konteks perilaku menyimpang seperti kekerasan dan aktivitas kriminal, sebagai bentuk kompensasi terhadap kurangnya dukungan keluarga asli.

3. Struktur Keluarga

Menurut Friedman (2003), struktur keluarga terbagi menjadi empat bagian yaitu:

a. Pola komunikasi keluarga

Komunikasi dalam keluarga merupakan proses penyampaian pesan secara jelas dan berkualitas serta meminta dan menerima umpan balik. Komunikasi dikatakan berfungsi apabila dilakukan secara jujur, terbuka, melibatkan emosi, ada hirarki kekuatan, dan dikatakan tidak berfungsi apabila tertutup, adanya berita negatif, tidak berfokus pada satu hal. Komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah hubungan, komunikasi yang dibangun akan menentukan kedekatan antara anggota keluarga dan bisa menjadi salah satu tolak ukur kebahagiaan sebuah keluarga. Bagi keluarga dengan pola komunikasi yang tidak berfungsi dapat menimbulkan berbagai persoalan, terutama beban psikologis bagi anggota keluarga.

Tabel. 1.1
Karakteristik Pola Komunikasi Keluarga yang Tidak Berfungsi dan Pola Interaksi Keluarga yang Berfungsi

No	Pola Komunikasi Tertutup dan Tidak Berfungsi	Pola Interaksi yang Berfungsi dalam Keluarga
1	Fokus pembicaraan hanya pada	Komunikasi berlangsung terbuka, jujur, berpikiran positif, dan keluarga berupaya

	satu orang, misalnya hanya pada penentu keputusan.	menyelesaikan konflik bersama.
2	Tidak ada diskusi dalam keluarga, anggota keluarga harus menyetujui keputusan dan tidak dapat menyampaikan pendapatnya.	Setiap anggota keluarga memiliki kesempatan menyampaikan pendapat dan terlibat dalam diskusi keluarga.
3	Hilangnya empati dalam keluarga.	Adanya empati, saling mendengarkan, dan saling memahami antaranggota keluarga.
4	Komunikasi bersifat satu arah dan cenderung pasif.	Komunikasi berkualitas antara pembicara dan pendengar melalui pola stimulus–respons yang baik.
5	Interaksi kurang dinamis dan kurang komunikatif.	Dalam pola komunikasi interaksional, kedua belah pihak sama-sama aktif dan kreatif dalam menyampaikan ide atau gagasan sehingga komunikasi menjadi lebih dinamis dan komunikatif.

b. Struktur peran

Struktur peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan sesuai posisi atau kedudukannya dalam keluarga, misalnya ayah sebagai kepala rumah tangga dan ibu perannya merawat anak. Struktur peran dapat bersifat formal atau informal, misalnya seorang istri diperbolehkan bekerja di luar rumah, maka istri telah menjalankan peran informal, begitu pun sebaliknya jika suami ikut membantu pekerjaan rumah tangga maka suami telah melaksanakan peran informalnya.

Standar peran formal dalam keluarga meliputi ; pencari nafkah, ibu rumah tangga, merawat anak, mengelola keuangan, rekreasi, terapeutik, reproduksi atau seksual. Peran informal bersifat implisit atau tidak tampak berkaitan dengan kebutuhan emosional seperti membina keharmonisan, motivasi, inisiasi dan lain sebagainya.

c. Struktur kekuatan dan struktur nilai

Struktur kekuatan adalah kemampuan individu untuk mengontrol, mempengaruhi atau mengubah perilaku orang lain, meliputi hak (*Legitimate power*), ditiru (*Referent power*), keahlian (*Expert power*), hadiah (*Reward power*), paksaan (*Coercive power*), dan *effektif power*. Struktur kekuatan keluarga menggambarkan adanya kekuasaan atau kekuatan dalam sebuah keluarga yang digunakan untuk mengendalikan dan mempengaruhi anggota keluarga. Kekuasaan ini terdapat pada individu di dalam keluarga untuk

mengubah perilaku anggotanya ke arah positif, baik dari sisi perilaku maupun kesehatan.

Ketika seseorang memiliki kekuatan, maka ia sesungguhnya mampu mengendalikan sebuah interaksi. Kekuatan ini dapat dibangun dengan berbagai cara. Selain itu, ada beberapa faktor yang mendasari terjadinya struktur kekuatan keluarga.

1) *Legitimate power*

Dalam konteks keluarga, kekuatan ini sebenarnya tumbuh dengan sendirinya karena ada hierarki yang merupakan konstruksi masyarakat. Seorang kepala keluarga adalah memegang kekuatan interaksi dalam keluarga. Ia memiliki hak untuk mengontrol tingkah laku anggota keluarga lainnya, terutama pada anak-anak.

2) *Referent power*

Di masyarakat pada umumnya, orangtua adalah panutan utama dalam keluarga, terlebih posisi ayah sebagai kepala keluarga. Apa yang dilakukan ayah akan menjadi contoh, baik oleh pasangannya maupun anak-anaknya. Friedman menunjukkan bahwa kekuatan tidak harus ditunjukkan secara fisik, melainkan juga dengan teladan. Misalnya untuk mengajari anak melaksanakan ibadah, tidak perlu dengan kemarahan, dengan cara orangtua senantiasa beribadah anak akan mengikuti dengan sendirinya. Anak akan belajar dari apa yang dilihatnya.

3) *Reward power*

Kekuatan penghargaan berasal dari adanya harapan bahwa orang yang berpengaruh dan dominan akan melakukan sesuatu yang positif terhadap ketaatan seseorang (Friedman, 1988). Imbalan menjadi hal penting dan dapat memberikan pengaruh kekuatan dalam keluarga. Hal ini tentu sering terjadi di masyarakat, misalnya orang tua menjanjikan hadiah untuk anaknya jika berhasil meraih nilai terbaik di sekolah.

Dengan hadiah tersebut, anak akan berusaha untuk menjadi yang terbaik agar dapat mencapai keinginannya untuk mendapatkan hadiah tersebut. Cara tersebut memang ampuh dalam memotivasi anak, akan tetapi jika anak gagal, sebaiknya anak tetap diberi hadiah tapi di bawah standar yang dijanjikan, sebagai bentuk penghargaan terhadap usaha anak meski belum berhasil.

4) *Coercive power*

Unsur lain kekuatan dalam keluarga yaitu ancaman dan hukuman yang menjadi pokok dalam membangun kekuatan keluarga. Friedman (1988)

mendefinisikan kekuatan ini sebagai kekuasaan dominasi atau paksaan yang mampu untuk menghukum bila tidak taat. Sebagian orangtua tidak menggunakan kekuasaan ini, namun sebagian lainnya sangat membutuhkan karena merasa putus asa dalam mendidik anak.

Setiap anak memiliki karakter unik dan berbeda-beda, oleh karena itu pola asuh terhadap anak harus disesuaikan dengan karakter masing-masing anak, tidak bisa disamaratakan. Orangtua memilih pola asuh tertentu atas berbagai pertimbangan yang membuat anak menjadi lebih positif.

d. Nilai-nilai atau norma

Nilai merupakan suatu sistem, sikap dan kepercayaan atau keyakinan yang dapat menjadi pedoman bagi perkembangan norma dan aturan dan dapat mempersatukan keluarga dalam suatu budaya. Norma adalah pola perilaku yang baik menurut masyarakat yang dapat diterima pada lingkungan sosial berdasarkan system nilai yang berlaku. Nilai-nilai dianut bersama dalam masyarakat meski tidak tertulis Nilai-nilai dalam keluarga tidak hanya dibentuk oleh keluarga itu sendiri melainkan juga merupakan warisan dari keluarga dari pihak suami atau istri dan garis keturunan sebelumnya dan terus berkembang.

4. Struktur keluarga berdasarkan dimensi budaya :

a. Berdasarkan dominasi jalur hubungan darah :

1) *Patrilineal*

2) Struktur keluarga yang dibangun melalui hubungan sedarah pada jalur garis ayah. Suku-suku di Indonesia rata-rata menggunakan struktur keluarga patrilineal.

3) *Matrilineal*

Keluarga yang dihubungkan atau disusun melalui jalur garis ibu. Suku Padang merupakan salah satu suku yang menggunakan struktur keluarga *matrilineal*.

b. Berdasarkan keberadaan tempat tinggal

1) *Patrilokal*

Struktur keluarga yang dibangun berdasarkan keberadaan tempat tinggal keluarga yang tinggal dengan keluarga sedarah dari pihak suami.

2) *Matrilokal*

Struktur keluarga yang dibangun berdasarkan keberadaan tempat tinggal keluarga yang tinggal dengan keluarga sedarah dari pihak istri

c. Berdasarkan dominasi pengambilan Keputusan

1) Patriakal

Struktur keluarga yang dibangun berdasarkan pengambilan keputusan dalam keluarga dengan dominasi pengambil keputusan berada pada pihak suami.

2) Matriakal

Struktur keluarga yang dibangun berdasarkan pengambilan keputusan dalam keluarga dengan dominasi pengambil keputusan berada pada pihak istri.

5. Fungsi dan peran keluarga

Fungsi dan peran keluarga merupakan hal penting yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh setiap anggotanya. Jika salah satu anggota keluarga terkendala, dalam melaksanakan peran dan fungsinya maka tujuan keluarga akan terhambat. Aspek fungsional keluarga merupakan pembentuk ikatan keluarga yang intim, interaktif dan saling ketergantungan yang memiliki nilai-nilai, tujuan, sumber tanggung jawab, dan keputusan sepanjang waktu (Steinmetz, Clavan, & Stein, 1990).

Menurut Friedman (1998) fungsi pokok keluarga dikelompokkan dalam lima poin yaitu fungsi reproduktif, sosialisasi, afektif, ekonomi, dan perawatan kesehatan.

a. Fungsi reproduktif

Fungsi reproduksi berkaitan dengan hubungan suami istri dan pola reproduksi memiliki keturunan untuk mempertahankan generasi penerus keluarga, budaya dan menjaga kelangsungan sebuah keluarga.

b. Fungsi sosial

Fungsi yang mengembangkan dan melatih anak untuk hidup bersosial, menanamkan nilai-nilai, norma, sikap dan perilaku dalam berhubungan dengan orang lain.

c. Fungsi afektif

Keluarga berfungsi memberikan kasih sayang, perhatian, rasa nyaman, membantu anggota keluarga untuk belajar saling menghormati dan menggunakan koping pada saat menghadapi konflik atau stress. Fungsi ini dapat membentuk karakteristik atau identitas keluarga, dan membentuk perkembangan psikologis anggota keluarga. Maka komponen yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi afektif yaitu saling mendukung, menghormati, saling asuh, menciptakan kehangatan dan menjalin hubungan yang dekat antara anggota keluarga.

d. Fungsi ekonomi

Keluarga memberikan finansial dan memenuhi kebutuhan anggota keluarga seperti makanan, pakaian, rumah tempat tinggal. Kemampuan keluarga untuk memperoleh penghasilan yang baik dan mengelola dengan bijak merupakan faktor penting untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi. Penghasilan keluarga diperoleh dari ayah, ibu atau anak yang bekerja.

e. Fungsi perawatan/pemeliharaan kesehatan

Keluarga merupakan unit utama dalam menciptakan perilaku sehat dan melakukan pemeliharaan serta perawatan kesehatan bagi anggota keluarga, fungsi perawatan kesehatan dalam keluarga bersifat preventif dalam melakukan perawatan pada anggota keluarga yang sakit. Terdapat lima tugas Kesehatan keluarga yang saling berkaitan dan perlu dilakukan pengkajian oleh perawat untuk mengetahui sejauh mana keluarga mampu melaksanakan tugas tersebut sehingga perawat dapat memberikan pembinaan terhadap keluarga. Keluarga harus mampu melakukan tugas kesehatan sebagai berikut :

1) Mengenal masalah kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan utama, oleh karena itu Keluarga harus mampu mengenal keadaan kesehatan dan menyadari perubahan yang dialami anggota keluarga.

2) Mengambil keputusan yang tepat

Sebagai bentuk upaya keluarga dalam mencari tindakan untuk mengatasi masalah kesehatan yang dirasakan berupa perubahan kesehatan yang terjadi pada anggota keluarga. Keluarga diharapkan mampu menentukan tindakan kesehatan yang tepat sehingga dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh keluarga.

3) Merawat anggota keluarga yang sakit

Pada saat anggota keluarga mengalami gangguan kesehatan maka keluarga harus segera memberikan perawatan atau melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan atau masalah kesehatan yang terjadi agar tidak terjadi dampak lebih lanjut dari masalah yang terjadi. Jika masalah kesehatan yang terjadi masih dalam tahap ringan, keluarga dapat memberikan tindakan pertolongan pertama di rumah, dan jika keluarga merasa tidak mampu mengatasi masalah di rumah maka perawatan dapat dilakukan di tempat pelayanan Kesehatan.

4) Menciptakan lingkungan rumah yang sehat

Rumah merupakan tempat tinggal anggota keluarga, harus dapat menunjang kesehatan keluarga dengan keadaan yang bersih, pencahayaan sinar matahari dan udara yang cukup baik, tenang dan nyaman terbebas dari faktor-faktor yang dapat menimbulkan penyakit baik fisik maupun psikologis.

5) Memanfaatkan pelayanan Kesehatan

Ketika anggota keluarga mengalami masalah kesehatan, keluarga dapat berkonsultasi dan meminta pertolongan dengan tenaga Kesehatan serta dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada disekitarnya sehingga keluarga dapat mengatasi masalah kesehatan yang terjadi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994, BKKR (1992) menambahkan beberapa fungsi keluarga, disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihadapi masyarakat Indonesia, yaitu fungsi pendidikan, fungsi budaya, fungsi agama, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, dan fungsi pelestarian lingkungan.

1) Fungsi Pendidikan

Keluarga memiliki kewajiban mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Maka sejak dini, anak sudah harus dikenalkan dengan berbagai pendidik positif demi membentuk perilaku dan karakter. Dalam hal ini, pendidikan keluarga harus didukung dengan memberikan pengalaman. Dengan demikian, anak akan memiliki pengetahuan, keterampilan dan membentuk perilaku anak sesuai bakat dan minat yang dimilikinya.

2) Fungsi budaya

Setiap wilayah, memiliki tradisi atau budaya yang dipegang oleh masyarakatnya. Maka tugas keluarga adalah memberikan pemahaman kepada anggota keluarga, untuk dapat memahami budaya di sekitarnya. Selain memberikan pemahaman, keluarga juga bertugas untuk menyaring budaya baru atau luar yang masuk. Oleh sebab itu, keluarga harus dapat menjelaskan dan mendiskusikan kepada anggota keluarga, terutama anak, supaya tidak terjerumus pada budaya yang tidak baik atau tidak diinginkan.

3) Fungsi agama

Masyarakat kita, dilihat dari dasar negara, adalah masyarakat yang memegang teguh ajaran-ajaran agama. Oleh sebab itu, keluarga memiliki fungsi untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak mereka

mengenai nilai-nilai agama yang dianutnya. Tidak hanya sebatas pemahaman konsep keagamaan, melainkan juga harus memberikan praktik secara langsung, yang dapat diteladani oleh anak.

4) Fungsi cinta kasih

Keluarga berfungsi untuk memberikan pembelajaran kepada anggota keluarganya akan arti cinta kasih. Terutama adalah orangtua yang harus memberikan contoh bagaimana sikap saling menyayangi, menghargai, mengasihi, dan mencintai sehingga tumbuh perasaan nyaman berada di rumah. Penerapan fungsi ini juga penting sebagai bekal mengasah perasaan cinta kasih anggota keluarga di luar rumah.

5) Fungsi perlindungan

Fungsi ini menegaskan bahwa keluarga merupakan tempat berlindung, yang dapat memberikan rasa aman, dan keluarga bisa hidup nyaman, baik di dalam maupun di luar rumah, baik fisik maupun psikis.

6) Fungsi pelestarian lingkungan

Fungsi keluarga dalam melestarikan lingkungan adalah membangun kesadaran, sikap dan perilaku anggota keluarga untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan dapat menunjang kesehatan.

6. Tahapan & Tugas Perkembangan Keluarga

Perkembangan keluarga adalah proses perubahan yang terjadi pada sistem keluarga meliputi perubahan pola interaksi dan hubungan antar anggotanya di sepanjang waktu. Perkembangan ini terbagi menjadi beberapa tahap atau kurun waktu tertentu. Pada setiap tahapnya, keluarga memiliki tugas perkembangan yang harus dipenuhi agar tahap perkembangan tersebut dapat tercapai.

Dalam memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas maka perawat perlu melakukan pengkajian secara lengkap dan komprehensif, pengkajian yang dilakukan juga harus memperhatikan setiap tingkat perkembangan keluarga berikut tugas-tugas perkembangannya.

Tiap tahap perkembangan membutuhkan tugas atau fungsi keluarga agar dapat melalui tahap tersebut dengan sukses. Setiap individu mempunyai tugas-tugas perkembangan yang harus mereka capai agar mereka merasa puas selama tahap perkembangan dan agar mereka mampu beralih ke tahap berikutnya dengan berhasil. Setiap tahap perkembangan keluarga mempunyai tugas-tugas perkembangan yang spesifik. Tahap-tahap perkembangan keluarga:

a. Pasangan Baru (*Begining Family*)

Tahap perkembangan keluarga dengan pasangan yang baru menikah. Dua orang yang membentuk keluarga perlu mempersiapkan kehidupan keluarga yang baru karena keduanya membutuhkan penyesuaian peran dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Masing-masing belajar hidup bersama serta beradaptasi dengan kebiasaan sendiri dan pasangannya. Beberapa masalah yang dapat terjadi pada tahap ini diantaranya adalah; Penyesuaian seksual dan peran perkawinan, penyuluhan dan konseling keluarga berencana, penyuluhan dan konseling prenatal dan komunikasi.

Kurangnya informasi seringkali mengakibatkan masalah-masalah seksual dan emosional, ketakutan, rasa bersalah, kehamilan yang tidak direncanakan, dan penyakit-penyakit kehamilan sebelum ataupun sesudah perkawinan. Kejadian-kejadian yang kurang menyenangkan ini menghambat pasangan tersebut dalam merencanakan kehidupan mereka.

Tugas perkembangan pada pasangan baru:

- 1) Menciptakan sebuah perkawinan yang saling memuaskan.
- 2) Pada saat dua orang diikat dalam ikatan pernikahan, perhatian awal mereka adalah menyiapkan suatu kehidupan bersama yang baru. Sumber-sumber dari dua orang digabungkan, peran-peran mereka berubah. Pasangan harus saling menyesuaikan diri terhadap banyak hal kecil yang bersifat rutinitas.
- 3) Menghubungkan jaringan persaudaraan secara harmonis, membina hubungan dengan keluarga pasangan, mertua, saudara ipar, dan lain-lain. Perubahan peran dasar terjadi dalam perkawinan pertama dari sebuah pasangan yaitu menjadi anggota keluarga dari keluarga asal masing-masing, pada saat yang sama keluarga mereka sendiri baru saja terbentuk.
- 4) Mendiskusikan rencana memiliki anak (menjadi orang tua)
- 5) Keinginan untuk memiliki anak dan penentuan waktu untuk hamil merupakan suatu keputusan keluarga yang sangat penting. Littlefield (1977) dalam Friedman (2003) menekankan pentingnya pertimbangan semua rencana kehamilan keluarga.

b. Tahap II: Keluarga "*Child-Bearing*" (Kelahiran Anak Pertama)

Tahap keluarga "*Child-Bearing*" merupakan tahap perkembangan keluarga yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak pertama berusia sekitar 30 bulan (2,5 tahun). Pada fase ini, pasangan suami-istri mengalami transisi besar dari peran sebagai pasangan menjadi orang tua. Menurut konsep perkembangan keluarga dari Evelyn Millis Duvall, tahap ini sering menjadi

fase kritis karena terjadi perubahan biologis, psikologis, sosial, ekonomi, dan spiritual dalam keluarga.

Masalah yang Terjadi pada Tahap Ini : Suami merasa diabaikan oleh sang istri. Kelahiran bayi pertama memberi perubahan yang besar dalam keluarga sehingga pasangan harus beradaptasi dengan perannya untuk memenuhi kebutuhan bayi. Masalah kedua adalah sering terjadi peningkatan perselisihan dan argumen antara suami dan istri serta terjadinya interupsi dalam jadwal yang kontinyu (begitu lelah sepanjang waktu).

Peran utama perawat keluarga adalah mengkaji peran orang tua; bagaimana orang tua berinteraksi dan merawat bayi serta bagaimana bayi merespons. Perawat perlu memfasilitasi hubungan orang tua dan bayi yang positif dan hangat sehingga jalinan kasih sayang antara bayi dan orang tua dapat tercapai.

Tugas keluarga pada tahap ini adalah:

1) Persiapan Menjadi Orang Tua

Pasangan harus mempersiapkan diri secara fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi untuk menerima kehadiran anak.

Bentuk tugas:

- a) Memahami proses kehamilan dan persalinan
- b) Menyiapkan mental menjadi ayah dan ibu
- c) Mempersiapkan kebutuhan bayi
- d) Menata lingkungan rumah yang aman bagi bayi
- e) Menyiapkan biaya persalinan dan kebutuhan anak

2) Adaptasi terhadap Perubahan Peran dalam Keluarga

Tahap ini menuntut pasangan untuk menyesuaikan diri dengan peran baru sebagai orang tua.

Bentuk adaptasi:

- a) Ibu mulai menjalankan peran pengasuhan
- b) Ayah mulai berperan sebagai pelindung dan pendukung keluarga
- c) Penyesuaian jadwal aktivitas keluarga
- d) Pembagian tugas rumah tangga

3) Mempertahankan Hubungan Suami-Istri yang Harmonis

Walaupun perhatian banyak tertuju pada bayi, hubungan pasangan tetap harus dipelihara.

Tugas yang dilakukan:

- a) Menjaga komunikasi terbuka
- b) Saling memberi dukungan emosional

- c) Menghargai perubahan fisik dan psikologis pasangan
- d) Menyesuaikan hubungan seksual pascapersalinan
- 4) Membagi Peran dan Tanggung Jawab Pengasuhan Anak
 Keluarga harus mulai membentuk pola pengasuhan yang efektif.
 Bentuk tugas:
 - a) Menentukan siapa yang merawat bayi
 - b) Membagi tugas menyusui, memandikan, dan menjaga bayi
 - c) Mengembangkan kerja sama dalam pengasuhan
- 5) Memenuhi Kebutuhan Dasar Bayi
 Keluarga harus mampu memenuhi kebutuhan biologis dan emosional bayi.
 Kebutuhan yang harus dipenuhi:
 - a) Kebutuhan fisik; Nutrisi/ASI, Kebersihan, Imunisasi , Tidur dan kenyamanan
 - b) Kebutuhan emosional; Kasih sayang, Sentuhan, Respons terhadap tangisan bayi
 - c) Kebutuhan stimulasi; Interaksi verbal, Kontak mata, Bermain sederhana
- 6) Memantau Pertumbuhan dan Perkembangan Anak
 Orang tua mulai belajar mengenali proses tumbuh kembang bayi.
 Bentuk tugas:
 - a) Memantau berat badan dan tinggi badan
 - b) Mengikuti imunisasi
 - c) Mengenali milestone perkembangan
 - d) Mendeteksi tanda gangguan kesehatan
- 7) Menyesuaikan Kondisi Ekonomi Keluarga
 Kelahiran anak menyebabkan peningkatan kebutuhan finansial.
 Bentuk penyesuaian:
 - a) Mengatur pengeluaran keluarga
 - b) Menyiapkan dana kesehatan
 - c) Menentukan prioritas kebutuhan
- 8) Mengembangkan Pola Asuh dan Nilai Keluarga
 Pada tahap ini keluarga mulai membentuk pola pendidikan anak.
 Bentuk tugas:
 - a) Menanamkan nilai agama dan moral
 - b) Membentuk kebiasaan positif
 - c) Menentukan pola disiplin anak
- 9) Menjaga Kesehatan Ibu Pascapersalinan

Kesehatan ibu menjadi bagian penting dalam keberhasilan adaptasi keluarga.

Bentuk perhatian:

- a) Perawatan masa nifas
- b) Dukungan menyusui
- c) Pencegahan depresi postpartum
- d) Istirahat cukup

c. Tahap III: Keluarga dengan Anak Prasekolah

Tahap ini dimulai saat kelahiran anak pertama berusia 2,5 tahun dan berakhir saat anak berusia 5 tahun. Pada tahap ini, keluarga tumbuh dengan baik dalam jumlah serta kompleksitas fungsi dan permasalahannya. Penambahan jumlah anggota keluarga dapat memicu timbulnya perubahan peran, ketegangan peran, serta konflik peran antara suami dan istri akibat bertambahnya peran, tugas, atau karena ketidaktahuan dalam menjalankan tugas sehingga dapat mengancam stabilitas perkawinan, (Friedman, 2010).

Kehidupan keluarga pada tahap ini sangat sibuk dan anak sangat bergantung pada orang tua. Kedua orang tua harus mengatur waktunya sedemikian rupa sehingga kebutuhan anak, suami istri dan pekerjaan (purna waktu/paruh waktu) dapat terpenuhi. Orang tua mempunyai peran untuk menstimulasi perkembangan individual anak, khususnya kemandirian anak agar tugas perkembangan anak pada fase ini tercapai.

Tugas Keluarga pada tahap ini adalah:

1) Mempertahankan Pernikahan yang Stabil

Pada tahap ini pasangan suami istri harus tetap menjaga hubungan pernikahan agar harmonis meskipun perhatian dan waktu banyak terfokus pada anak. Kehadiran anak prasekolah sering menyebabkan perubahan peran, kelelahan, serta meningkatnya tuntutan rumah tangga sehingga hubungan pasangan perlu dipelihara dengan baik.

Hal yang dilakukan keluarga antara lain:

- a) Menjaga komunikasi terbuka antara suami dan istri,
- b) Saling mendukung dalam pengasuhan anak,
- c) Menghargai peran masing-masing pasangan,
- d) Menyelesaikan konflik secara sehat,
- e) Tetap menyediakan waktu bersama pasangan.

2) Membuat Keputusan Pekerjaan dan Pengasuhan

Keluarga perlu menentukan pembagian peran antara pekerjaan dan pengasuhan anak. Pada masa ini orang tua mulai menghadapi tantangan dalam mengatur waktu, tenaga, dan tanggung jawab. Keluarga perlu:

- a) Menentukan siapa yang lebih banyak mendampingi anak,
- b) Mengatur jadwal kerja agar kebutuhan anak tetap terpenuhi,
- c) Memilih pola pengasuhan yang sesuai,
- d) Menentukan tempat penitipan atau pendidikan anak,
- e) Bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan emosional keluarga.

3) Menyesuaikan Diri dengan Kebutuhan Anak Prasekolah

Anak usia prasekolah mengalami perkembangan pesat dalam aspek fisik, motorik, bahasa, sosial, emosional, dan kognitif. Oleh karena itu keluarga harus mampu menyesuaikan pola pengasuhan sesuai kebutuhan perkembangan anak. Penyesuaian tersebut meliputi:

- a) Menyediakan makanan bergizi,
- b) Memberikan waktu bermain,
- c) Mendukung proses belajar,
- d) Melatih kemandirian anak,
- e) Memberikan pengawasan yang sesuai usia,
- f) Memahami perubahan perilaku anak.

4) Memberikan Kesempatan Berkembang pada Kepribadian Anak

Keluarga berperan penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Anak prasekolah mulai belajar mengenal diri, mengekspresikan emosi, dan membangun rasa percaya diri. Keluarga perlu:

- a) Memberi kesempatan anak mencoba hal baru,
- b) Menghargai pendapat dan perasaan anak,
- c) Memberikan pujian dan dukungan,
- d) Membantu anak belajar mandiri,
- e) Mengajarkan nilai moral dan sosial,
- f) Menghindari pola asuh yang terlalu keras atau terlalu mengekang.

5) Menjaga Komunikasi dan Keintiman Pasangan

Walaupun perhatian orang tua banyak tertuju pada anak, hubungan emosional pasangan tetap perlu dijaga. Kurangnya komunikasi dapat menyebabkan konflik dan menurunkan kualitas hubungan keluarga.

Upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- a) Meluangkan waktu berbicara bersama,
- b) Saling mendengarkan keluhan dan kebutuhan pasangan,

- c) Mempertahankan kedekatan emosional,
 - d) Bekerja sama dalam pengambilan keputusan keluarga,
 - e) Memberikan dukungan psikologis satu sama lain.
- 6) Menyediakan Lingkungan Rumah yang Aman dan Mendukung Perkembangan Anak
- Rumah menjadi tempat utama anak belajar dan berkembang. Oleh karena itu keluarga harus menciptakan lingkungan yang aman secara fisik maupun psikologis. Lingkungan yang mendukung meliputi:
- a) Rumah yang bersih dan aman dari bahaya,
 - b) Suasana keluarga yang penuh kasih sayang,
 - c) Adanya aturan yang jelas,
 - d) Tersedianya ruang bermain dan belajar,
 - e) Hubungan keluarga yang hangat,
 - f) Lingkungan yang mendukung perkembangan kreativitas dan sosialisasi anak.

d. Tahap IV: Keluarga dengan Anak Sekolah

Tahap ini dimulai saat anak masuk sekolah pada usia enam tahun dan berakhir pada usia 12 tahun. Pada fase ini, umumnya keluarga mencapai jumlah anggota keluarga maksimal sehingga keluarga sangat sibuk. Selain aktivitas di sekolah, masing-masing anak memiliki aktivitas dan minat sendiri. Pada tahap ini, orang tua perlu belajar berpisah dengan anak, memberi kesempatan kepada anak untuk bersosialisasi, baik aktivitas di sekolah maupun di luar sekolah.

1) Membantu Sosialisasi Anak

Keluarga memiliki tugas membantu anak beradaptasi dan bersosialisasi dengan lingkungan yang lebih luas, seperti sekolah, tetangga, teman sebaya, organisasi, dan masyarakat. Pada tahap ini anak mulai belajar hidup tidak hanya bergantung pada keluarga, tetapi juga belajar menjadi bagian dari lingkungan sosialnya.

Orang tua perlu mengajarkan:

- a) Cara berinteraksi yang baik,
- b) Kerja sama, disiplin, tanggung jawab, sopan santun,
- c) Kemampuan mengikuti aturan sosial, serta
- d) Membangun hubungan pertemanan yang sehat.

2) Mendukung dan Meningkatkan Prestasi Sekolah Anak

Keluarga bertanggung jawab menciptakan suasana belajar yang mendukung perkembangan akademik anak.

Bentuk tugas ini meliputi:

- a) Menyediakan fasilitas belajar,
- b) Membimbing kegiatan sekolah,
- c) Memotivasi anak untuk belajar,
- d) Memantau perkembangan pendidikan,
- e) Membantu anak mengembangkan keterampilan membaca, menulis, dan berhitung, serta
- f) Memberikan penghargaan terhadap pencapaian anak.
- g) Orang tua juga perlu menjalin komunikasi yang baik dengan pihak sekolah demi mendukung perkembangan anak secara optimal.

3) Mengembangkan Hubungan dengan Teman Sebaya yang Sehat

Pada usia sekolah, hubungan dengan teman sebaya mulai memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan anak. Namun demikian keluarga tetap menjadi tempat utama pembentukan karakter meskipun anak mulai banyak berinteraksi di luar rumah.

Oleh karena itu keluarga memiliki tugas:

- a) Anak memilih lingkungan pertemanan yang baik,
- b) Mengajarkan nilai moral dan etika,
- c) Melatih kemampuan bekerja sama,
- d) Membantu anak belajar menyelesaikan konflik,
- e) Serta membangun rasa percaya diri dalam hubungan sosial.

4) Mempertahankan Hubungan Perkawinan yang Harmonis

Di tengah meningkatnya aktivitas dan kesibukan keluarga, pasangan suami istri tetap memiliki tugas mempertahankan hubungan yang harmonis dan memuaskan. Hal ini dilakukan melalui: komunikasi yang baik, pembagian peran yang seimbang, saling mendukung, pengambilan keputusan bersama, dan menjaga kedekatan emosional antar pasangan. Keharmonisan orang tua sangat berpengaruh terhadap rasa aman dan stabilitas emosional anak usia sekolah.

5) Memenuhi Kebutuhan Ekonomi dan Kehidupan Keluarga yang Semakin Meningkat

Pada tahap ini kebutuhan keluarga meningkat, terutama terkait: biaya pendidikan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan aktivitas sekolah, nutrisi, pakaian, transportasi, dan kegiatan pengembangan anak.

Karena itu keluarga perlu mengelola keuangan secara efektif agar seluruh kebutuhan anggota keluarga dapat terpenuhi dengan baik.

6) Memenuhi dan Memelihara Kesehatan Anggota Keluarga

Keluarga memiliki tanggung jawab menjaga kesehatan fisik dan psikologis seluruh anggota keluarga, terutama anak usia sekolah. Kesehatan yang baik akan mendukung proses belajar dan perkembangan sosial anak.

Tugas ini meliputi:

- a) Memenuhi kebutuhan nutrisi,
- b) Menjaga kebersihan diri dan lingkungan,
- c) Memberikan imunisasi dan pelayanan kesehatan,
- d) Membentuk kebiasaan hidup sehat,
- e) Mengatur aktivitas dan istirahat anak,
- f) Serta memantau pertumbuhan dan perkembangan anak.

7) Memberikan Kesempatan Anak untuk Mandiri

Orang tua mulai belajar memberikan kebebasan secara bertahap sambil tetap melakukan pengawasan dan bimbingan. Keluarga perlu mulai memberi kesempatan kepada anak untuk belajar mandiri sesuai tahap perkembangannya, seperti:

- a) Bertanggung jawab terhadap tugas sekolah,
- b) Mengatur perlengkapan pribadi,
- c) Membantu pekerjaan rumah sederhana,
- d) Mengambil keputusan sederhana,
- e) Dan menyelesaikan masalah ringan secara mandiri.

e. Tahap V: Keluarga dengan Anak Remaja

Periode remaja dianggap penting karena terjadi perubahan fisik yang diikuti dengan perkembangan mental yang cepat. Tak jarang, perkembangan mental pada remaja yang merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa menimbulkan dampak negatif pada mental anak remaja sehingga diperlukan penyesuaian mental dan pembentukan sikap, nilai, dan minat baru. Tahap ini dimulai saat anak pertama berusia 13 tahun dan berakhir dengan 6-7 tahun kemudian, yaitu pada saat anak meninggalkan rumah orang tuanya.

Tujuan keluarga ini adalah melepas anak remaja dan memberi tanggung jawab pada tahap-tahap sebelumnya. Pada tahap ini, ini merupakan tahapan yang paling sulit karena orang tua melepas otoritanya dan membimbing anak untuk bertanggung jawab (mempunyai otoritas terhadap dirinya sendiri yang berkaitan dengan peran dan fungsinya).

Seringkali muncul konflik antara orang tua dan remaja karena anak menginginkan kebebasan untuk melakukan aktivitasnya sementara orang tua mempunyai hak untuk mengontrol aktivitas anak. Dalam hal ini, orang

tua perlu menciptakan komunikasi yang terbuka, menghindari kecurigaan, dan permusuhan sehingga hubungan orang tua dan remaja tetap harmonis. Berikut tugas-tugas perkembangan keluarga dengan anak remaja yang relevan untuk konsep keperawatan keluarga dan teori perkembangan keluarga:

1) Menyeimbangkan Kebebasan dan Tanggung Jawab Remaja

Keluarga perlu memberikan kesempatan kepada remaja untuk belajar mandiri, mengambil keputusan, serta mengembangkan identitas diri, namun tetap disertai pengawasan dan tanggung jawab yang sesuai dengan usia perkembangan. Orang tua mulai mengurangi kontrol yang terlalu ketat dan beralih menjadi pembimbing.

Tugas ini mencakup:

- a) Memberikan kepercayaan secara bertahap kepada remaja.
- b) Membantu remaja belajar bertanggung jawab terhadap perilaku dan keputusan.
- c) Mengembangkan disiplin yang fleksibel dan demokratis.
- d) Mendukung perkembangan identitas dan kemandirian remaja.

2) Mempertahankan Hubungan Pernikahan yang Harmonis

Pada tahap ini orang tua tidak hanya berfokus pada anak, tetapi juga perlu mempertahankan kualitas hubungan suami istri. Keluarga perlu menyesuaikan kembali peran dan fungsi pasangan seiring meningkatnya kemandirian anak remaja. Adapun tugas keluarga pada tahapan ini adalah:

- a) Mempertahankan komunikasi yang sehat antar pasangan.
- b) Menyesuaikan pola pengasuhan secara bersama.
- c) Menjaga keharmonisan dan stabilitas keluarga.
- d) Mengembangkan kembali hubungan emosional pasangan.

3) Mengembangkan Komunikasi Terbuka antara Orang Tua dan Remaja

Keluarga perlu menciptakan pola komunikasi dua arah yang terbuka, suportif, dan saling menghargai agar remaja merasa diterima serta mampu mengekspresikan pikiran dan perasaannya dengan aman. Adapun tugas keluarga pada tahapan ini adalah:

- a) Mendengarkan pendapat remaja secara aktif.
- b) Menghargai privasi dan pandangan remaja.
- c) Mengurangi komunikasi otoriter.
- d) Mendorong diskusi keluarga secara terbuka.

4) Membantu Remaja Membentuk Identitas Diri

Keluarga berperan mendukung perkembangan konsep diri, nilai, moral, tujuan hidup, serta peran sosial remaja agar terbentuk identitas yang positif. Bentuk pelaksanaannya antara lain:

- a) Memberikan dukungan emosional.
 - b) Membantu remaja mengenali potensi diri.
 - c) Membimbing dalam pengambilan keputusan.
 - d) Menanamkan nilai dan norma keluarga.
- 5) Menyesuaikan Perubahan Hubungan Antar Generasi
- Perubahan perkembangan remaja menyebabkan pola hubungan dalam keluarga ikut berubah. Orang tua perlu menyesuaikan diri dari pola hubungan yang bersifat mengendalikan menjadi lebih kolaboratif dan suportif. Penyesuaian ini meliputi:
- a) Mengubah pola pengawasan menjadi pendampingan.
 - b) Memberikan ruang diskusi dan negosiasi.
 - c) Menghormati perkembangan otonomi remaja.
 - d) Tetap mempertahankan batasan dan nilai keluarga.
- 6) Mendukung Pengembangan Hubungan Sosial Remaja
- Keluarga memiliki tugas membantu remaja mengembangkan hubungan sosial yang sehat dengan teman sebaya, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Pelaksanaannya meliputi:
- a) Mendukung aktivitas sosial dan pendidikan remaja.
 - b) Mengawasi lingkungan pergaulan secara positif.
 - c) Menanamkan kemampuan bersosialisasi yang sehat.
 - d) Membimbing remaja dalam menjalankan peran sosialnya.
- 7) Mempersiapkan Remaja Menuju Kehidupan Dewasa
- Keluarga mulai membantu remaja mempersiapkan masa depan, baik dalam pendidikan, pekerjaan, nilai kehidupan, maupun tanggung jawab sebagai individu dewasa. Tugas ini mencakup:
- a) Memberikan dukungan terhadap pendidikan dan cita-cita.
 - b) Melatih keterampilan hidup (life skills).
 - c) Mengembangkan kemampuan pengambilan keputusan.
 - d) Membina tanggung jawab pribadi dan sosial
- f. Tahap VI: Keluarga dengan Anak Dewasa (Pelepasan)
- Tahap ini dimulai pada saat terakhir kali meninggalkan rumah dan berakhir pada saat anak terakhir kali meninggalkan rumah. Lamanya tahap ini bergantung pada jumlah anak dalam keluarga atau jika anak yang belum berkeluarga dan tetap tinggal bersama orang tua. Tujuan utama tahap ini

adalah mengorganisasi kembali keluarga untuk tetap berperan melepas anak untuk hidup sendiri. Keluarga mempersiapkan anaknya yang tertua untuk membentuk keluarga sendiri dan tetap membantu anak terakhir untuk lebih mandiri.

Pada saat semua anak meninggalkan rumah, pasangan perlu menata ulang dan membina hubungan suami istri seperti fase awal. Orang tua akan merasa kehilangan peran dalam merawat anak dan merasa "kosong" karena anak-anak sudah tidak tinggal serumah lagi. Untuk mengatasi keadaan ini, orang tua perlu melakukan aktivitas kerja, meningkatkan peran sebagai pasangan, dan tetap memelihara hubungan dengan baik.

Menurut konsep perkembangan keluarga dari Duvall dan Miller, terdapat beberapa tugas perkembangan utama yang harus dijalankan keluarga pada tahapan ini, yaitu:

1) Membantu Anak Menjadi Mandiri

Keluarga bertugas membantu anak dewasa mencapai kemandirian secara emosional, sosial, ekonomi, dan pengambilan keputusan. Orang tua memberikan dukungan, arahan, serta kesempatan kepada anak untuk menjalankan peran dewasa dalam masyarakat.

2) Menerima Proses Pelepasan Anak dari Rumah

Keluarga perlu menerima bahwa anak mulai membangun kehidupannya sendiri di luar rumah. Proses pelepasan ini mencakup kesiapan orang tua dalam mengurangi ketergantungan emosional dan memberikan ruang bagi anak untuk berkembang sebagai individu dewasa.

3) Mempertahankan Hubungan Keluarga yang Harmonis

Walaupun anak mulai hidup mandiri, keluarga tetap memiliki tugas menjaga komunikasi, kedekatan emosional, serta dukungan antaranggota keluarga. Hubungan yang sehat membantu terciptanya kesinambungan fungsi keluarga lintas generasi.

4) Menata Kembali Peran dan Fungsi Suami-Istri

Ketika anak mulai meninggalkan rumah, pasangan suami-istri perlu menyesuaikan kembali pola hubungan mereka. Fokus keluarga yang sebelumnya berpusat pada pengasuhan anak mulai bergeser pada penguatan hubungan perkawinan dan perencanaan kehidupan tahap berikutnya.

5) Menata Kembali Sumber Daya dan Fasilitas Keluarga

Keluarga melakukan reorganisasi terhadap penggunaan waktu, keuangan, ruang rumah, serta sumber daya lainnya sesuai perubahan jumlah anggota keluarga yang tinggal di rumah.

6) Memperluas Hubungan Keluarga Inti Menjadi Keluarga Besar

Pada tahap ini keluarga mulai menerima anggota baru seperti menantu dan cucu sehingga sistem keluarga berkembang menjadi keluarga besar (*extended family*). Keluarga dituntut mampu menyesuaikan pola interaksi dan peran baru dalam struktur keluarga.

7) Membantu Anak Membentuk Keluarga Baru di Masyarakat

Orang tua mendukung anak dalam membangun kehidupan baru, baik dalam pekerjaan, pendidikan, maupun perkawinan. Dukungan diberikan dalam bentuk bimbingan, nilai-nilai keluarga, serta dukungan moral dan sosial.

8) Mempertahankan Keintiman dan Dukungan Emosional Pasangan

Keluarga memiliki tugas mempertahankan hubungan emosional yang hangat antara pasangan suami-istri setelah berkurangnya peran pengasuhan langsung terhadap anak.

9) Menjalankan Peran Baru sebagai Kakek atau Nenek

Pada sebagian keluarga, tahap ini juga ditandai dengan munculnya peran baru sebagai kakek dan nenek. Keluarga perlu menyesuaikan diri terhadap perubahan peran antar generasi dalam sistem keluarga.

g. Tahap VII: Keluarga Usia Pertengahan

Tahap ini dimulai pada saat seorang anak terakhir kali meninggalkan rumah dan berakhir pada saat pensiun atau salah satu pasangan meninggal. Pada beberapa pasangan fase ini dirasakan sulit karena masalah lanjut usia, perpisahan dengan anak, dan perasaan gagal sebagai orang tua. Setelah semua anak meninggalkan rumah, maka pasangan suami istri fokus untuk mempertahankan kesehatan dengan berbagai aktivitas: pola hidup yang sehat, diet seimbang, olah raga rutin, menikmati hidup dan pekerjaan, dan sebagainya.

Pasangan juga mempertahankan hubungan dengan teman sebaya dan keluarga lainnya dengan cara mengadakan pertemuan keluarga antar generasi (anak dan cucu) sehingga pasangan dapat merasakan kebahagiaan sebagai kakek nenek. Hubungan antar pasangan perlu semakin dieratkan dengan memperhatikan kebergantungan dan kemandirian masing-masing pasangan.

Tugas-Tugas Keluarga pada Tahap Usia Pertengahan

- 1) Mempertahankan dan meningkatkan kesehatan anggota keluarga
Keluarga usia pertengahan memiliki tugas untuk menjaga kesehatan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual seluruh anggota keluarga. Upaya ini dilakukan melalui penerapan pola hidup sehat, pemeriksaan kesehatan berkala, pengaturan aktivitas fisik, istirahat yang cukup, serta pemeliharaan keseimbangan emosional keluarga.
- 2) Mempertahankan hubungan perkawinan yang harmonis dan bermakna
Pasangan suami istri perlu memperkuat kembali hubungan emosional setelah anak-anak mulai mandiri. Fokus keluarga kembali pada peningkatan keintiman, komunikasi yang efektif, saling mendukung, dan menjaga kepuasan dalam kehidupan perkawinan.
- 3) Memelihara hubungan yang memuaskan dengan anak-anak dewasa
Keluarga bertugas mempertahankan hubungan yang sehat dengan anak yang telah dewasa tanpa menghambat kemandirian mereka. Orang tua mulai berperan sebagai pendukung, pemberi arahan, dan sumber konsultasi bagi anak-anaknya.
- 4) Menjalin dan mempertahankan hubungan dengan orang tua lanjut usia
Pada tahap ini keluarga memiliki tanggung jawab moral dan emosional terhadap orang tua yang memasuki usia lanjut. Tugas keluarga mencakup pemberian dukungan, perhatian, perawatan, serta menjaga hubungan interpersonal yang hangat dengan generasi sebelumnya.
- 5) Menyesuaikan diri terhadap perubahan peran keluarga
Keluarga usia pertengahan perlu melakukan reorganisasi peran setelah anak-anak mulai mandiri. Pasangan kembali menjalankan fungsi sebagai "keluarga inti berdua" dan menyesuaikan aktivitas rumah tangga, tanggung jawab, serta pola interaksi keluarga.
- 6) Mengembangkan aktivitas sosial dan pemanfaatan waktu luang
Keluarga mulai memiliki lebih banyak waktu untuk mengembangkan minat pribadi, aktivitas sosial, kegiatan rekreasi, organisasi masyarakat, maupun aktivitas spiritual sebagai bentuk aktualisasi diri dan peningkatan kualitas hidup keluarga.
- 7) Mempersiapkan masa pensiun dan kehidupan lanjut usia
Keluarga usia pertengahan memiliki tugas untuk mempersiapkan kehidupan pada masa tua, baik secara ekonomi, psikologis, sosial, maupun spiritual. Persiapan ini mencakup perencanaan keuangan, kesiapan perubahan aktivitas, dan adaptasi terhadap proses penuaan.
- 8) Mempertahankan stabilitas dan fungsi keluarga

Keluarga bertugas menjaga keberlangsungan fungsi afektif, fungsi sosial, fungsi ekonomi, serta fungsi perawatan kesehatan agar keluarga tetap adaptif terhadap perubahan siklus kehidupan keluarga.

h. Tahap VIII : Keluarga Usia Lanjut

Tahap terakhir perkembangan keluarga ini dimulai saat salah satu pasangan pensiun, berlanjut saat salah satu pasangan meninggal sampai keduanya meninggal. Proses lanjut usia dan pensiun merupakan realitas yang tidak dapat dihindari karena berbagai stresor dan kehilangan yang harus dialami keluarga. Stresor tersebut adalah berkurangnya pendapatan, kehilangan berbagai hubungan sosial, kehilangan pekerjaan, serta perasaan menurunnya produktivitas dan fungsi kesehatan. Fokus utama pada tahap ini adalah mempertahankan integritas keluarga, adaptasi terhadap perubahan kehidupan, serta menjaga keberlangsungan fungsi keluarga.

Mempertahankan penataan kehidupan yang memuaskan merupakan tugas utama keluarga pada tahap ini. Usia lanjut umumnya lebih dapat beradaptasi tinggal di rumah sendiri daripada tinggal bersama anaknya. Menurut riset Day and Day (1993), wanita yang tinggal dengan pasangannya memperlihatkan adaptasi yang lebih positif dalam memasuki masa tuanya dibandingkan dengan wanita yang tinggal dengan teman-teman sebayanya. Orang tua juga perlu melakukan *"life review"* dengan mengenang pengalaman hidup dan keberhasilan di masa lalu. Hal ini berguna agar orang tua merasakan, bahwa hidupnya berkualitas dan berarti.

Tugas-tugas perkembangan keluarga usia lanjut

1) Mempertahankan pengaturan hidup yang memuaskan

Keluarga usia lanjut diharapkan mampu mempertahankan pola kehidupan yang nyaman, aman, dan sesuai dengan kondisi fisik maupun psikososial lansia. Pengaturan kehidupan mencakup penyesuaian aktivitas harian, pengelolaan rumah tangga, pola interaksi keluarga, serta mempertahankan lingkungan yang mendukung kesejahteraan lansia.

2) Menyesuaikan diri terhadap penurunan pendapatan atau masa pensiun

Memasuki usia lanjut sering diikuti berhentinya pekerjaan atau berkurangnya produktivitas ekonomi. Oleh karena itu, keluarga perlu melakukan adaptasi terhadap perubahan sumber penghasilan, mengatur kembali kebutuhan ekonomi keluarga, serta mempertahankan stabilitas finansial secara realistis sesuai kemampuan keluarga.

3) Mempertahankan hubungan perkawinan yang harmonis

Pada tahap ini pasangan lansia diharapkan tetap mempertahankan hubungan emosional yang hangat, saling mendukung, dan menjaga kedekatan interpersonal. Hubungan perkawinan yang baik menjadi sumber dukungan psikologis utama dalam menghadapi perubahan fisik, sosial, dan emosional pada usia lanjut.

4) Menyesuaikan diri terhadap kehilangan pasangan

Kehilangan pasangan hidup merupakan bagian dari proses perkembangan keluarga usia lanjut. Keluarga perlu beradaptasi terhadap perubahan struktur keluarga, menjalani kehidupan secara mandiri apabila menjadi duda atau janda, serta mempertahankan kebermaknaan hidup setelah kehilangan pasangan.

5) Mempertahankan ikatan keluarga antar generasi

Keluarga usia lanjut memiliki tugas menjaga hubungan yang baik dengan anak, cucu, maupun anggota keluarga besar lainnya. Interaksi antar generasi diperlukan untuk mempertahankan dukungan emosional, nilai keluarga, kontinuitas budaya keluarga, serta keberfungsian keluarga sebagai suatu sistem sosial.

6) Melanjutkan proses adaptasi terhadap kehilangan anggota keluarga dan perubahan peran

Pada tahap ini keluarga sering mengalami perubahan struktur dan fungsi akibat kematian saudara, teman sebaya, atau anggota keluarga lainnya. Lansia diharapkan mampu menerima berbagai kehilangan secara bertahap dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan peran dalam keluarga maupun masyarakat.

7) Menyesuaikan diri terhadap penurunan kemampuan fisik dan kesehatan

Keluarga usia lanjut perlu menerima perubahan biologis sebagai bagian normal dari proses penuaan. Penyesuaian dilakukan melalui pengaturan aktivitas, pemeliharaan kesehatan, penggunaan fasilitas kesehatan, serta pengembangan pola hidup yang mendukung kualitas hidup lansia.

8) Mempertahankan kepuasan dan makna hidup

Keluarga usia lanjut diharapkan tetap memiliki tujuan hidup, mempertahankan aktivitas sosial dan spiritual, serta melakukan refleksi kehidupan (life review) secara positif sebagai bentuk pencapaian integritas diri pada masa tua

C. Konsep Tuberkulosis

1. Pengertian

Tuberkulosis (TBC) merupakan penyakit infeksi menular terutama menyerang parenkim paru, umumnya disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis* (MTb). Penyakit ini dapat menyerang berbagai bagian tubuh termasuk selaput otak, ginjal, tulang, dan kelenjar getah bening, namun paling umum menyerang paru-paru, yang dikenal sebagai TBC Paru tetapi juga dapat menyebar ke bagian lain tubuh (Pitaloka & Siyam, 2020). Infeksi awal biasanya terjadi 2 hingga 10 minggu setelah terpapar. Pasien kemudian dapat mengembangkan penyakit aktif karena respons sistem kekebalan tubuh yang terganggu atau tidak memadai.

TBC tergolong airborne disease yakni penularan melalui *droplet nuclei* yang dikeluarkan ke udara oleh individu terinfeksi dalam fase aktif. Selain itu kuman TBC dapat keluar bebas di udara saat penderita TBC batuk, bersin, bernyayi, dan bersiul. Penularan terjadi karena kuman dibatukkan atau dibersinkan keluar menjadi *droplet nuclei* dalam udara. Partikel infeksi ini dapat menetap dalam udara bebas selama 1 – 2 jam (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021).

2. Etiologi

TBC adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis* (MTb), sejenis kuman berbentuk batang dengan ukuran panjang 1-4/Um dan tebal 0,3-0,6/Um, sebagian besar kuman MTb terdiri dari asam lemak (lipid), lipid inilah yang membuat kuman lebih tahan terhadap asam dan lebih tahan terhadap gangguan kimia dan fisik (Okuonghae, 2013). Kuman ini dapat tahan hidup pada udara kering maupun dingin (dapat tahan bertahun-tahun dalam lemari es), hal ini terjadi karena kuman berada dalam sifat *dormant* yaitu dapat bangkit kembali dan menjadikan TBC aktif lagi.

Kuman MTb berbentuk batang memiliki sifat unik, yaitu tahan terhadap pewarnaan asam. Oleh karena itu, dikenal sebagai Basil Tahan Asam (BTA). MTb cepat mati jika terkena sinar matahari langsung, tetapi dapat bertahan beberapa jam di tempat gelap dan lembab. Infeksi kronik yang disebabkan oleh MTb biasanya menyerang paru-paru. Droplet nucleus dapat menyebarkan bakteri melalui udara. Droplet ini terbentuk ketika seseorang yang terinfeksi batuk, bersin, berbicara, atau bernyanyi (Gultom & Isaura, 2024).

Sifat dari kuman ini adalah anaerob, sifat ini menunjukkan bahwa kuman lebih menyukai jaringan yang tinggi kandungan oksigennya, dalam hal ini

tekanan oksigen bagian apikal paru-paru lebih tinggi dari pada bagian lain, sehingga bagian apikal ini merupakan tempat predileksi penyakit TBC.

3. Faktor-Faktor yang Meningkatkan Risiko Penularan Tuberkulosis

Beberapa faktor yang diketahui berkontribusi terhadap risiko penularan TBC diantaranya adalah : pasien TBC Paru dengan BTA Positif, jumlah percikan dahak dalam udara dan lamanya menghirup udara tersebut, kontak erat dengan pasien TBC, tinggal di daerah padat penduduk, ventilasi rumah tidak menggerakkan udara dan sinar matahari tidak masuk, orang dengan status gizi rendah (Fadhilah et al., 2023).

a. Kepadatan Hunian dan Ventilasi yang Buruk

Lingkungan tempat tinggal dengan kepadatan hunian tinggi dan ventilasi yang tidak memadai dapat meningkatkan risiko penularan TBC. Ventilasi yang buruk menyebabkan akumulasi droplet yang mengandung *MTb* di udara, sehingga meningkatkan kemungkinan individu terpapar bakteri tersebut. Kondisi fisik rumah, termasuk ventilasi dan kepadatan hunian, berperan signifikan dalam kejadian TB paru di wilayah kerja Puskesmas Baturraden I Kabupaten Banyumas (Dewani et al., 2025).

b. Gizi Buruk dan Sistem Imun yang Lemah

Status gizi yang buruk dapat melemahkan sistem imun, membuat individu lebih rentan terhadap infeksi TBC. Individu dengan defisiensi nutrisi memiliki kemampuan yang lebih rendah dalam melawan infeksi, termasuk TBC. Studi oleh Pratiwi (2020) mengidentifikasi bahwa gizi buruk merupakan salah satu faktor risiko utama dalam kejadian TB paru di Indonesia (Sabir, 2023).

c. Kontak Erat dengan Penderita TBC Aktif

Kontak erat dan berkepanjangan dengan penderita TBC aktif, terutama dalam lingkungan rumah tangga, meningkatkan risiko penularan. Penelitian oleh Pratiwi (2020) menemukan bahwa riwayat kontak dengan penderita TBC merupakan faktor risiko signifikan dalam kejadian TBC paru (Sabir, 2023).

d. Penggunaan Obat yang Menekan Sistem Kekebalan Tubuh

Penggunaan obat imunosupresan, seperti kortikosteroid atau obat kemoterapi, dapat menurunkan fungsi sistem imun, meningkatkan kerentanan terhadap infeksi TBC. Individu dengan sistem imun yang lemah (misalnya, lansia, penderita kanker, terapi kortikosteroid, dan HIV) memiliki risiko lebih tinggi untuk mengembangkan TBC aktif. Meskipun penelitian spesifik mengenai penggunaan obat imunosupresan sebagai faktor risiko TBC di Indonesia masih terbatas, prinsip ini diakui secara luas dalam literatur medis global.

4. Patofisiologi

Berikut adalah perjalanan penyakit infeksi *Mycobacterium tuberculosis* dalam tubuh manusia (Muray, 2022);

- a. Infeksi bakteri oleh basil *Mycobacterium tuberculosis* (TB); terutama menyerang paru-paru (70% menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit [CDC], 2004) meskipun dapat menyerang sistem tubuh lainnya, dan melalui tetesan yang terbawa udara terhirup, dengan inti tetesan tersebut mengendap di dalam alveoli paru-paru.
- b. Infeksi primer diikuti oleh fase laten atau tidak aktif, atau oleh penyakit aktif pada beberapa individu.
- c. Ketika sistem kekebalan melemah, organisme TB yang tidak aktif dapat aktif kembali dan berkembang biak (TB reaktivasi).
- d. Aktivasi Sistem Imun
Sistem imun mengenali kehadiran bakteri dan mengaktifkan sel-sel fagosit, terutama makrofag alveolar.
- e. Fagositosis oleh Makrofag
Makrofag menelan (fagositosis) MTb untuk menghancurkannya.
- f. Evasion dan Multiplikasi Intramakrofag
MTb memiliki kemampuan bertahan di dalam makrofag dan justru berkembang biak di dalamnya, menghindari penghancuran.
- g. Pembentukan Granuloma
Sistem imun membentuk struktur granuloma (agregat makrofag, sel epiteloid, limfosit, dan sel raksasa) untuk membatasi penyebaran bakteri.
- h. Status Infeksi:
 - 1) Laten: Sistem kekebalan tubuh telah membungkus bakteri ke dalam kapsul-kapsul kecil yang disebut tuberkel; infeksi ini tidak menular ke orang lain.
 - 2) Aktif: Infeksi menyebar di dalam tubuh dan dapat menular ke orang lain.
- i. Penyebaran Sistemik (jika imun gagal)
MTb dapat menyebar melalui darah atau limfatik ke organ lain: otak, ginjal, tulang, dll. (TBC *ekstrapulmoner*).

5. Manifestasi klinik

Seseorang yang sudah terinfeksi dengan bakteri MTb, biasanya menimbulkan beberapa macam gejala (Nasution et al., 2023), yaitu :

- a. Batuk berkepanjangan yang berlangsung lebih dari tiga minggu. Batuk ini dapat bersifat kering yang dapat berkembang menjadi dahak berlendir dan bernanah disertai batuk berdarah

- b. Demam yang berlangsung lama dan suhu tubuh cenderung meningkat di sore atau malam hari dan bisa disertai dengan menggigil.
- c. Mengalami Penurunan Berat Badan disebabkan oleh berkurangnya nafsu makan atau gangguan metabolisme akibat infeksi.
- d. Berkeringat berlebihan pada malam hari meskipun tanpa aktifitas fisik yang signifikan dan dapat mengganggu tidur.
- e. Penderita sering merasa lemah dan kehilangan energi yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari.

6. Pemeriksaan penunjang

N o	Jenis Pemeriksaan	Deskripsi	Tujuan
1	BTA (Basil Tahan Asam)	Pemeriksaan sputum dengan pewarnaan Ziehl-Neelsen untuk mendeteksi kuman TB	Menentukan pasien infeksius
2	Tes Cepat Molekuler (TCM/GeneXpert)	Deteksi DNA <i>Mycobacterium tuberculosis</i> dan resistensi rifampisin	Diagnosis cepat dan deteksi resistensi obat
3	Kultur (Biakan Kuman)	Penanaman kuman pada media Lowenstein-Jensen	Gold standard diagnosis TB
4	Foto Rontgen Dada	Pemeriksaan radiologi melihat infiltrat, kavitas, fibrosis	Menilai kerusakan paru
5	Uji Tuberkulin (Mantoux)	Tes reaksi kulit terhadap antigen TB	Mengetahui paparan TB
6	IGRA	Pemeriksaan respon imun spesifik TB	Diagnosis infeksi TB laten
7	Pemeriksaan Darah	LED meningkat, leukosit meningkat	Menilai inflamasi
8	Analisis Cairan Tubuh	Pemeriksaan cairan pleura/CSF	Diagnosis TB ekstraparu
9	Tes HIV	Pemeriksaan infeksi HIV	Mengetahui komorbid TB-HIV

7. Komplikasi

Komplikasi TB terjadi akibat infeksi kronis atau keterlambatan pengobatan yang dapat menyebabkan kerusakan organ (*World Health Organization, 2023; Harrison's Principles of Internal Medicine, 2022*)

a. Komplikasi Paru

- 1) Hemoptisis (Batuk Darah)

- Terjadi akibat kerusakan pembuluh darah paru dan dapat mengancam jiwa (*Brunner & Suddarth, 2021*)
- 2) Pneumotoraks
Terjadi akibat pecahnya kavitas paru sehingga udara masuk ke rongga pleura dan menyebabkan paru kolaps (*Harrison's Infectious Diseases, 2022*)
 - 3) Bronkiektasis
Pelebaran bronkus permanen akibat infeksi kronis yang menyebabkan batuk produktif berkepanjangan (*Brunner & Suddarth, 2021*)
 - 4) Fibrosis Paru
Kerusakan jaringan paru yang menyebabkan penurunan fungsi paru secara permanen (*Harrison's Principles of Internal Medicine, 2022*)
 - 5) Gagal Napas
Terjadi akibat kerusakan paru yang luas sehingga pertukaran gas terganggu (*World Health Organization, 2023*)
- b. Komplikasi Sistemik
- 1) TB Milier
Penyebaran kuman melalui darah ke seluruh tubuh dan mengenai banyak organ (*World Health Organization, 2023*)
 - 2) TB Ekstraparu
Dapat mengenai berbagai organ seperti tulang, otak, dan ginjal. (*Kementerian Kesehatan RI, 2023*)
 - 3) Malnutrisi
Infeksi kronis menyebabkan penurunan nafsu makan dan berat badan. (*Brunner & Suddarth, 2021*)
 - 4) Anemia
Terjadi akibat peradangan kronis yang mempengaruhi produksi sel darah merah (*Harrison's Principles of Internal Medicine, 2022*)
- c. Komplikasi Organ Spesifik
- 1) Meningitis TB
Infeksi pada selaput otak yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan kematian (*Harrison's Infectious Diseases, 2022*)
 - 2) Spondilitis TB (Pott's Disease)
Infeksi tulang belakang yang dapat menyebabkan deformitas dan kelumpuhan (*Kementerian Kesehatan RI, 2023*)
 - 3) Perikarditis TB
Infeksi pada selaput jantung yang dapat mengganggu fungsi jantung. (*World Health Organization, 2023*)

8. Penatalaksanaan

a. Farmakologi

Tujuan pengobatan TBC adalah; menyembuhkan pasien dan meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup, mencegah kematian akibat TBC atau dampak buruk yang ditimbulkannya, mencegah kekambuhan TBC, mengurangi risiko penularan TBC, serta mencegah terjadinya dan penularan TBC yang resisten terhadap obat (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021). Obat Anti Tuberkulosis (OAT) merupakan komponen terpenting dalam pengobatan TBC.

Pengobatan TBC merupakan salah satu upaya yang paling efisien untuk mencegah penyebaran kuman TBC lebih lanjut, oleh karena itu pengobatan yang adekuat harus memenuhi prinsip-prinsip: diberikan dalam bentuk kombinasi OAT yang tepat yang mengandung paling sedikit 4 macam obat untuk mencegah terjadinya resistensi, diberikan dengan dosis yang tepat, ditelan secara teratur dan diawasi secara langsung oleh Pengawas Menelan Obat (PMO) hingga selesai pengobatan, dan pengobatan diberikan dalam jangka waktu yang cukup, dibagi dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap awal dan tahap lanjutan, sebagai pengobatan yang adekuat untuk mencegah terjadinya kekambuhan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021).

Pengobatan tahap awal (fase intensif) diberikan setiap hari, tujuannya adalah untuk secara efektif mengurangi jumlah kuman di dalam tubuh pasien dan meminimalkan pengaruh sejumlah kecil kuman yang mungkin sudah kebal sejak sebelum pasien menerima pengobatan. Pengobatan awal pada semua pasien baru, harus diberikan selama 2-3 bulan. Pada umumnya, dengan pengobatan yang teratur dan tanpa komplikasi, tingkat penularan sudah sangat menurun setelah 2 minggu pertama pengobatan. Sedangkan pengobatan tahap lanjutan (4-7 bulan) bertujuan untuk membunuh sisa kuman yang masih ada di dalam tubuh, terutama bakteri yang persisten sehingga penderita dapat sembuh dan mencegah kekambuhan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021)

Tabel 1.1
Pengobatan Pasien TBC

Fase Pengobatan	Durasi	Tujuan	Obat yang Diberikan	Pemantauan dan Tindak Lanjut
Fase Intensif	2 bulan	Membunuh bakteri TBC yang aktif secara cepat	HRZE (Isoniazid, Rifampisin, Pirazinamid, Etambutol)	▪ Kunjungan rutin setiap minggu ke fasyankes- - Edukasi efek samping obat dan kepatuhan minum obat- - Pemeriksaan dahak setelah 2 bulan
Fase Lanjutan	4 bulan	Membunuh sisa bakteri yang masih bertahan untuk mencegah kekambuhan	HR (Isoniazid dan Rifampisin)	▪ Pemantauan bulanan di fasyankes ▪ Pemeriksaan lanjutan (dahak, berat badan, efek samping) ▪ Evaluasi gejala klinis
Evaluasi Kesembuhan	Setelah 6 bulan (selesai terapi)	Menentukan keberhasilan terapi dan status kesembuhan pasien	Tidak ada obat jika pengobatan selesai	▪ Pemeriksaan sputum ulang ▪ Penilaian klinis dan radiologis jika perlu ▪ Edukasi pasien tentang deteksi dini kekambuhan
Fase Pemantauan Pasca-Sembuh	6–12 bulan setelah sembuh	Mendeteksi dini kekambuhan atau efek jangka panjang	Tidak ada	▪ Edukasi pasien dan keluarga ▪ Monitoring gejala sisa atau komplikasi ▪ Follow-up rutin sesuai indikasi

b. Penatalaksanaan Non-Farmakologi

Penatalaksanaan non-medis bersifat suportif dan preventif, meliputi:

- 1) Edukasi dan konseling: tentang kepatuhan minum obat, efek samping, dan pencegahan penularan.
- 2) Nutrisi: meningkatkan asupan protein dan kalori karena TBC menyebabkan wasting.

- 3) Perbaiki lingkungan: ventilasi rumah, pencahayaan, dan kebersihan.
 - 4) Isolasi sementara: untuk mencegah penularan selama fase infeksi aktif.
 - 5) Vaksinasi: pemberian BCG (Bacillus Calmette–Guérin) pada bayi untuk mencegah TBC berat.
 - 6) Program skrining dan penemuan kasus aktif (Active Case Finding) di komunitas berisiko tinggi.
- c. Manajemen Keperawatan
- 1) Mendorong Pembersihan Saluran Napas
 - a) Dorong peningkatan asupan cairan.
 - b) Berikan petunjuk mengenai posisi terbaik untuk memudahkan drainase.
 - 2) Mendorong Kepatuhan terhadap Rencana Pengobatan
 - a) Jelaskan bahwa TB adalah penyakit menular dan bahwa minum obat adalah cara paling efektif untuk mencegah penularan.
 - b) Berikan petunjuk mengenai obat-obatan, jadwal, dan efek samping; pantau efek samping obat anti-TB.
 - c) Berikan instruksi mengenai risiko resistensi obat jika rejimen pengobatan tidak diikuti secara ketat dan terus-menerus.
 - d) Pantau tanda-tanda vital dengan cermat dan amati lonjakan suhu atau perubahan status klinis pasien.
 - e) Ajarkan kepada pengasuh pasien yang tidak dirawat di rumah sakit untuk memantau suhu dan status pernapasan pasien; laporkan setiap perubahan status pernapasan pasien kepada penyedia layanan kesehatan primer.
 - 3) Mendorong Aktivitas dan Gizi yang Cukup
 - a) Rencanakan jadwal aktivitas bertahap bersama pasien untuk meningkatkan toleransi aktivitas dan kekuatan otot.
 - b) Susun rencana pendukung untuk mendorong asupan gizi yang cukup. Pola makan berupa porsi kecil yang sering dan suplemen nutrisi mungkin bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan kalori harian.
 - c) Identifikasi fasilitas (misalnya, tempat penampungan, dapur umum, Meals on Wheels) yang menyediakan makanan di lingkungan pasien dapat meningkatkan kemungkinan bahwa pasien dengan sumber daya dan energi terbatas akan memiliki akses ke asupan nutrisi yang lebih baik.
 - 4) Mencegah Penyebaran Infeksi TB
 - a) Berikan pengarahan secara cermat kepada pasien mengenai langkah-langkah kebersihan yang penting, termasuk perawatan mulut, menutup

mulut dan hidung saat batuk dan bersin, membuang tisu dengan benar, serta mencuci tangan.

- b) Laporkan setiap kasus TB ke dinas kesehatan agar orang-orang yang telah berkontak dengan pasien yang terinfeksi selama fase menular dapat menjalani skrining dan pengobatan jika diperlukan.
- c) Berikan pengarahan kepada pasien mengenai risiko penyebaran TB ke bagian tubuh lain (penyebaran infeksi TB ke bagian tubuh non-paru-paru dikenal sebagai TB milier).
- d) Pantau pasien dengan cermat untuk TB milier: Pantau tanda-tanda vital dan perhatikan lonjakan suhu serta perubahan fungsi ginjal dan kognitif; sedikit tanda fisik mungkin terdeteksi pada pemeriksaan fisik dada, tetapi pada tahap ini pasien mengalami batuk parah dan sesak napas. Pengobatan TB milier sama dengan pengobatan TB paru.

D. Referensi

- American Thoracic Society. (2022). *Harrison's infectious diseases* (3rd ed.). McGraw-Hill Education. New York.
- American Thoracic Society. (2022). *Harrison's principles of internal medicine* (21st ed.). McGraw-Hill Education. New York.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (1992). *Pedoman pembinaan fungsi keluarga*. BKKBN. Jakarta.
- Black, J. M., & Hawks, J. H. (2021). *Medical-surgical nursing: Clinical management for positive outcomes* (10th ed.). Elsevier. St. Louis.
- Brunner, L. S., & Suddarth, D. S. (2021). *Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing* (15th ed.). Wolters Kluwer. Philadelphia.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2004). *Tuberculosis transmission and pathogenesis*. CDC. Atlanta.
- Day, R. D., & Day, J. V. (1993). *Family relationships in later life*. Harper Collins. New York.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Pedoman umum program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga*. Kementerian Kesehatan RI. Jakarta.
- Dewani, N., Prasetyo, A., & Rahmawati, I. (2025). Hubungan kondisi fisik rumah dengan kejadian tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Baturraden I Kabupaten Banyumas. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 24(1), 15–24.
- Duvall, E. M. (1985). *Marriage and family development* (6th ed.). Harper & Row.

New York.

- Fadhilah, N., Tri Bowo, I., & Putri, D. (2023). Faktor risiko penularan tuberkulosis pada kontak serumah di Kabupaten Pringsewu. *Jurnal Keperawatan Komunitas Indonesia*, 8(2), 102–110.
- Fadhilah, N., Razak Muttalif, A., Hashim, F., Kesehatan, F., Muhammadiyah, U., & Lampung, P. (2023). Pendidikan Kesehatan Sebuah Pendekatan/Nilai Untuk Meningkatkan Pengetahuan Pencegahan Penularan Tb Paru Pada Anggota Keluarga Kontak Serumah (Vol. 12, Issue 1). <https://ejournal.umpri.ac.id/index.php/JIK>
- Friedman, M. M. (1988). *Family nursing: Theory and assessment* (2nd ed.). Appleton & Lange. Norwalk.
- Friedman, M. M. (1998). *Family nursing: Research, theory, and practice* (5th ed.). Prentice Hall. New Jersey.
- Friedman, M. M. (2003). *Family nursing: Research, theory, and practice* (6th ed.). Prentice Hall. New Jersey.
- Friedman, M. M. (2010). *Buku ajar keperawatan keluarga: Riset, teori, dan praktik* (5th ed.). EGC. Jakarta.
- Friedman, M. M., Bowden, V. R., & Jones, E. G. (2003). *Family nursing: Research, theory, and practice* (5th ed.). Prentice Hall. New Jersey.
- Gultom, R., & Isaura, M. (2024). Karakteristik Mycobacterium tuberculosis dan mekanisme penularannya. *Jurnal Mikrobiologi Klinik Indonesia*, 12(1), 44–53.
- Kaakinen, J. R., Coehlo, D. P., Steele, R., Robinson, M., & Hanson, S. M. H. (2018). *Family health care nursing: Theory, practice, and research* (6th ed.). F.A. Davis Company. Philadelphia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman nasional pelayanan kedokteran tata laksana tuberkulosis*. Kementerian Kesehatan RI. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Pedoman nasional penanggulangan tuberkulosis*. Kementerian Kesehatan RI. Jakarta.
- Lancaster, J., & Stanhope, M. (2020). *Public health nursing: Population-centered health care in the community* (10th ed.). Elsevier. St. Louis.
- Lewis, S. L., Bucher, L., Heitkemper, M. M., & Harding, M. (2023). *Medical-surgical nursing: Assessment and management of clinical problems* (12th ed.). Elsevier. St. Louis.
- Littlefield, J. (1977). Family planning and developmental tasks in early marriage. In M. M. Friedman (Ed.), *Family nursing theory and practice*. Appleton-Century-Crofts. New York.

- Macionis, J. J. (2012). *Sociology* (14th ed.). Pearson Education. Boston.
- Murray, J. F. (2022). *Murray & Nadel's textbook of respiratory medicine* (7th ed.). Elsevier. Philadelphia.
- Nasution, R., Siregar, D., & Harahap, F. (2023). Manifestasi klinis tuberkulosis paru pada pasien dewasa. *Jurnal Respirasi Indonesia*, 43(2), 88–96.
- Okuonghae, D. (2013). Epidemiology and control of tuberculosis. *International Journal of Epidemiology and Public Health*, 5(2), 45–53.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- Pitaloka, D. A., & Siyam, N. (2020). Tuberkulosis paru dan faktor risiko penularannya. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 15(1), 34–42.
- Pratiwi, N. (2020). Faktor risiko kejadian tuberkulosis paru di Indonesia. *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Indonesia*, 4(2), 67–75.
- Sabir, M. (2023). Hubungan status gizi dengan kejadian tuberkulosis paru di Indonesia. *Jurnal Gizi dan Kesehatan Indonesia*, 11(3), 120–129.
- Salvicion, G. B., & Maglaya, A. S. (1989). *Family nursing: The Filipino experience*. University of the Philippines Press. Quezon City.
- Stanhope, M., & Lancaster, J. (2020). *Foundations for population health in community/public health nursing* (5th ed.). Elsevier. St. Louis.
- Steinmetz, S. K., Clavan, S., & Stein, K. F. (1990). *Marriage and family realities: Historical and contemporary perspectives*. Harper Collins. New York.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- World Health Organization. (2023). *Global tuberculosis report 2023*. World Health Organization. Geneva.

CHAPTER 2

TUGAS KESEHATAN KELUARGA DALAM PERAWATAN ANGGOTA KELUARGA DENGAN TB PARU

Ns. Ardila Lailatul Barik, S.Kep., M.Kep

A. Pendahuluan

Asuhan keperawatan keluarga merupakan proses keperawatan yang berfokus pada keluarga sebagai unit pelayanan, bukan semata-mata individu sebagai anggota keluarga. Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa keluarga adalah sistem sosial fundamental yang memiliki pengaruh determinatif terhadap status kesehatan setiap anggotanya. Friedman et al., (2003) mendefinisikan keperawatan keluarga sebagai pemberian perawatan yang menggunakan proses keperawatan kepada keluarga dan anggota-anggotanya dalam situasi sehat dan sakit. Dengan demikian, asuhan keperawatan keluarga tidak hanya merespons kondisi patologis individual, melainkan juga memperhatikan konteks relasional, fungsional, dan struktural keluarga secara menyeluruh.

Proses keperawatan keluarga mencakup lima tahapan: pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Tahap pengkajian tidak hanya mengidentifikasi masalah kesehatan individu, tetapi juga menilai fungsi keluarga, pola interaksi, sumber daya, dan kemampuan koping keluarga. Secara khusus, dalam konteks penyakit kronis seperti tuberkulosis paru, diagnosa yang lazim muncul adalah Manajemen Kesehatan Keluarga Tidak Efektif yang mencerminkan tantangan yang dihadapi keluarga dalam mengelola penyakit anggotanya (Herdman et al., 2021).

Pendekatan holistik dalam asuhan keperawatan keluarga mensyaratkan tenaga keperawatan untuk memiliki kompetensi lintas disiplin, termasuk pemahaman tentang dinamika keluarga, faktor sosioekonomi, budaya kesehatan, serta kebijakan kesehatan masyarakat. Dengan orientasi ini, perawat tidak hanya berperan sebagai pemberi asuhan klinis, melainkan juga sebagai edukator, advokat, koordinator, dan fasilitator yang mendorong keluarga menuju kemandirian dalam mengelola kesehatan (Stanhope & Lancaster, 2020).

Keluarga dalam perspektif keperawatan dimaknai sebagai unit fungsional yang menjalankan berbagai peran dan tugas esensial bagi keberlangsungan hidup

dan kesejahteraan anggotanya. Friedman, (1998) mengidentifikasi lima fungsi utama keluarga, yaitu: (1) fungsi afektif yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan emosional; (2) fungsi sosialisasi yang mempersiapkan anggota keluarga untuk berinteraksi dalam masyarakat; (3) fungsi reproduksi; (4) fungsi ekonomi; dan (5) fungsi perawatan kesehatan yang menjadi pilar utama dalam konteks asuhan keperawatan keluarga.

Peran keluarga dalam asuhan keperawatan mencakup peran sebagai pengasuh (*caregiver*), pengambil keputusan kesehatan (*health decision-maker*), manajer sumber daya, dan pendukung emosional. Masing-masing peran ini berkontribusi secara langsung terhadap kemampuan keluarga dalam merespons situasi sakit yang dialami anggotanya. Dalam kerangka teoritis Duvall & Miller, (1977) mengenai tahap perkembangan keluarga, tugas perkembangan yang harus diselesaikan keluarga pada setiap tahap siklus kehidupan turut memengaruhi kapasitas keluarga dalam memberikan perawatan.

Keluarga memainkan peran penting dalam merawat anggota keluarga yang sakit, dan salah satu fungsi keluarga adalah perawatan kesehatan (Friedman, 2014; Rachmawati et al., 2022). Keluarga sebagai sebuah kelompok dapat menyebabkan, mencegah, mengabaikan, atau mengatasi masalah kesehatan dalam kelompok tersebut. Masalah kesehatan dalam keluarga saling terkait dan jika salah satu anggota sakit, hal itu akan memengaruhi anggota keluarga lainnya dan juga akan memengaruhi masyarakat sekitarnya (Friedman, 2014; Rachmawati et al., 2022).

B. Tugas Kesehatan Keluarga pada Pasien TB Paru

Tugas keluarga dalam memberikan perawatan kesehatan merupakan manifestasi konkret dari fungsi perawatan kesehatan yang menjadi tanggung jawab intrinsik setiap keluarga. M. M Friedman, (1998) menegaskan bahwa kemampuan keluarga untuk memenuhi tugas kesehatan ini merupakan determinan utama status kesehatan anggotanya. Dalam konteks TB Paru, tugas perawatan kesehatan keluarga menjadi sangat kritis mengingat karakteristik penyakit ini yang bersifat menular, memerlukan pengobatan jangka panjang, dan berdampak pada dimensi fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi keluarga secara bersamaan.

Friedman et al., (2003) menyebutkan bahwa tugas keluarga dalam keperawatan keluarga ada 5 tugas utama diantaranya; (1) Mengetahui masalah kesehatan keluarga yaitu Keluarga mampu mengenali tanda, gejala, penyebab, serta dampak masalah kesehatan yang dialami anggota keluarga, (2) Mengambil

keputusan mengenai tindakan kesehatan yang tepat yaitu Keluarga dapat menentukan tindakan yang sesuai untuk mengatasi masalah kesehatan, termasuk memanfaatkan pelayanan kesehatan, (3) Merawat anggota keluarga yang sakit yaitu Keluarga memberikan perawatan langsung, dukungan emosional, pengawasan pengobatan, serta membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari anggota keluarga yang sakit, (4) Memodifikasi lingkungan keluarga agar menunjang kesehatan yaitu Keluarga menjaga lingkungan fisik maupun psikologis agar mendukung proses penyembuhan dan mencegah penularan penyakit. (5) Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yaitu Keluarga mampu menggunakan layanan kesehatan secara optimal, seperti puskesmas, rumah sakit, posyandu, atau layanan kesehatan lainnya.

Tugas pertama adalah kemampuan mengenal masalah kesehatan. Keluarga diharapkan mampu mengidentifikasi tanda dan gejala TB Paru secara dini, memahami faktor risiko, serta menyadari bahwa TB Paru bukan penyakit yang memalukan melainkan penyakit yang dapat disembuhkan. Keterlambatan dalam pengenalan masalah menyebabkan penundaan diagnosis yang pada gilirannya memperparah kondisi pasien dan memperluas rantai penularan. Perilaku keluarga dalam pencegahan TB paru sangat berperan penting dalam mengurangi resiko penularan TB paru. Meningkatnya penderita TB Paru di Indonesia disebabkan oleh perilaku hidup yang tidak sehat. Hasil survey di Indonesia oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) salah satu penyebab 4 tingginya angka kejadian TB Paru di sebabkan oleh kurangnya tingkat pengetahuan (H et al., 2024).

Pengetahuan keluarga akan penularan penyakit TB paru menjadi faktor utama belum terlaksananya peran keluarga dalam bidang kesehatan dengan baik. Oleh karena itu pendidikan kesehatan bagi keluarga penting untuk dijadikan prioritas dalam pendekatan dengan anggota keluarga dengan TB Paru secara khusus tentang menjaga lingkungan keluarga yang bersih yang menjadi awal pencegahan penularan penyakit TB Paru yang efektif, karena keluarga merupakan sistem atau unit terkecil dari masyarakat yang mempunyai komitmen dan keterikatan antar anggota keluarga yang senantiasa saling ketergantungan meliputi kewajiban yang sekarang hingga kewajiban dimasa yang akan datang (Carabali-Isajar et al., 2023). Maria, (2020);Sugion et al., (2022) menemukan ada hubungan antara pengetahuan keluarga dengan pencegahan penularan tuberkulosis paru. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga yang memiliki pengetahuan yang baik juga memiliki upaya pencegahan tuberkulosis yang tinggi daripada keluarga dengan pengetahuan yang kurang (Maria, 2020).

Tugas keluarga kedua dalam keperawatan keluarga menurut Friedman et al., (2003) adalah kemampuan keluarga dalam membuat keputusan kesehatan yang tepat bagi anggota keluarga yang sakit. Dalam perawatan pasien TB Paru di rumah, kemampuan pengambilan keputusan keluarga menjadi sangat penting karena menentukan ketepatan tindakan keluarga dalam mengenali gejala, mencari pertolongan kesehatan, mendukung pengobatan, serta mencegah penularan penyakit kepada anggota keluarga lain. Keluarga dengan tingkat pendidikan dan akses informasi yang baik cenderung lebih cepat mengenali tanda TB Paru seperti batuk lebih dari dua minggu, penurunan berat badan, demam, dan sesak napas sehingga segera membawa pasien ke fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan dan pengobatan. Sebaliknya, rendahnya pengetahuan dan kuatnya kepercayaan budaya tertentu dapat menyebabkan keterlambatan diagnosis serta penghentian pengobatan sebelum waktunya (Sudirman et al., 2020).

Proses pengambilan keputusan dalam keluarga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk struktur kekuasaan keluarga, kepercayaan budaya tentang penyakit, tingkat pendidikan, dan akses informasi. Pada konteks TB Paru, keputusan kritis yang harus dibuat keluarga meliputi: proses pengambilan keputusan keluarga dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan keluarga, dukungan emosional, struktur peran dalam keluarga, kepercayaan budaya mengenai penyakit, dan akses terhadap informasi kesehatan. Keluarga yang memiliki pengetahuan dan dukungan yang baik cenderung lebih mampu mengambil keputusan kesehatan yang efektif, seperti mengingatkan pasien minum obat secara teratur, membawa pasien kontrol rutin, serta menerapkan etika batuk dan penggunaan masker di rumah. Dukungan keluarga juga terbukti meningkatkan kepatuhan pengobatan pasien TB Paru secara signifikan (Jang & Lee, 2022). Selain itu, dukungan keluarga yang baik terbukti berhubungan dengan meningkatnya kepatuhan pengobatan pasien TB Paru dan keberhasilan terapi. Sebaliknya, pengambilan keputusan yang kurang tepat dapat menyebabkan putus obat, resistensi obat, perburukan kondisi pasien, dan meningkatnya risiko penularan TB di lingkungan rumah maupun Masyarakat (Khafid et al., 2024). Pengambilan keputusan yang tepat dapat membantu mempercepat diagnosis dan meningkatkan keberhasilan pengobatan TB Paru. Sebaliknya, keputusan yang kurang tepat, seperti menunda pemeriksaan atau menghentikan pengobatan sebelum waktunya, dapat menyebabkan perburukan kondisi pasien serta meningkatkan risiko penularan TB kepada anggota keluarga lain (Rachmawati et al., 2022).

Tugas ketiga adalah kemampuan merawat anggota keluarga yang sakit. Pada pasien TB Paru, tugas ini sangat penting karena proses pengobatan TB membutuhkan waktu yang panjang, kepatuhan terapi yang tinggi, serta pengawasan yang konsisten di rumah. Kemampuan keluarga dalam merawat pasien TB Paru meliputi membantu pemenuhan kebutuhan fisik pasien, mengingatkan minum obat anti tuberkulosis (OAT) secara teratur, menjaga nutrisi pasien, memberikan dukungan emosional, menerapkan etika batuk, menjaga ventilasi rumah, serta mencegah penularan kepada anggota keluarga lain. Keluarga juga berperan dalam memantau kondisi pasien dan membawa pasien kontrol rutin ke fasilitas kesehatan. Apabila keluarga tidak mampu menjalankan tugas perawatan dengan baik, maka risiko putus obat, kekambuhan, resistensi obat, dan penularan TB akan meningkat (Kristinawati et al., 2019). Keterlibatan keluarga dalam perawatan pasien TB Paru memiliki hubungan yang signifikan dengan keberhasilan pengobatan dan kualitas hidup pasien. (Nursasi et al., 2021) menjelaskan bahwa keluarga yang merawat pasien TB memiliki kebutuhan dukungan informasi, emosional, instrumental, dan penghargaan selama proses pengobatan. Penelitian tersebut menekankan bahwa kemampuan keluarga dalam merawat pasien, termasuk mendorong kepatuhan pengobatan dan memantau perilaku kesehatan pasien, menjadi bagian penting dalam keberhasilan terapi TB Paru.

Tambunan, (2023) menjelaskan bahwa keluarga merupakan *caregiver* utama dalam perawatan pasien TB di rumah. Keluarga memberikan dukungan fisik dan psikologis, membantu pencegahan penularan, serta memastikan pasien menjalani pengobatan secara teratur. Hasil penelitian Rumokoya & Rumokoy, (2026) menjelaskan bahwa dukungan keluarga berhubungan dengan peningkatan kepatuhan pengobatan, pencegahan kekambuhan, dan penurunan angka rawat ulang pasien TB Paru. Keluarga yang aktif dalam perawatan pasien mampu membantu pasien mempertahankan motivasi selama terapi yang berlangsung lama.

Tugas keempat adalah kemampuan memodifikasi lingkungan untuk menjamin kesehatan. Lingkungan fisik rumah yang kondusif sangat berperan dalam proses kesembuhan penderita TB sekaligus melindungi anggota keluarga lain dari risiko penularan. Modifikasi yang diperlukan mencakup: peningkatan ventilasi dan pencahayaan alami, pemisahan kamar tidur penderita, pembersihan dan desinfeksi permukaan secara rutin, serta penyediaan masker dan alat perlindungan diri. Keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas sering menghadapi kendala dalam melakukan modifikasi lingkungan ini, sehingga

intervensi keperawatan perlu mempertimbangkan aspek feasibility dan konteks sosioekonomik keluarga.

Pada pasien TB Paru, keluarga berperan penting dalam menciptakan lingkungan rumah yang sehat untuk mencegah penularan penyakit dan mendukung proses penyembuhan pasien. Bentuk modifikasi lingkungan yang dapat dilakukan meliputi menjaga ventilasi rumah, meningkatkan pencahayaan alami, menjaga kebersihan rumah, mengurangi kepadatan hunian, menerapkan etika batuk, dan menggunakan masker. Penelitian internasional menunjukkan bahwa pengendalian lingkungan melalui ventilasi dan kebersihan rumah efektif dalam menurunkan risiko penularan TB serta meningkatkan kesehatan pasien TB Paru (Suprajitno et al., 2022). Lee, (2016) menjelaskan bahwa ventilasi yang baik merupakan komponen utama pengendalian penularan TB karena mampu mengurangi partikel infeksius di udara. Ventilasi alami dan pencahayaan yang cukup menjadi langkah efektif dan ekonomis dalam mencegah penyebaran TB di lingkungan rumah maupun fasilitas kesehatan.

Suprajitno et al., (2022) mengemukakan bahwa lingkungan rumah (*home environment*) dan upaya pencegahan keluarga merupakan faktor penting yang memengaruhi status kesehatan pasien TB. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keluarga yang mampu memodifikasi lingkungan rumah dan menerapkan perilaku pencegahan penularan memiliki kontribusi terhadap peningkatan kondisi kesehatan pasien TB Paru. Hasil penelitian dari Nursasi et al., (2021) mengemukakan bahwa Kebutuhan keluarga yang merawat pasien TB Paru yaitu membutuhkan dukungan informasi terkait cara menjaga lingkungan rumah tetap sehat selama proses pengobatan TB. Keluarga memerlukan edukasi tentang ventilasi, kebersihan rumah, pencegahan penularan, dan perilaku hidup sehat agar mampu menjalankan perawatan pasien TB secara optimal di rumah.

Tugas kelima adalah kemampuan menggunakan fasilitas kesehatan secara optimal. Keluarga perlu dimotivasi untuk memanfaatkan berbagai layanan kesehatan yang tersedia, tidak hanya untuk pengobatan kuratif tetapi juga preventif dan rehabilitatif. Hambatan dalam pemanfaatan fasilitas kesehatan dapat bersifat geografis (jarak), ekonomis (biaya transportasi dan non-transportasi), maupun psikososial (stigma dan rasa malu). Pendampingan keluarga dalam navigasi sistem layanan kesehatan menjadi salah satu peran kunci perawat komunitas (Stanhope & Lancaster, 2020).

Pada tugas keluarga yang kelima ini menunjukkan terkait kemampuan keluarga untuk mengenali dan memanfaatkan sumber pelayanan kesehatan yang tersedia guna mempertahankan, meningkatkan, dan memulihkan status kesehatan

anggota keluarga yang sakit. Penanganan pada pasien TB Paru, kemampuan menggunakan fasilitas kesehatan secara optimal menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pengobatan, karena terapi TB memerlukan pengobatan jangka panjang, pemantauan rutin, serta keterlibatan aktif tenaga kesehatan dan keluarga selama proses terapi berlangsung.

Pada pasien TB Paru, keluarga memiliki peran penting dalam memanfaatkan berbagai fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, klinik DOTS (*Directly Observed Treatment Short-course*), laboratorium pemeriksaan sputum, hingga layanan konsultasi kesehatan. Bentuk penggunaan fasilitas kesehatan yang optimal meliputi membawa pasien melakukan pemeriksaan saat muncul gejala TB seperti batuk lebih dari dua minggu, mendampingi pasien kontrol rutin, mengambil obat anti tuberkulosis (OAT) secara teratur, memanfaatkan layanan edukasi kesehatan, serta berkonsultasi mengenai efek samping pengobatan dan pencegahan penularan TB di rumah. Pemanfaatan fasilitas kesehatan yang baik memungkinkan pasien memperoleh diagnosis lebih cepat, terapi yang tepat, serta pemantauan kondisi kesehatan secara berkelanjutan sehingga risiko komplikasi dan penularan dapat diminimalisir (Nindrea et al., 2025).

Penggunaan fasilitas kesehatan secara optimal pada pasien TB Paru juga sangat berkaitan dengan kepatuhan pengobatan. Pengobatan TB membutuhkan waktu minimal enam bulan sehingga pasien sering mengalami kejenuhan, efek samping obat, maupun penurunan motivasi untuk melanjutkan terapi. Dalam kondisi tersebut, keluarga berperan sebagai pendukung utama yang membantu pasien tetap terhubung dengan pelayanan kesehatan. Keluarga dapat mengingatkan jadwal kontrol, membantu transportasi menuju fasilitas kesehatan, memastikan obat diminum sesuai jadwal, serta berkomunikasi dengan tenaga kesehatan ketika muncul masalah selama pengobatan. Hasil penelitian Nindrea et al., (2025) menunjukkan bahwa dukungan keluarga memiliki hubungan signifikan dengan kepatuhan pengobatan TB ($\beta = 0.229$; $p = 0.006$). Penelitian tersebut menjelaskan bahwa keluarga yang aktif mendukung penggunaan fasilitas kesehatan mampu meningkatkan motivasi pasien untuk menyelesaikan terapi TB hingga tuntas.

Selain itu, penggunaan fasilitas kesehatan yang optimal membantu keluarga memperoleh edukasi mengenai perawatan pasien TB Paru di rumah. Edukasi tersebut mencakup cara pencegahan penularan, etika batuk, penggunaan masker, pentingnya ventilasi rumah, pemenuhan nutrisi pasien, serta pengawasan efek samping OAT. Pengetahuan yang diperoleh dari tenaga kesehatan akan meningkatkan kemampuan keluarga dalam merawat pasien TB secara mandiri di

rumah. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengobatan, tetapi juga sebagai sumber informasi dan dukungan psikososial bagi pasien dan keluarga. Penelitian Nursasi et al., (2021) menjelaskan bahwa keluarga pasien TB membutuhkan akses informasi kesehatan yang memadai agar mampu menjalankan perawatan pasien secara optimal dan mencegah terjadinya penularan di lingkungan keluarga.

Pemanfaatan fasilitas kesehatan juga berkaitan dengan keberhasilan program pengendalian TB secara nasional maupun global. Program DOTS menekankan pentingnya keteraturan kontrol, pengawasan minum obat, dan evaluasi sputum secara berkala. Keluarga yang mampu menggunakan fasilitas kesehatan dengan baik cenderung memiliki anggota keluarga yang lebih patuh menjalani terapi dan memiliki angka kesembuhan yang lebih tinggi. Sebaliknya, keterbatasan akses fasilitas kesehatan, rendahnya pengetahuan keluarga, stigma terhadap TB, serta kondisi ekonomi yang kurang mendukung dapat menyebabkan keterlambatan pemeriksaan, putus obat, hingga resistensi obat (*Multi Drug Resistant Tuberculosis/MDR-TB*). Kondisi tersebut tidak hanya memperburuk keadaan pasien tetapi juga meningkatkan risiko penularan TB di Masyarakat (Rahmah et al., 2025).

Ferlia et al., (2025) mengemukakan bahwa pendekatan *family-centered care* dapat meningkatkan kualitas hidup pasien TB Paru dan membantu keberhasilan terapi. Keterlibatan keluarga dalam penggunaan fasilitas kesehatan membuat pasien merasa lebih didukung secara emosional dan lebih termotivasi untuk mengikuti pengobatan secara teratur. Keluarga menjadi penghubung antara pasien dan tenaga kesehatan dalam proses pemantauan kondisi pasien selama terapi berlangsung. Oleh karena itu, tugas keluarga kelima memiliki hubungan yang sangat erat dengan keberhasilan perawatan pasien TB Paru di rumah maupun di fasilitas pelayanan kesehatan.

Dengan demikian, kemampuan keluarga dalam menggunakan fasilitas kesehatan secara optimal merupakan komponen penting dalam perawatan pasien TB Paru. Keluarga yang mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan dengan baik akan membantu mempercepat diagnosis, meningkatkan kepatuhan pengobatan, mencegah komplikasi dan resistensi obat, serta menurunkan risiko penularan TB di lingkungan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu memberikan edukasi dan pendampingan kepada keluarga agar mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan secara efektif selama proses pengobatan TB berlangsung (Falah et al., 2025).

C. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Keluarga dalam Merawat Pasien TB Paru

Tuberkulosis (TB) paru merupakan penyakit infeksi menular yang masih menjadi masalah kesehatan global, terutama di negara berkembang. Keberhasilan pengobatan TB paru tidak hanya dipengaruhi oleh terapi farmakologis, tetapi juga dipengaruhi oleh keterlibatan keluarga dalam menjalankan tugas kesehatan keluarga. Menurut Friedman, keluarga memiliki peran penting dalam mengenali masalah kesehatan, mengambil keputusan kesehatan, merawat anggota keluarga yang sakit, memodifikasi lingkungan, dan memanfaatkan fasilitas kesehatan secara optimal. Dalam konteks TB paru, keberhasilan keluarga menjalankan tugas tersebut sangat menentukan kepatuhan pengobatan, pencegahan penularan, dan keberhasilan terapi pasien.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan keluarga dalam merawat pasien TB paru adalah tingkat pengetahuan keluarga mengenai penyakit TB. Pengetahuan keluarga tentang tanda dan gejala TB, cara penularan, pentingnya kepatuhan pengobatan, serta pencegahan penularan akan memengaruhi kemampuan keluarga dalam memberikan perawatan yang tepat kepada pasien. Keluarga yang memiliki pengetahuan baik cenderung lebih mampu mendukung pasien menjalani terapi secara rutin, mengingatkan jadwal minum obat, serta menerapkan perilaku pencegahan penularan di rumah. Hasil penelitian Putri et al., (2021) menunjukkan bahwa pengetahuan dan dukungan keluarga memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku pasien dan kepatuhan pengobatan TB paru.

Faktor berikutnya adalah dukungan sosial. Beberapa intervensi menunjukkan bahwa aspek psikologis berupa dukungan sosial yang mencakup dukungan keluarga, dukungan sesama, dukungan dari tenaga kesehatan, dan dukungan dari masyarakat sekitar dapat meningkatkan kepatuhan (Deshmukh dkk., 2018; Barik et al., 2020). Menurut Friedman et al., (2003), dukungan keluarga merupakan salah satu faktor yang mendukung kepatuhan pasien terhadap pengobatan yang dijalankan. Keluarga berperan sebagai sistem pendukung bagi anggota keluarga yang sakit, sehingga selalu siap memberikan bantuan dan dukungan jika diperlukan. Memiliki keluarga dan berada dalam lingkungan keluarga yang harmonis membuat pasien TB merasa didukung, nyaman, yakin akan kesembuhan, serta meningkatkan kepatuhan (B. Chen dkk., 2016; Barik et al., 2020).

Dukungan keluarga meliputi dukungan emosional, instrumental, informasional, dan penghargaan kepada pasien selama menjalani pengobatan TB (Penny et al., 1997; Barik et al., 2020). Dukungan emosional dapat berupa

perhatian, motivasi, dan empati kepada pasien agar tetap semangat menjalani terapi jangka panjang. Dukungan instrumental meliputi bantuan finansial, pengantaran ke fasilitas kesehatan, serta membantu memenuhi kebutuhan nutrisi pasien. Dukungan keluarga yang baik dapat meningkatkan motivasi pasien untuk menyelesaikan pengobatan hingga tuntas. Dukungan informasi yang diberikan pada masa-masa stres dapat menjadi solusi dalam pemecahan masalah. Penelitian yang dilakukan oleh (Arifin et al., 2019; Barik et al., 2020) menunjukkan bahwa dukungan informasi yang diberikan oleh keluarga berkorelasi dengan meningkatnya motivasi untuk sembuh dan perilaku patuh pada pasien TB. Proses penyelesaian rejimen pengobatan TB berlangsung selama 6-8 bulan. Lamanya masa pengobatan ini sering kali membuat pasien merasa bosan, putus asa, dan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Namun, hal ini dapat dicegah dengan dukungan berupa penghargaan yang diberikan oleh sistem pendukung pasien. Dukungan apresiasi yang dirasakan oleh pasien, yang ditunjukkan melalui dorongan, motivasi untuk sembuh, dan bantuan selama masa pengobatan, berkorelasi dengan kepatuhan pasien terhadap rejimen pengobatan (Ainiyah et al., 2019; Barik et al., 2020). Penelitian Nindrea et al., (2025) menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara dukungan keluarga dan kepatuhan pengobatan TB ($\beta = 0.229$; $p = 0.006$). Dukungan keluarga juga meningkatkan motivasi pasien untuk menjalani pengobatan secara teratur.

Selain dukungan keluarga, ketahanan keluarga (*family resilience*) juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan perawatan pasien TB paru. Ketahanan keluarga mencerminkan kemampuan keluarga dalam menghadapi stres, masalah ekonomi, stigma sosial, dan tantangan selama proses pengobatan TB. Pengobatan TB yang berlangsung lama sering menimbulkan tekanan psikologis pada keluarga sehingga keluarga memerlukan kemampuan adaptasi dan pemecahan masalah yang baik. Penelitian (Rachmawati et al., 2022) menunjukkan bahwa ketahanan keluarga berpengaruh terhadap kepatuhan pengobatan pasien TB paru. Kemampuan keluarga dalam coping dan pemecahan masalah membantu keluarga tetap memberikan dukungan optimal kepada pasien selama terapi berlangsung.

Faktor sosial ekonomi juga memengaruhi keberhasilan keluarga dalam menjalankan tugas kesehatan keluarga. Keluarga dengan kondisi ekonomi yang baik cenderung lebih mudah memenuhi kebutuhan nutrisi pasien, biaya transportasi menuju fasilitas kesehatan, serta kebutuhan penunjang lainnya selama pengobatan TB. Sebaliknya, keterbatasan ekonomi dapat menyebabkan pasien terlambat kontrol, kesulitan memenuhi kebutuhan nutrisi, bahkan berisiko putus obat. Penelitian Nadon et al., (2023) mengemukakan bahwa tingkat pendapatan

keluarga, pekerjaan kepala keluarga, dan tingkat pendidikan keluarga berhubungan dengan tingkat dukungan keluarga pada pasien TB paru.

Tingkat pendidikan keluarga juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan perawatan pasien TB paru. Pendidikan yang lebih tinggi memudahkan keluarga memahami informasi kesehatan, mengikuti edukasi dari tenaga kesehatan, dan menerapkan perilaku kesehatan yang tepat dalam perawatan pasien TB. Keluarga dengan tingkat pendidikan baik umumnya lebih mudah menerima informasi mengenai pentingnya kepatuhan pengobatan, pencegahan penularan, serta penggunaan fasilitas kesehatan secara optimal. Sebaliknya, rendahnya tingkat pendidikan dapat menyebabkan kesalahan persepsi mengenai penyakit TB dan menghambat proses pengobatan pasien (Nadon et al., 2023).

Faktor psikologis juga memengaruhi keberhasilan keluarga dalam menjalankan tugas keluarga. Pasien TB paru sering mengalami stres, kecemasan, bahkan stigma sosial akibat penyakit yang dideritanya. Kondisi tersebut dapat memengaruhi motivasi pasien untuk menjalani pengobatan. Dalam situasi ini, keluarga berperan sebagai sumber dukungan psikologis utama bagi pasien. Penelitian mengenai hubungan dukungan keluarga dan stres keluarga pada pasien TB paru menunjukkan bahwa dukungan keluarga yang baik mampu menurunkan tingkat stres pasien dan meningkatkan kualitas hidup pasien selama pengobatan (Suarnianti et al., 2023).

Keberhasilan keluarga dalam merawat pasien TB paru juga dipengaruhi oleh akses terhadap fasilitas kesehatan dan informasi kesehatan. Keluarga yang mudah mengakses fasilitas kesehatan akan lebih cepat membawa pasien melakukan pemeriksaan, kontrol rutin, dan memperoleh edukasi kesehatan mengenai TB. Selain itu, tenaga kesehatan juga berperan penting dalam memberikan pendampingan dan edukasi kepada keluarga terkait perawatan pasien TB di rumah. Penelitian Nursasi et al., (2021) menjelaskan bahwa keluarga pasien TB membutuhkan dukungan informasi terkait pengobatan, pemantauan perilaku kesehatan pasien, dan cara mendorong pasien agar menyelesaikan terapi pengobatan secara lengkap.

Lingkungan sosial dan budaya keluarga juga memengaruhi keberhasilan perawatan pasien TB paru. Di beberapa masyarakat, TB masih dianggap sebagai penyakit yang memalukan sehingga pasien dan keluarga sering mengalami stigma sosial. Kondisi tersebut menyebabkan keluarga cenderung menutupi penyakit pasien dan enggan memanfaatkan layanan kesehatan secara optimal. Sebaliknya, lingkungan sosial yang suportif akan membantu keluarga lebih terbuka dalam

mencari bantuan kesehatan dan mendukung pasien selama pengobatan (Rachmawati et al., 2022).

Selain itu, keterlibatan keluarga sebagai caregiver utama sangat memengaruhi keberhasilan pengobatan TB paru. Keluarga yang aktif dalam mengawasi minum obat, menjaga pola makan pasien, membantu kebutuhan sehari-hari, dan memberikan motivasi psikologis terbukti mampu meningkatkan keberhasilan terapi pasien TB. Penelitian fenomenologi mengenai peran keluarga sebagai caregiver menunjukkan bahwa keluarga memberikan dukungan fisik, emosional, dan sosial dalam proses perawatan pasien TB paru di rumah (Kristinawati et al., 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan keluarga dalam menjalankan tugas kesehatan keluarga untuk merawat pasien TB paru dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pengetahuan keluarga, dukungan keluarga, ketahanan keluarga, kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan, faktor psikologis, akses fasilitas kesehatan, lingkungan sosial budaya, dan keterlibatan keluarga sebagai caregiver. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan kemampuan keluarga memberikan perawatan yang optimal kepada pasien TB paru. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis keluarga dalam program pengendalian TB melalui edukasi kesehatan, pendampingan keluarga, penguatan dukungan psikososial, dan peningkatan akses pelayanan kesehatan agar keberhasilan pengobatan TB dapat tercapai secara optimal.

D. Hambatan Keluarga dalam Menjalankan Tugas Perawatan Pasien TB Paru

Tuberkulosis (TB) paru masih menjadi salah satu masalah kesehatan global dengan angka kejadian dan kematian yang tinggi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Keberhasilan pengobatan TB paru tidak hanya dipengaruhi oleh kepatuhan pasien dalam menjalani terapi, tetapi juga sangat bergantung pada kemampuan keluarga dalam menjalankan tugas kesehatan keluarga. Menurut teori Friedman, keluarga memiliki lima tugas kesehatan, yaitu mengenal masalah kesehatan, mengambil keputusan kesehatan yang tepat, merawat anggota keluarga yang sakit, memodifikasi lingkungan, dan memanfaatkan fasilitas kesehatan secara optimal. Namun, dalam praktiknya banyak keluarga mengalami hambatan dalam menjalankan tugas tersebut sehingga memengaruhi keberhasilan perawatan pasien TB paru di rumah.

Salah satu hambatan utama keluarga dalam menjalankan tugas kesehatan adalah rendahnya pengetahuan mengenai TB paru. Banyak keluarga belum memahami tanda dan gejala TB, cara penularan, pentingnya kepatuhan

pengobatan, maupun risiko penghentian terapi sebelum waktunya. Rendahnya pengetahuan menyebabkan keluarga terlambat mengenali kondisi pasien dan menunda membawa pasien ke fasilitas kesehatan. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang pengobatan TB menyebabkan keluarga kesulitan mengawasi kepatuhan minum obat pasien selama terapi berlangsung. Penelitian oleh Nindrea et al. (2025) menunjukkan bahwa dukungan keluarga dan motivasi sangat berhubungan dengan kepatuhan pengobatan pasien TB. Keluarga yang memiliki pemahaman dan dukungan yang baik cenderung lebih mampu membantu pasien menjalani terapi secara teratur (Nindrea et al., 2025).

Hambatan berikutnya adalah stigma sosial dan kepercayaan budaya terhadap penyakit TB. Di beberapa masyarakat, TB masih dianggap sebagai penyakit memalukan, penyakit kutukan, atau penyakit yang berhubungan dengan kondisi sosial tertentu. Stigma tersebut membuat keluarga merasa malu apabila ada anggota keluarga yang menderita TB sehingga memilih menyembunyikan penyakit pasien dari lingkungan sekitar. Akibatnya, pasien sering terlambat mendapatkan pengobatan dan tidak menjalani kontrol rutin ke fasilitas kesehatan. Penelitian *Barriers and Strategies to Successful Tuberculosis Treatment in a High-Burden Tuberculosis Setting* menjelaskan bahwa stigma sosial menjadi salah satu faktor utama yang menghambat keberhasilan pengobatan TB karena pasien dan keluarga cenderung menarik diri dari lingkungan sosial dan menghindari pelayanan kesehatan (Pradipta et al., 2021).

Selain faktor pengetahuan dan stigma, kondisi ekonomi keluarga juga menjadi kendala penting dalam perawatan pasien TB paru. Pengobatan TB memang tersedia secara gratis melalui program pemerintah, tetapi keluarga tetap menghadapi biaya tidak langsung seperti transportasi ke fasilitas kesehatan, kehilangan pendapatan akibat pasien tidak dapat bekerja, kebutuhan nutrisi tambahan, dan biaya perawatan lainnya. Kondisi ekonomi yang rendah menyebabkan keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan nutrisi pasien serta mempertahankan keteraturan kontrol pengobatan. Hambatan ekonomi juga dapat meningkatkan risiko pasien putus obat karena keluarga lebih memprioritaskan kebutuhan sehari-hari dibandingkan pengobatan jangka panjang. Penelitian dalam *Indian Journal of Tuberculosis* menyebutkan bahwa kesulitan ekonomi dan keterbatasan akses pelayanan kesehatan merupakan hambatan utama dalam manajemen perawatan diri pasien TB.

Hambatan psikologis juga sering dialami keluarga dalam merawat pasien TB paru. Proses pengobatan TB yang berlangsung lama, minimal enam bulan, dapat menyebabkan kelelahan emosional pada pasien maupun keluarga. Keluarga sering

merasa stres, cemas, takut tertular, bahkan mengalami kelelahan dalam mendampingi pasien menjalani terapi setiap hari. Penelitian *Exploring the Experiences of Family Caregivers Caring for Patient with Tuberculosis at Home* menunjukkan bahwa keluarga yang merawat pasien TB di rumah menghadapi tantangan psikologis, sosial, dan praktis selama proses pengobatan. Beberapa keluarga mengalami ketakutan terhadap penularan, kesulitan menjaga motivasi pasien, dan merasa terbebani oleh tanggung jawab perawatan jangka panjang (Tambunan, 2023).

Faktor lain yang menjadi kendala adalah keterbatasan akses informasi dan fasilitas kesehatan. Tidak semua keluarga memiliki akses yang mudah terhadap layanan kesehatan, terutama keluarga yang tinggal di daerah terpencil. Jarak yang jauh, keterbatasan transportasi, dan kurangnya edukasi kesehatan menyebabkan keluarga kesulitan memanfaatkan fasilitas kesehatan secara optimal. Kondisi tersebut dapat menyebabkan keterlambatan diagnosis, ketidakpatuhan kontrol rutin, dan rendahnya pengawasan pengobatan pasien TB. Keterbatasan dukungan keluarga, rendahnya literasi kesehatan, dan kurangnya edukasi menjadi faktor yang menghambat kepatuhan perawatan diri pasien TB (Falah et al., 2025).

Dalam menjalankan tugas memodifikasi lingkungan rumah, keluarga juga menghadapi berbagai kendala. Banyak rumah pasien TB memiliki ventilasi yang buruk, pencahayaan kurang memadai, dan kondisi hunian yang padat sehingga meningkatkan risiko penularan TB kepada anggota keluarga lain. Keterbatasan ekonomi sering membuat keluarga sulit memperbaiki kondisi rumah agar sesuai dengan standar rumah sehat. Selain itu, beberapa keluarga belum memahami pentingnya etika batuk, penggunaan masker, serta pemisahan alat pribadi pasien selama masa infeksi aktif. Kondisi lingkungan rumah yang tidak sehat menyebabkan rantai penularan TB sulit diputus.

Hambatan lain adalah rendahnya dukungan sosial dan keterlibatan keluarga dalam proses pengobatan. Tidak semua anggota keluarga mampu memberikan dukungan emosional, instrumental, maupun motivasi kepada pasien TB. Sebagian keluarga justru menjauhi pasien karena takut tertular. Padahal, dukungan keluarga sangat berperan dalam meningkatkan motivasi pasien untuk menyelesaikan pengobatan.

Berdasarkan berbagai hambatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala keluarga dalam menjalankan tugas kesehatan pada perawatan pasien TB paru dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, stigma sosial, kondisi ekonomi, psikologis, akses fasilitas kesehatan, lingkungan rumah, dan dukungan sosial keluarga. Hambatan-hambatan tersebut dapat menyebabkan keterlambatan diagnosis,

ketidakpatuhan pengobatan, resistensi obat, hingga peningkatan penularan TB di lingkungan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan edukasi kesehatan yang berkelanjutan, pendampingan keluarga, peningkatan akses pelayanan kesehatan, serta pendekatan berbasis keluarga dalam program pengendalian TB agar keluarga mampu menjalankan tugas kesehatannya secara optimal.

E. Simpulan

Keluarga memainkan peran penting dalam merawat anggota keluarga yang sakit, dan salah satu fungsi keluarga adalah perawatan kesehatan. Keluarga sebagai sebuah kelompok dapat menyebabkan, mencegah, mengabaikan, atau mengatasi masalah kesehatan dalam kelompok tersebut. Masalah kesehatan dalam keluarga saling terkait dan jika salah satu anggota sakit, hal itu akan memengaruhi anggota keluarga lainnya dan juga akan memengaruhi masyarakat sekitarnya. Selain menjalankan peran penting, keluarga juga memiliki 5 (lima) tugas utama dalam melaksanakan keperawatan keluarga, diantaranya (1) keluarga mampu mengenal masalah kesehatan keluarga, (2) keluarga mampu mengambil keputusan mengenai tindakan kesehatan yang tepat, (3) keluarga mampu merawat anggota keluarga yang sakit, (4) keluarga mampu memodifikasi lingkungan keluarga agar menunjang kesehatan, (5) keluarga mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan.

Salah satu faktor kepatuhan pengobatan TB Paru dipengaruhi oleh keberhasilan keluarga dalam melaksanakan tugas kesehatan keluarga. keberhasilan keluarga dalam menjalankan tugas kesehatan keluarga untuk merawat pasien TB paru dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pengetahuan keluarga, dukungan keluarga, ketahanan keluarga, kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan, faktor psikologis, akses fasilitas kesehatan, lingkungan sosial budaya, dan keterlibatan keluarga sebagai *caregiver*. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan kemampuan keluarga memberikan perawatan yang optimal kepada pasien TB paru. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis keluarga dalam program pengendalian TB melalui edukasi kesehatan, pendampingan keluarga, penguatan dukungan psikososial, dan peningkatan akses pelayanan kesehatan agar keberhasilan pengobatan TB dapat tercapai secara optimal.

Menjalankan peran dan tugas keluarga khususnya tugas keluarga dalam perawatan pada anggota TB Paru tidak mudah dan menemui beberapa kendala. kendala keluarga dalam menjalankan tugas kesehatan pada perawatan pasien TB

paru dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, stigma sosial, kondisi ekonomi, psikologis, akses fasilitas kesehatan, lingkungan rumah, dan dukungan sosial keluarga. Hambatan-hambatan tersebut dapat menyebabkan keterlambatan diagnosis, ketidakpatuhan pengobatan, resistensi obat, hingga peningkatan penularan TB di lingkungan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan edukasi kesehatan yang berkelanjutan, pendampingan keluarga, peningkatan akses pelayanan kesehatan, serta pendekatan berbasis keluarga dalam program pengendalian TB agar keluarga mampu menjalankan tugas kesehatannya secara optimal.

F. Referensi

- Ainiyah, S. N., Soedarsono, & Umiastuti, P. (2019). The Relationship between Family ' s Assessment Support and MDR TB Patient ' s Adherence on Treatment in RSUD Dr . Soetomo Surabaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kedokteran Universitas Airlangga*, 02.
- Arifin, V. N., Juariah, Nur, A., & Uzair, F. M. (2019). The Relationship of Social Support with Medication Adherence Pulmonary Tuberculosis Patients Through DOTS Strategy in Pidie Aceh Indonesia The Relationship of Social Support with Medication Adherence Pulmonary Tuberculosis Patients Through DOTS Strategy i. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/469/1/012055>
- Barik, A. L., Indarwati, R., & Sulistiawati, S. (2020). The Role of Social Support on Treatment Adherence in TB Patients : A Systematic Review. *Nurse and Health: Jurnal Keperawatan*, 9(2), 201–210. <https://doi.org/https://doi.org/10.36720/nhjk.v9i2.186>
- Carabalí-Isajar, M. L., Bejarano, O. H. R., Amado, T., Patarroyo, M. A., Izquierdo, M. A., Lutz, J. R., & Ocampo, M. (2023). Clinical Manifestations and Immune Response to Tuberculos. *World Journal of Microbiology and Biotechnology*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11274-023-03636-x>
- Duvall, E. M., & Miller, B. C. (1977). *Marriage and Family Development* (5th ed.). Lippincott.
- Falah, M., Sansuwito, T., Dioso, R. I. I. I., & Said, F. M. (2025). Enhancing Self-Care Adherence in Tuberculosis Patients through Family Support: A Systematic Review. *International Journal of Public Health Science (IJPHS)*, 14(2), 661–671. <https://doi.org/10.11591/ijphs.v14i2.24749>
- Ferlia, R., Palupi, R., Kusuma, A., & Kameliawati, F. (2025). Hubungan Family Centered Care dan Kepatuhan Terapi dengan Kualitas Hidup pada

- Pasien TB Paru. *Wiraraja Medika: Jurnal Kesehatan*, 15(2), 34–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.24929/fik.v15i2.3521>
- Friedman, M. M. (1998). *Family Nursing: Research, Theory, and Practice Ed. 4* (4th). Connecticut: Appleton and Lange.
- Friedman, Marilyn M., Bowden, V. R., & Jones, E. G. (2003). *Family Nursing, Research, Theory, & Practice* (5th ed.). Prentice Hall.
- H, T. M., Maryono, & Husaini, M. (2024). HUBUNGAN PENGETAHUAN KELUARGA DENGAN TINDAKAN PENCEGAHAN PENULARAN TB PARU DI WILAYAH KERJA UPTD PUSKESMAS SIMPANG KNAN KABUPATEN ACEH SINGKIL. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(9), 4541–4547.
- Herdman, T. H., Kamitsuru, S., & Lopes, C. T. (2021). *NANDA International nursing diagnoses: Definitions and classification 2021-2023* (Twelfth Ed). Thieme.
- Jang, Y.-R., & Lee, M.-A. (2022). A Study of Relationships among Tuberculosis Knowledge, Family Support, and Medication Adherence in Tuberculosis Patients. *The Journal of Korean Academic Society of Nursing Education*, 80(1), 80–90. <https://doi.org/10.5977/jkasne.2022.28.1.80>
- Khafid, M., Krisnawati, D. I., Hatmanti, N. M., Mukti, P., Winoto, P., Faizzatullailiyah, L., & Qasanah, I. F. (2024). Peran Keluarga terhadap Kepatuhan Minum Obat pada Pasien TB Paru: Literatur Review. *Jurnal Kesehatan Islam: Islamic Health Journal*, 13(2), 85–105. <https://doi.org/10.33474/jki>
- Kristinawati, B., Muryadewi, A., & Irianti, A. D. (2019). The Role of Family as A Caregiver in Caring for Family Members that are Suffering from Pulmonary Tuberculosis. *Jurnal Ners*, 14(3), 362–366. [https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20473/jn.v14i3\(si\).17214](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20473/jn.v14i3(si).17214)
- Lee, J. Y. (2016). Tuberculosis Infection Control in Health- Care Facilities: Environmental Control and Personal Protection. *Tuberculosis and Respiratory Diseases*, 79(2), 234–240. <https://doi.org/10.4046/trd.2016.79.4.234>
- Maria, I. (2020). Hubungan Pengetahuan Keluarga dengan Perilaku Pencegahan Penularan Tuberculosis Paru di Wilayah Kerja Puskesmas Martapura II. *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (JKSI)*, 5(2), 182–186.
- Nadon, H., Dmello, M. K., & Shetty, S. (2023). Factors Determining Family and Social Support Among Pulmonary Tuberculosis Patients in East Khasi Hills, Meghalaya: A Cross-Sectional Study. *Journal of Public Health*, 45(3), 542–550. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/pubmed/fdad063>
- Nindrea, R. D., Ming, L. C., & Agustian, D. R. (2025). Family Support, Motivation, and Treatment: Insights From Indonesia Patient Adherence to

- Tuberculosis. *African Journal of Infectious Diseases (AJID)*, 19(2), 43–49.
<https://doi.org/10.21010/Ajidv19i2.5>
- Nursasi, A. Y., Sabila, N. T., & Jauhar, M. (2021). The Healthcare Needs of Families Caring for Patients. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 24(2), 110–117.
<https://doi.org/10.7454/jki.v24i2.1076>
- Pradipta, I. S., Idrus, L. R., Probandari, A., Lestari, B. W., & Diantini, A. (2021). Barriers and Strategies To Successful Tuberculosis Treatment in A High-Burden Tuberculosis Setting: A Qualitative Study from The Patient ' S Perspective. *BMC Public Health*, 21(1903), 1–12.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12889-021-12005-y>
- Putri, R. H. S., Sukartini, T., & Qona'ah, A. (2021). Patient Adherence to Tuberculosis Treatment: A Relation between Family Support and Patient Behavior. *CRITICAL MEDICAL AND SURGICAL*, 10(2), 42–46.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20473/cmsnj.v10i2.26491>
- Rachmawati, D. S., Nursalam, N., Amin, M., Hargono, R., Suhardiningsih, A. V. S., & Amalia, N. (2022). An Analysis of Factors Influencing the Compliance to Treatment of Pulmonary Tuberculosis Patients Through Family Resilience. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 13(4), 1210–1223. <https://doi.org/10.47750/pnr.2022.13.04.170>
- Rahmah, S., Ardiana, A., & Rachmawati, I. (2025). Determinants of Medication Adherence in Pulmonary Tuberculosis: A Systematic Review. *NERS Jurnal Keperawatan*, 21(1), 45–61.
<https://doi.org/https://doi.org/10.25077/njk.v21i1.243>
- Rumokoya, C. B. M., & Rumokoy, D. G. M. (2026). Family Support as an Effort To Improve Tuberculosis Patient Rehabilitation: Systematic Review. *Jurnal Keperawatan (J-Kp)*, 14(01), 51–61.
- Stanhope, M., & Lancaster, J. (2020). *Public Health Nursing: Population-Centered Health Care in The Community* (10th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Suarnianti, Haskas, Y., & BN, I. R. (2023). The Relationship Between Family Support and Family Stress in Pulmonary Tuberculosis Patients. *Poltekita: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 17(3), 879–885.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33860/jik.v17i3.1912> ©
- Sudirman, A. N. A., Mulyono, S., & Khasanah, U. (2020). Meningkatkan Kemandirian Keluarga pada Klien Tuberculosis Paru Melalui Peran Tugas Kesehatan Keluarga. *Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan*, 8(2), 243–252 0.001).
<https://doi.org/10.20527/dk.v8i2.8285>
- Sugion, Ningsih, F., & Ovany, R. (2022). HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN KELUARGA DENGAN UPAYA PENCEGAHAN PENULARAN TUBERCULOSIS PARU DI WILAYAH KERJA UPT PUSKESMAS

PAHANDUT. *Jurnal Surya Medika (JSM)*, 8(3), 228–234.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33084/jsm.v8i3.4516>

Suprajitno, S., Mugianti, S., & Al-hadeethi, A. (2022). Health Index Formula for Tuberculosis Patients: A Study on Family Self-Care at Public Health Center in 2018 at Blitar, East Java, Indonesia. *BIOMOLECULAR AND HEALTH SCIENCE JOURNAL*, 05(01), 37–41.
<https://doi.org/10.20473/bhsj.v5i1.30913>

Tambunan, E. H. (2023). Exploring The Experiences of Family Caregivers Caring for Patient with Tuberculosis at Home. *Jurnal Ners Universitas Pahlawan*, 7(288), 1741–1749.

G. Glosarium

Ditjen P2P	: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
DOTS	: <i>Directly Observed Treatment Short-course</i>
OAT	: Obat Anti Tuberkulosis
TB Paru	: Tuberkulosis Paru

CHAPTER 3

PENGKAJIAN KEPERAWATAN KELUARGA DAN KONDISI LINGKUNGAN RAMAH

Anis Rosyiatul Husna, S.Kep., Ns., M.Kes

A. Pendahuluan

Tuberkulosis merupakan merupakan penyakit kronis menular yang masih menjadi tantangan global, terutama dinegara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (Husna et al., 2024). Indonesia termasuk negara dengan beban Tuberkulosis Paru yang tinggi di dunia. Tuberkulosis cepat ditularkan pada anggota keluarga yang tinggal serumah dengan kondisi lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan, seperti ventilasi yang buruk, tingginya konsentrasi infeksi dalam ruangan, sirkulasi udara yang mengandung kuman, penanganan spesimen yang tidak tepat, kurangnya tekanan udara negatif di ruangan penderita, paparan di ruangan kecil yang tertutup (CDC, 2021). Kondisi lingkungan lainnya yang memepengaruhi berkembangnya kuman Tuberkulosis adalah kurangnya paparan sinar matahari, kelembapan udara yang tinggi, kondisi rumah, sanitasi, kepadatan hunian (*overcrowding*), dan perilaku kesehatan keluarga, juga sangat memengaruhi status kesehatan individu (Lee et al., 2022; Razak et al., 2025)

Pengendalian Tuberkulosis Paru tidak hanya dilakukan dengan pengobatan farmakologis tetapi juga perlu adanya keterlibatan keluarga dan lingkungan keluarga (Donsu et al., 2021). Keluarga merupakan sistem, dimana jika salah satu anggota keluarga bermasalah akan mempengaruhi anggota keluarga yang lainnya, begitupun sebaliknya (Friedman, 2010). Keluarga memiliki fungsi dalam mendukung kepatuhan pengobatan serta menciptakan lingkungan yang sehat (WHO, 2023). Kurangnya pengetahuan, sikap, dan keterampilan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit dapat memperburuk kondisi penderita dan meningkatkan risiko penularan penyakit. Kegagalan keluarga dalam menjalankan lima tugas kesehatan keluarga, mulai dari mengenal masalah kesehatan, mengambil keputusan, merawat anggota keluarga yang sakit, memodifikasi lingkungan rumah, hingga memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan menjadi faktor penyulit dalam penyembuhan Tuberkulosis Paru. Banyak keluarga yang belum mampu memodifikasi lingkungan rumah mereka agar mendukung proses penyembuhan dan mencegah penularan interpersonal.

Pengkajian keperawatan keluarga merupakan langkah awal dalam mengidentifikasi kondisi kesehatan anggota keluarga, faktor risiko penularan, serta kemampuan keluarga dalam melakukan perawatan mandiri. Pendekatan keluarga sangat penting untuk keberhasilan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan keluarga. Asuhan keperawatan keluarga adalah suatu proses pelayanan keperawatan yang ditujukan kepada keluarga sebagai satu kesatuan unit dengan fokus pada peningkatan kemampuan keluarga dalam memelihara kesehatan, mencegah penyakit, serta merawat anggota keluarga yang sakit. Pendekatan ini menekankan pada interaksi antara perawat dengan keluarga dalam mengkaji masalah kesehatan, menentukan prioritas, serta merencanakan dan melaksanakan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan keluarga (Kaakinen et al., 2018). Pendekatan asuhan keperawatan keluarga memungkinkan perawat untuk melakukan intervensi promotif dan preventif secara langsung dalam konteks lingkungan keluarga. Perawat perlu melakukan pengkajian secara komprehensif terhadap kondisi keluarga, termasuk aspek fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan. Pendekatan holistik ini memungkinkan perawat untuk memberikan intervensi yang lebih tepat dan berkelanjutan (Allender et al., 2014). Dengan demikian, asuhan keperawatan keluarga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup keluarga secara menyeluruh.

B. Pengertian Pengkajian Keperawatan Keluarga

Pengkajian asuhan keperawatan keluarga adalah proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan oleh perawat keluarga secara sistematis, komprehensif, dan kontinu tentang karakteristik, kebutuhan, masalah, dan sumber daya kesehatan keluarga. Pengkajian asuhan keperawatan keluarga bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi keluarga dalam mencapai kesehatan optimal, serta menetapkan prioritas masalah dan diagnosis keperawatan keluarga.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam melakukan pengkajian keperawatan keluarga dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, dan studi dokumentasi. Metode atau teknik pengumpulan data keluarga pada anggota yang menderita Tuberkulosis Paru dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses penggalan informasi yang dilakukan oleh perawat keluarga terhadap klien yang menderita Tuberkulosis Paru dan

keluarganya untuk mendapatkan data verbal tentang keluarga, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan pertanyaan terbuka atau tertutup.

Tahapan komunikasi dalam wawancara dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Pra Interaksi: Pahami rekam medis pasien, untuk mengetahui lama pengobatan OAT dan fase saat ini sebagai materi/bahan topik diskusi.
- b. Orientasi: Ciptakan lingkungan yang nyaman, perkenalkan diri, dan bangun kepercayaan. Jelaskan juga tujuan dari wawancara.
- c. Kerja: Gunakan tehnik eksplorasi (menggali), klarifikasi, dan pendalam pertanyaan. Berikan jeda waktu agar keluarga dapat merespons dengan leluasa.
- d. Terminasi: simpulkan hasil diskusi, buat kesepakatan lebih lanjut, dan berikan penguatan (pujian) atas peran keluarga.

2. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data obyektif melalui proses pengamatan langsung atau tidak langsung oleh perawat keluarga terhadap pasien dan keluarga. Fokus observasi, sebagai berikut:

- a. Kondisi dan Kepatuhan Pasien
 - 1) Kepatuhan Pengobatan: Observasi keteraturan pasien minum obat secara teratur sesuai jadwal sampai pasien dinyatakan sembuh oleh dokter.
 - 2) Gejala Klinis: Observasi apakah ada keluhan batuk berdahak lebih dari 2 minggu, demam, keringat saat malam hari tanpa beraktifitas, dan penurunan berat badan.
 - 3) Etika Batuk: Observasi apakah pasien selalu menutup mulut saat batuk atau bersin dengan tisu atau lengan baju, dan membuang ludah di tempat tertutup yang diberi cairan disinfektan.
- b. Peran dan Dukungan Keluarga
 - 1) Pengawas Menelan Obat (PMO): Kaji apakah terdapat PMO yang berasal dari satu anggota keluarga yang tinggal serumah untuk memastikan dan mengingatkan pasien meminum obat setiap hari.
 - 2) Dukungan Emosional: Kaji apakah keluarga memberikan motivasi agar pasien tidak putus asa, apakah keluarga memberikan rasa aman, empati, dan kepedulian pada penderita.
 - 3) Dukungan Nutrisi: Kaji kemampuan keluarga dalam menyediakan diet Tinggi Kalori Tinggi Protein (TKTP) untuk mencegah malnutri.
- c. Kondisi Lingkungan dan Rumah

- 1) Ventilasi dan Pencahayaan: Observasi sirkulasi udara di dalam rumah dan pastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan.
 - 2) Kepadatan Hunian: Observasi apakah jumlah anggota keluarga yang tinggal serumah tidak sebanding dengan luas ruangan. Kepadatan hunian dapat mempermudah penularan kuman Tuberkulosis Paru melalui udara.
3. Pemeriksaan Fisik
- Pemeriksaan fisik pada keluarga dengan Tuberkulosis Paru berfokus pada pelacakan tanda klinis infeksi (skrining kontak serumah) dan pemantauan kondisi anggota keluarga yang sedang menjalani pengobatan.
4. Studi Dokumentasi
- Metode pengumpulan data klinis melalui rekam medis dan catatan keperawatan untuk mengevaluasi riwayat kesehatan, kepatuhan, dan status penularan.

D. Fokus Pengkajian Keperawatan Keluarga

Model pengkajian keperawatan keluarga menurut Friedman, L. M (2010) di fokuskan pada:

1. Data Identifikasi Keluarga
Data identifikasi keluarga, meliputi:
 - a. Identitas Pasien
 - 1) Nama Kepala Keluarga : diisi nama kepala keluarga
 - 2) Pekerjaan kepala keluarga : diisi pekerjaan kepala keluarga
 - 3) Pendidikan kepala keluarga: diisi pendidikan kepala keluarga
 - 4) Komposisi keluarga : diisi komposisi kepala keluarga
 - b. Tipe Keluarga: Mengetahui bentuk keluarga (*nuclear, extended, dll*).
 - c. Genogram (Pohon Keluarga): berfungsi untuk mengetahui riwayat penyakit Tuberkulosis Paru atau infeksi menular dalam garis keturunan.
2. Tahap dan Riwayat Perkembangan Keluarga
 - a. Tahap perkembangan keluarga ditentukan oleh anak tertua dalam keluarga inti dan tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi. Pengkajian tahap perkembangan keluarga ini bertujuan untuk menyesuaikan risiko penularan pada kelompok rentan.
 - b. Riwayat kesehatan keluarga: mengkaji riwayat Tuberkulosis Paru yang dialami oleh anggota keluarga sebelumnya, lama pengobatan dan status pengobatan OAT.
3. Data Lingkungan
 - a. Karakteristik Lingkungan Rumah

Pengkajian karakteristik rumah bertujuan untuk menilai secara fisik kondisi rumah, meliputi luas rumah, jenis bangunan, jumlah ruangan, luas ventilasi/jendela, pencahayaan alami, kelembapan dinding rumah, penyediaan air bersih, dan pengelolaan sampah rumah tangga.

1) Data Fisik Komponen Rumah

- a) Denah rumah: Observasi tata letak ruang (kamar tidur penderita, ruang keluarga, dapur, kamar mandi, posisi jendela, dan pintu). Berikan tanda arah mata angin untuk menganalisis paparan sinar matahari pagi.
- b) Luas bangunan dan kepadatan hunian: Hitung luas total rumah (misal: $6\text{m} \times 6\text{m} = 36 \text{ m}^2$). Bandingkan dengan jumlah penghuni. Standar Kemenkes mensyaratkan minimal 8m^2 per orang. Tuliskan jika terjadi *overcrowding* (kepadatan berlebih) karena mempercepat penularan *droplet*.
- c) Jenis Lantai: Observasi material lantai, terutama di kamar tidur pasien. Apakah berupa tanah, papan, atau semen/keramik kedap air. Lantai tanah meningkatkan kelembapan udara secara signifikan.
- d) Kondisi Dinding: Observasi apakah dinding rumah semi-permanen (anyaman bambu/papan kayu tebal) atau permanen (tembok plesteran). Catat jika dinding tampak lembap, berjamur, atau basah karena rembesan air.
- e) Langit-langit (Plafon): Observasi ada atau tidak ada plafon. Keberadaan plafon yang kotor dan berdebu dapat memperburuk kondisi paparan partikel di saluran pernapasan.

2) Parameter Sanitasi Udara dan Pencahayaan

- a) Sistem Ventilasi: Hitung total luas lubang angin/jendela yang bisa dibuka. Bandingkan dengan luas lantai (standar sehat: minimal 10%-15% dari luas lantai). Kaji apakah ventilasi menggunakan sistem silang (cross ventilation) agar udara bersih dapat mengusir droplet yang melayang.
- b) Pencahayaan Alami (Sinar Matahari): Amati apakah sinar matahari pagi dapat masuk langsung ke dalam rumah, terutama ke kamar tidur penderita. Sinar UV alami merupakan pembunuh bakteri Tuberkulosis paling efektif. Ukur intensitas cahaya jika membawa Lux Meter (standar sehat: minimal 60 Lux).
- c) Kelembapan dan Suhu Ruangan: Catat jika ruangan terasa pengap, dingin, atau terlalu lembap (kelembapan ideal: 40% – 60%). Rumah

yang lembap membuat bakteri bertahan hidup lebih lama di debu ruangan.

3) Fasilitas Sanitasi Dasar

- a) Kamar Tidur Penderita: Kaji secara khusus kamar tidur pasien. Apakah pasien tidur sendiri atau masih berbagi ranjang dengan anggota keluarga lain yang sehat (sangat berisiko menularkan)?
- b) Penyediaan Air Bersih: Sumber air yang digunakan untuk kebutuhan minum dan MCK (PDAM, sumur bor, atau sumur gali).
- c) Sarana Pembuangan Dahak: Kaji perilaku penderita saat batuk/membuang ludah. Apakah penderita memiliki tempat pembuangan dahak khusus yang diberi disinfektan (misal: kaleng berisi air sabun/karbol) atau dibuang sembarangan.
- d) Kepemilikan Rumah: Status rumah yang ditinggali (milik sendiri, menumpang, atau kontrak/sewa). Status kepemilikan memengaruhi kemampuan keluarga dalam memodifikasi struktur fisik rumah (misal: membuat jendela baru).

b. Karakteristik Lingkungan Tetangga

Karakteristik tetangga dan komunitas bertujuan untuk mengetahui risiko penularan, dukungan sosial (stigma/penerimaan), kebiasaan, tingkat kepedulian lingkungan sekitar, serta ketersediaan fasilitas kesehatan bagi penderita Tuberkulosis.

1) Interaksi Sosial dan Kebiasaan

- a) Frekuensi Kontak: Menilai seberapa sering pasien atau anggota keluarga berinteraksi dan berkumpul dengan tetangga sekitar.
- b) Kebiasaan Bersama: Mengidentifikasi kebiasaan berkumpul (seperti arisan, ronda, atau kerja bakti) yang dapat menjadi celah risiko penularan jika pasien berada dalam fase aktif tanpa pengobatan.
- c) Kepadatan Hunian Tetangga: Menilai jarak antar rumah dan kepadatan penduduk di lingkungan sekitar yang turut memengaruhi sirkulasi udara dan potensi penularan.

2) Dukungan Sosial dan Stigma

- a) Penerimaan Lingkungan: Menilai bagaimana sikap tetangga terhadap keluarga yang menderita Tuberkulosis Paru (apakah ada sikap mengucilkan atau dukungan yang baik).
- b) Keaktifan dalam Kegiatan: Menilai apakah keluarga pasien masih dilibatkan dalam kegiatan kemasyarakatan atau justru menarik diri karena takut akan stigma penyakit.

3) Pengetahuan Masyarakat tentang Tuberkulosis Paru

- a) Pemahaman Penularan: Mengkaji sejauh mana pemahaman tetangga mengenai cara penularan penyakit Tuberkulosis Paru, misalnya melalui droplet (percikan ludah saat batuk atau bersin)
- b) Stigma Negatif: Mengkaji apakah terdapat mitos keliru di lingkungan tetangga yang memandang Tuberkulosis Paru sebagai penyakit aib atau kutukan

4) Sistem Pendukung dan Akses Kesehatan

- a) Kader Kesehatan: Mengidentifikasi peran kader kesehatan atau tokoh masyarakat setempat dalam memantau dan memberikan edukasi.
- b) Akses Fasilitas: Memetakan akses lingkungan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan terdekat (seperti puskesmas atau klinik) untuk pengobatan rutin pasien
- c) Mobilitas Geografis keluarga: menjelaskan kebiasaan keluarga berpindah tempat. Anggota keluarga yang memiliki mobilitas tinggi akan berperan sebagai vektor (agen pembawa) bakteri dari satu komunitas ke komunitas yang lain serta mengganggu kontinuitas pengobatan (Ovany et al., 2026).
- d) Perkumpulan Keluarga dan Interaksi Masyarakat: pengkajian difokuskan bagaimana kebiasaan berkumpul, dukungan emosional, dan sejauh mana stigma masyarakat membatasi sosialisasi penderita Tuberkulosis dengan lingkungan sekitar.
- e) Sistem Pendukung Keluarga: pengkajian sistem pendukung keluarga difokuskan pada dukungan emosional, informasi, instrumental, dan penilaian yang diberikan keluarga kepada penderita Tuberkulosis (Sarafino & Smith, 2010).

4. Struktur Keluarga

- a. Pola Komunikasi: komponen pengkajian pola komunikasi meliputi keterbukaan dan kejujuran pasien dan keluarga dalam membicarakan masalah yang dialami, ada tidaknya hambatan komunikasi karena adanya ketakutan dan stigma, frekuensi dan cara berkomunikasi anggota keluarga, cara keluarga mendiskusikan dan memutuskan pengobatan seperti jadwal kontrol dan minum obat OAT, serta seberapa aktif keluarga keluarga bertanya dan merespons edukasi dari perawat.
- b. Struktur Kekuatan Keluarga: fokus pengkajiannya meliputi siapa yang memiliki wewenang paling besar dalam mengambil keputusan (*decision making*) di keluarga terkait pengobatan, perawatan, serta keuangan. Perlu

juga dikaji apakah penderita Tuberkulosis Paru sebelumnya merupakan pengambil keputusan utama atau pencari nafkah dan bagaimana keluarga menyesuaikan dengan kondisi tersebut.

- c. Struktur Peran Keluarga: perawat perlu mengkaji bagaimana penyakit Tuberkulosis Paru memengaruhi pembagian tugas, pengambilan keputusan, dan fungsi masing-masing anggota keluarga, serta peran sebagai *care giver*.
- d. Nilai dan Norma Keluarga: Kaji sistem keyakinan keluarga mengenai penyakit Tuberkulosis Paru (misalnya, apakah dianggap sebagai kutukan, aib yang harus ditutupi, atau penyakit medis biasa) dan kebiasaan sehari-hari yang dilakukan dalam keluarga (seperti membuka jendela setiap hari).

5. Fungsi Keluarga

- a. Fungsi Afektif: Kaji cara antar anggota keluarga dalam memberikan kasih sayang, kepedulian terhadap perasaan, penerimaan, kehangatan serta dukungan emosional yang diberikan satu sama lain (Wahyudi et al., 2023).
- b. Fungsi Sosialisasi: Kaji bagaimana anggota keluarga berinteraksi, menjalankan peran sosial, dan beradaptasi dengan lingkungan masyarakat, serta identifikasi adanya isolasi sosial akibat anggota keluarga menderita Tuberkulosis Paru.
- c. Fungsi Perawatan Kesehatan, kaji kemampuan keluarga dalam melaksanakan tugas kesehatan keluarga (Bailon & Maglaya, 1978), yaitu:
 - 1) Mengenal Masalah Kesehatan: Kaji pemahaman keluarga tentang penyakit Tuberkulosis Paru, kesadaran keluarga dengan kondisi anggota keluarga.
 - 2) Mengambil Keputusan Tindakan yang Tepat: kaji kemana keluarga mencari pertolongan pertama saat gejala Tuberkulosis Paru muncul, dukungan dan keputusan keluarga membawa anggota keluarga berobat (tes sputum, pemeriksaan foto thorak) (CDC, 2021).
 - 3) Merawat Anggota keluarga yang Sakit: kaji apakah terdapat anggota keluarga yang ditunjuk sebagai pengawas minum obat (PMO), kemampuan keluarga dalam menyediakan dan menyajikan makanan yang bergizi, serta dukungan emosional yang diberikan keluarga.
 - 4) Memodifikasi Lingkungan: Kaji ventilasi dan pencahayaan (rumah memiliki sirkulasi udara yang baik dan jendela yang memungkinkan sinar matahari masuk), kepadatan hunian (jumlah anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah), pemisahan alat makan penderita dengan anggota keluarga yang lain.
 - 5) Memanfaatkan Fasilitas Kesehatan: Kaji apakah keluarga rutin ke puskesmas, klinik, atau rumah sakit untuk mengambil Obat Anti

Tuberkulosis (OAT), apakah keluarga membawa anggota keluarga serumah yang berisiko tertular untuk melakukan pemeriksaan atau skrining (seperti tes Mantoux atau IGRA).

- d. Fungsi Reproduksi: Kaji apakah penderita atau pasangan mengalami gangguan menstruasi, penurunan libido, atau kesulitan memiliki keturunan serta risiko penularan infeksi dan perencanaan kehamilan yang aman.
 - e. Fungsi Ekonomi: Kaji kemampuan finansial keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar (sumber pendapatan keluarga), alokasi biaya pengobatan jangka panjang (pemeriksaan laboratorium, obat-obatan non program, vitamin, biaya transportasi ke pelayanan kesehatan), serta dampak penyakit terhadap penurunan produktivitas.
6. Stres dan Koping Keluarga
- a. Stressor Jangka Pendek dan Panjang
 - 1) Stressor jangka pendek

Stres jangka pendek (akut) pada pasien Tuberkulosis Paru umumnya berlangsung mulai pasien didiagnosa hingga 2 bulan pengobatan pertama (fase intensive) (Sibarani, 2024; WHO, 2024). Sedangkan pada keluarga stressor ini memerlukan penyelesaian segera dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan. Hal-hal yang perlu dikaji meliputi keluhan fisik akibat efek samping obat, bagaimana adaptasi pasien terhadap diagnosis Tuberkulosis Paru dan kecemasan penularan.
 - 2) Stressor jangka panjang

Stres jangka panjang biasanya berlangsung lama dan membutuhkan penyelesaian lebih dari 6 bulan. Hal-hal yang perlu di kaji, meliputi kepatuhan pengobatan jangka panjang, stigma sosial dari lingkungan dan masyarakat, biaya pengobatan dan transportasi ke pelayanan kesehatan, produktivitas kerja, serta risiko kekambuhan.
 - b. Kemampuan Keluarga Merespon stressor: Kaji kemampuan keluarga menerima anggota keluarga dengan Tuberkulosis Paru, kemampuan mencegah penularan, pemahaman pentingnya perawatan.
 - c. Strategi Koping: Strategi koping merupakan kemampuan individu untuk mengelola, mengendalikan, atau mengatasi masalah internal maupun eksternal yang dinilai membebani atau melebihi kapasitas diri mereka (Lazarus & Folkman, 1984; Maryam, 2017). Hal-hal yang perlu di kaji, meliputi bagaimana keluarga menerima, mengatasi, dan beradaptasi dengan beban fisik maupun psikososial selama anggota keluarga mereka menjalani pengobatan Tuberkulosis Paru.

E. Kondisi Lingkungan Rumah

Pengkajian kondisi lingkungan rumah pasien Tuberkulosis Paru difokuskan untuk menilai sejauh mana rumah menjadi media penularan kuman Tuberkulosis atau pendukung kesembuhan pasien.

1. Kaji Sanitasi Udara Rumah

- a. Perilaku Membuka Jendela (Ventilasi): Amati apakah jendela dibuka setiap hari (terutama jendela kamar penderita). Kaji durasinya (misalnya: hanya pagi hari atau sepanjang hari). Ventilasi yang selalu tertutup membuat bakteri TBC bertahan hidup di dalam rumah.
- b. Kepadatan Hunian (Jarak Kontak Luar): Kaji rasio jumlah penghuni terhadap luas rumah. Standar sehat mewajibkan minimal 8 m² per orang. Rumah yang terlalu padat meningkatkan frekuensi paparan partikel infeksius (*droplet*) antar anggota keluarga.
- c. Keberadaan Ventilasi Silang (*Cross Ventilation*): Periksa apakah posisi jendela dan pintu atau lubang angin saling berhadapan. Sirkulasi udara satu arah tidak efektif untuk mengusir bakteri *Mycobacterium tuberculosis* keluar ruangan.

2. Higienitas Tempat Tidur dan Paparan Sinar Matahari

- a. Pencahayaan Kamar Tidur: Amati apakah cahaya matahari pagi dapat menembus masuk ke area tempat tidur pasien. Bakteri TBC dapat mati dalam hitungan jam jika terkena sinar ultraviolet (UV) langsung.
- b. Perilaku Menjemur Alat Tidur: Tanyakan seberapa sering keluarga menjemur kasur, bantal, dan selimut penderita di bawah terik matahari langsung (idealnya minimal 1–2 kali seminggu).
- c. Kondisi Alas Tidur: Kaji apakah penderita tidur sendiri di kamar terpisah atau masih satu ranjang dengan anggota keluarga yang sehat (terutama balita atau lansia yang rentan).

3. Sanitasi Pembuangan Limbah dan Perilaku Higienis

- a. Pengelolaan Dahak (Sputum) Penderita: Kaji secara detail di mana dan bagaimana penderita membuang dahak saat batuk. Apakah dibuang sembarangan (di lantai/pekarangan) atau dibuang ke wadah khusus tertutup yang diisi cairan disinfektan (karbol/air sabun)?
- b. Etika Batuk dan Bersin: Observasi apakah penderita menerapkan etika batuk yang benar (menggunakan masker, tisu, atau lengan baju bagian dalam) saat berada di dalam rumah bersama keluarga.

- c. Sistem Pembuangan Sampah: Kaji jenis tempat sampah (terbuka atau tertutup) dan penanganannya (dibakar, dikubur, atau diangkut petugas) untuk melihat potensi pencemaran udara lingkungan sekitar.
4. Sumber Polusi Udara (Kualitas Udara Dalam Rumah)
- a. Paparan Asap Rokok: Identifikasi apakah ada anggota keluarga lain yang memiliki kebiasaan merokok di dalam rumah. Asap rokok menurunkan fungsi makrofag (sel imun) paru-paru seluruh penghuni rumah.
 - b. Jenis Bahan Bakar Memasak: Amati letak dapur dan bahan bakar yang digunakan (gas LPG, minyak tanah, atau kayu bakar). Asap dari kayu bakar tanpa cerobong meningkatkan risiko infeksi pernapasan akut yang memperparah Tuberkulosis Paru.

F. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik pada pasien dan keluarga yang tinggal serumah dengan pasien Tuberkulosis Paru, bertujuan untuk mengetahui penyebaran kuman pada anggota keluarga (*contact tracing*) berinteraksi setiap hari dalam satu rumah. Pemeriksaan fisik yang dilakukan, sebagai berikut:

1. Tanda-Tanda Vital (*Vital Sign*)

Pemeriksaan tanda-tanda vital merupakan pemeriksaan awal yang bertujuan untuk mengetahui adanya respons sistemik terhadap infeksi dan penyakit. Adapun tanda-tanda vital yang diperiksa adalah:

- a. Suhu tubuh: lakukan pengukuran suhu tubuh untuk mengetahui peningkatan suhu tubuh. Pasien Tuberkulosis biasanya mengalami peningkatan suhu tubuh/demam pada sore/malam hari.
- b. Nadi: lakukan pengukuran frekuensi dan irama nadi. Hasil pengukuran nadi biasanya didapatkan frekuensi nadi meningkat diatas 100x/menit saat istirahat dengan irama takikardia (nadi teratur dan cepat) (Patil et al., 2022). Kondisi ini terjadi sebagai respons tubuh terhadap infeksi kuman *Mycobacterium Tuberculosis*, respon dari demam, serta penurunan asupan oksigen.
- c. Pernapasan (Respirasi): lakukan pengukuran pernapasan pasien. Biasanya pasien Tuberkulosis Paru mengalami sesak napas akibat penurunan saturasi oksigen dan peningkatan frekuensi napas.
- d. Tekanan Darah: Untuk mendeteksi adanya komplikasi atau penyakit penyerta.

2. Penampilan Umum

Kaji penampilan umum, meliputi:

- a. Keluhan utama: Tanyakan batuk (berdahak, bercampur darah atau nanah), nyeri dada saat bernapas, dan sesak napas.
- b. Berat badan: lakukan pengukuran berat badan saat ini dan bandingkan dengan dengan bulan-bulan sebelumnya untuk memantau penurunan berat badan yang drastis. Penurunan berat badan merupakan salah satu gejala fisik yang dialami oleh pasien Tuberkulosis Paru aktif (Kemenkes, 2020).

3. Pemeriksaan Fisik Sistem Pernapasan

- a. Inspeksi (Melihat): Memeriksa kesimetrisan pergerakan dada kanan dan kiri, dan apakah ada penggunaan otot bantu pernapasan.
- b. Palpasi (Meraba): Meraba getaran vokal (*taktil fremitus*) untuk mengetahui adanya kelainan atau konsolidasi di jaringan paru.
- c. Perkusi (Mengetuk): Mendengarkan resonansi suara dada. Suara redup (pekak) bisa menandakan adanya cairan atau konsolidasi.
- d. Auskultasi (Mendengar dengan stetoskop): Mendengarkan suara napas untuk mencari adanya suara tambahan seperti *ronkhi* basah (*crackles*) yang biasanya muncul di area paru bagian atas.

4. Area Tubuh Lainnya

- a. Leher: Memeriksa apakah ada pembesaran kelenjar getah bening (limfadenopati), yang bisa menjadi tanda Tuberkulosis kelenjar.
- b. Kulit: Memeriksa adanya keringat dingin berlebih pada malam hari.

5. Langkah skrining untuk keluarga

Pemeriksaan fisik terkadang mampu mendeteksi adanya infeksi Tuberkulosis laten. Jika terdapat anggota keluarga yang menunjukkan gejala dan memiliki kontak erat dengan pasien Tuberkulosis Paru, maka segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat. Skrining yang dapat dilakukan menurut PDPI (2021) sebagai berikut :

- a. Tes Kulit Tuberkulin (*Mantoux*): Tes standar untuk melihat paparan infeksi.
- b. Tes Darah IGRA (*Interferon-Gamma Release Assays*): Tes darah untuk mendeteksi respons imun terhadap bakteri Tuberkulosis.
- c. Rontgen Dada (Thorax): Untuk melihat gambaran lesi atau bercak khas TB pada paru-paru.
- d. Pemeriksaan Dahak (Mikroskopis atau Tes Cepat Molekuler): Jika anggota keluarga mengalami batuk terus-menerus.

G. Referensi

- Allender, J. A., Rector, C., & Warner, K. D. (2014). *Community and Public Health Nursing: Promoting the Public's Health* (8th Editio). Lippincott Williams & Wilkins.
- Bailon, S. G., & Maglaya, A. S. (1978). *Perawatan Kesehatan Keluarga*. Pusdiknakes Depkes RI.
- CDC. (2021). Core Curriculum on Tuberculosis: What the Clinician Should Know. *Centers for Disease Control and Prevention National Center for HIV/AIDS, Viral Hepatitis, STD, and TB Prevention Division of Tuberculosis Elimination*, 9–12. <http://www.cdc.gov/tb>.
- Donsu, J. D. T., Ratnawati, A., & Adriani, R. B. (2021). *Review Article Tuberculosis Prevention Development Family Model Based in Indonesia*. 10.
- Friedman, L. M. (2010). *Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Riset, teori, praktik (5th ed)*. EGC.
- Friedman, M. (2010). *Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Riset, Teori, dan Praktek (5th ed.)*. Jakarta:EGC.
- Husna, A. R., Nursalam, N., Hidayat, A. A. A., & Makhfudli, M. (2024). Patient-Centered Digital Interventions for Self-Care Ability Among People with Pulmonary Tuberculosis: A Systematic Review. *Pacific Rim International Journal of Nursing Research*, 29(1 SE-Original paper), 24–43. <https://doi.org/10.60099/prijnr.2025.270467>
- Kaakinen, J. R., Coehlo, D. P., Steele, R., & Robinson, M. (2018). *Family Health Care Nursing* (6th Editio). F.A. Davis.
- Kemenkes, R. (2020). *Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran: Tata Laksana Tuberkulosis*. Kemenkes RI.
- Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, Appraisal and Coping* (1st ed.). Springer Publishing Company, Inc.
- Lee, J. Y., Kwon, N., Goo, G., & Cho, S. (2022). Inadequate housing and pulmonary tuberculosis: a systematic review. *BMC Public Health*, 1–12. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-12879-6>
- Maryam, S. (2017). Strategi Coping. *Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1(2), 101.
- Ovany, R., Alvionesa, M. C., & Delyka, M. (2026). *The influence of booklet media on tuberculosis knowledge among airport workers: A pre-experimental study*. 7(1), 66–73.
- Patil, S., Gondhali, G., Bhadake, & Manojkumar. (2022). Disproportionate Tachycardia and Tachypnea in Pulmonary Tuberculosis: A Marker of Concurrent Cardiac Dysfunction. *Journal of The Association of*

Pulmonologist of Tamil Nadu, 5(3), 124–129.
<https://doi.org/10.4103/japt.japt>

- PDPI. (2021). Tuberkulosis: Pedoman Diagnosis dan Penatalaksanaan di Indonesia. In *PDPI* (Vol. 001, Issue 2014).
- Razak, R., Rahmadina, F., & Santiyah, S. (2025). *Faktor Kondisi Fisik Lingkungan Rumah Terhadap Kasus Tuberkulosis di Indonesia: Systematic Review*. 17(March), 130–143. <https://doi.org/10.37012/jik.v17i1.2632>
- Sarafino, E. P., & Smith, T. W. (2010). *Health Psychology: Biopsychosocial Interactions* (7th ed., Vol. 59). Wiley.
- Sibarani, J. P. (2024). Description Of Stress Levels In Pulmonary Tuberculosis Patients Undergoing The Intensive Phase Of Treatment In Hospital And Puskesmas. *International Journal of Health and Pharmaceutical (IJHP)*, 4(4), 595–602. <https://doi.org/10.51601/ijhp.v4i4.290>
- Wahyudi, C. T., Mandasari, E., Kesehatan, F. I., Pembangunan, U., Veteran, N., Keluarga, F. A., Minum, K., & Anti, O. (2023). *Korelasi fungsi afektif keluarga dan efikasi diri terhadap kepatuhan minum obat tuberkulosis paru*. 7(3), 219–227.
- WHO. (2023). Global Tuberculosis Report 2023. In *January: Vol. t/malaria/* (Issue March).
- WHO. (2024). *Operational Handbook on Tuberculosis. Module 6: Tuberculosis and Comorbidities* (Third edit). World Health Organization.

H. Glosarium

D

Disinfektan: Bahan kimia yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen (bakteri, virus, dan jamur).

Droplet: adalah percikan lendir atau dahak yang dikeluarkan ke udara oleh penderita Tuberkulosis saat batuk, bersin, berbicara, atau bernyanyi.

O

OAT: adalah Obat Anti Tuberkulosis yang dikonsumsi pasien Tuberkulosis selama menjalani pengobatan.

P

PMO: adalah Pengawas Minum Obat yang mendampingi pasien Tuberkulosis agar patuh menjalani pengobatan sampai sembuh.

R

Ronchi: adalah Suara napas tambahan abnormal, seperti mendengkur atau mengorok yang terdengar saat bernapas

S

Sanitasi: adalah upaya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan fisik tempat tinggal, yang meliputi air bersih, pembuangan limbah, dan ventilasi.

Stigma: adalah pandangan negatif yang diberikan oleh masyarakat terhadap penderita Tuberkulosis.

V

Ventilasi: adalah sistem atau saluran yang berfungsi sebagai sirkulasi udara sehingga udara segar dari luar masuk dan udara kotor di dalam ruangan keluar.

CHAPTER 4

EDUKASI KEPATUHAN MINUM OBAT, ETIKA BATUK, NUTRISI DAN VENTILASI RUMAH

Christine Bernadette Matia Rumokoy, S.Kep., Ns., M.Kep.

A. Pendahuluan

Meskipun penyakit tuberkulosis (TB) dapat dicegah dan disembuhkan, penyakit ini masih menjadi ancaman kesehatan global yang besar dan dapat menginfeksi lebih dari 10 juta orang, bahkan bisa merenggut lebih dari 1 juta nyawa setiap tahunnya (Hostettler et al., 2025). Walaupun TB dapat disembuhkan dengan pengobatan yang tepat, program pengobatan ini membutuhkan waktu yang cukup panjang selama 6 bulan. Hal ini banyak menyebabkan penderita TB menjadi tidak patuh dalam pengobatan karena merasa jenuh dan bosan (Fitriani et al., 2019). Oleh karena itu, keluarga mengambil peran penting dalam upaya pencegahan tuberkulosis (TB) karena keluarga bertugas untuk melakukan perawatan dan pemantauan minum obat (Made et al., 2022). Berdasarkan penelitian oleh Stang et al (2023), mendapat hasil bahwa keluarga adalah pengasuh/ pengawas yang lebih efektif dalam kepatuhan minum obat bagi pasien TB (Rumokoy et al., 2026). Adapun dalam bab ini akan dibahas mengenai edukasi kepatuhan minum obat, etika batuk, nutrisi, dan ventilasi rumah terutama bagi keluarga yang merawat penderita TB.

B. Edukasi Kepatuhan Minum Obat

1. Obat Anti Tuberkulosis (OAT)

Program pengobatan pada pasien tuberkulosis disebut Obat Anti Tuberkulosis (OAT). Tujuan dari program OAT yaitu (Kemenkes, 2013):

- a. Menyembuhkan, mempertahankan kualitas hidup dan produktivitas pasien,
- b. Mencegah kematian akibat TB aktif atau efek lanjutan
- c. Mencegah kekambuhan TB
- d. Mengurangi penularan TB kepada orang lain
- e. Mencegah perkembangan dan penularan resisten obat

Pemberian Obat Anti Tuberkulosis terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap awal (fase intensif) dan tahap lanjutan. Pada tahap awal, OAT diberikan setiap hari (selama 2 minggu pertama) yang bertujuan untuk menurunkan jumlah bakteri

TB yang ada dalam tubuh pasien secara cepat. Selain itu, pengobatan tahap awal juga bertujuan untuk meminimalisir resiko penularan dan untuk memperkecil pengaruh Sebagian kecil bakteri TB yang mungkin sudah resisten terhadap OAT sejak sebelum pengobatan dimulai. Apabila pada tahap ini pasien mampu menyelesaikan pengobatan secara teratur dengan dosis yang tepat, resiko penularan umumnya sudah berkurang setelah dua minggu pertama pengobatan. Setelah pengobatan selama dua minggu pertama (tahap awal), pengobatan dilanjutkan ke tahap lanjutan. Pengobatan tahap lanjutan bertujuan untuk membunuh sisa bakteri TB yang tidak bisa mati pada tahap awal. Tahap lanjutan juga bertujuan untuk mencegah kekambuhan. Pada tahap ini pengobatan dilakukan antara 4-6 bulan (PDPI, 2021).

Konsumsi rutin OAT merupakan salah satu upaya paling efisien untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dari bakteri penyebab TB. Pengobatan yang dijalani pasien dikatakan adekuat apabila memenuhi prinsip pengobatan TB sebagai berikut (Kemenkes, 2019):

- a. Pengobatan OAT yang diberikan mengandung minimal 4 macam obat untuk mencegah terjadinya resistensi
- b. Diberikan dalam dosis yang tepat
- c. Ditelan secara teratur dan diawasi secara langsung oleh PMO (pengawas menelan obat) sampai selesai masa pengobatan
- d. Pengobatan diberikan dalam jangka waktu yang cukup, dibagi dalam 2 tahap yaitu tahap awal dan tahap lanjutan untuk mencegah kekambuhan

Semua pasien yang belum pernah diobati sebelumnya dan tidak memiliki faktor resiko untuk resistensi obat harus mendapatkan pengobatan lini pertama yang sudah disetujui oleh WHO dengan menggunakan obat yang terjamin kualitasnya. Pada tahap awal (fase insentif) harus mendapat pengobatan selama dua bulan dengan menggunakan Isoniazid, Rifampisin, Pirazinamid, dan Etambutol. Kemudian ada tahap lanjut harus diberikan Isoniazid dan Rifampisin selama 4 bulan. Dosis pengobatan harus mengikuti rekomendasi WHO. Berikut dosis rekomendasi OAT lini pertama untuk dewasa.

Tabel 4.1
Dosis rekomendasi OAT lini pertama untuk dewasa

Obat	Dosis Rekomendasi			
	Harian		3 kali per minggu	
	Dosis (mg/ kgBB)	Maksimum (mg)	Dosis (mg/ kgBB)	Maksimum (mg)
Isoniazid (H)	5 (4-6)	300	10 (8-12)	900
Rifampisin (R)	10 (8-12)	600	10 (8-12)	600
Pirazinamid (Z)	25 (20-30)	-	35 (30-40)	-
Etambutol (E)	15 (15-20)	-	30 (25-35)	-
Streptomisin	15 (12-18)	-	15 (12-18)	-

Sumber: (Kemenkes RI, 2019)

2. Efek Samping OAT

Sebagian besar pasien TB yang telah menyelesaikan pengobatan, tidak mengalami efek samping pemberian obat. Namun ada beberapa yang mengalami efek samping. Efek samping yang dialami berupa efek ringan bahkan berat. Jika efek samping ringan dan dapat diatasi dengan obat simtomatis, maka pemberian OAT dapat dilanjutkan (PDPI, 2021).

a. Isoniazid

- 1) Efek samping ringan: berupa tanda-tanda gangguan pada syaraf tepi berupa kesemutan, rasa terbakar di kaki tangan, dan nyeri otot
- 2) Efek samping berat: berupa hepatitis imbas obat yang dapat timbul pada kurang lebih 0,5% pasien.

b. Rifampisin

- 1) Efek samping ringan:
 - a) Sindrom flu berupa demam, menggigil, dan nyeri tulang.
 - b) Sindrom dispepsia berupa sakit perut, mual, penurunan nafsu makan, muntah, diare.
 - c) Rifampisin dapat menyebabkan warna kemerahan pada air seni, keringat, air mata, dan air liur
- 2) Efek samping berat:
 - a) Hepatitis imbas obat dan ikterik, bila terjadi maka OAT harus diberhentikan sementara.
 - b) Purpura, anemia hemolitik akut, syok, dan gagal ginjal. Bila salah satu dari gejala ini terjadi, rifampisin harus segera dihentikan dan jangan diberikan lagi meskipun gejala telah menghilang.
 - c) Sindrom respirasi ditandai dengan sesak napas

c. Pirazinamid

- 1) Efek samping ringan: Nyeri sendi
- 2) Efek samping berat: Hepatitis imbas obat dan gout artritis

d. Etambutol

Dapat menyebabkan gangguan penglihatan berupa penurunan ketajaman penglihatan dan buta warna merah dan hijau. Gangguan penglihatan akan kembali normal dalam beberapa minggu setelah obat dihentikan.

e. Streptomisin

- 1) Efek samping utama: kerusakan saraf keseimbangan dan pendengaran. Gejala efek samping yang dapat dirasakan adalah telinga berdenging (tinitus), pusing, dan kehilangan keseimbangan. Keadaan ini dapat dipulihkan bila obat segera dihentikan atau dosisnya dikurangi.
- 2) Efek samping ringan:
 - a) Reaksi hipersensitivitas kadang terjadi berupa demam yang timbul tiba-tiba disertai sakit kepala, muntah, dan eritema pada kulit
 - b) Kesemutan sekitar mulut dan telinga berdenging dapat terjadi segera setelah suntikan

3. Definisi Hasil Pengobatan

Beberapa definisi hasil pengobatan (Kemenkes, 2019):

- a. Sembuh : Pasien TB paru dengan konfirmasi bakteriologis positif pada awal pengobatan dan BTA sputum negatif atau biakan negatif pada akhir pengobatan dan memiliki hasil pemeriksaan negatif pada salah satu pemeriksaan sebelumnya.
- b. Pengobatan lengkap : Pasien TB yang telah menyelesaikan pengobatan secara lengkap dan tidak memiliki bukti gagal pengobatan tetapi juga tidak memiliki hasil BTA sputum atau biakan negatif pada akhir pengobatan dan satu pemeriksaan sebelumnya, baik karena tidak dilakukan atau karena hasilnya tidak ada.
- c. Pengobatan gagal : Pasien TB dengan hasil pemeriksaan BTA sputum atau biakan positif pada bulan kelima atau akhir pengobatan
- d. Meninggal : Pasien TB yang meninggal dengan alasan apapun sebelum dan selama pengobatan TB
- e. Putus Obat : Pasien TB yang tidak memulai pengobatan setelah terdiagnosis TB atau menghentikan pengobatan selama 2 bulan berturut-turut atau lebih
- f. Tidak dievaluasi : Pasien yang tidak memiliki hasil pengobatan pada saat akhir pelaporan kohort pengobatan, termasuk pasien yang sudah pindah ke

fasilitas kesehatan lain dan tidak diketahui hasil pengobatannya oleh fasilitas yang merujuk pada batas akhir pelaporan kohort pengobatan.

g. Keberhasilan pengobatan : Jumlah kasus dengan hasil pengobatan sembuh dan lengkap

4. Pengawas Menelan Obat (PMO)

Untuk mencapai keberhasilan program pengobatan pasien TB, maka penderita TB memerlukan PMO (PDPI, 2021).

a. Persyaratan menjadi PMO:

- 1) Seseorang yang dikenal, dipercaya, dan disetujui, baik oleh petugas kesehatan maupun pasien, selain itu harus disegani dan dihormati oleh pasien.
- 2) Seseorang yang tinggal dekat dengan pasien
- 3) Bersedia dan sukarela membantu pasien
- 4) Bersedia dilatih dan bersama pasien mendapatkan penyuluhan

b. Tugas dari PMO:

- 1) Mengawasi pasien TB agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
- 2) Memberi dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur.
- 3) Mengingatkan pasien untuk pemeriksaan dahak pada waktu yang telah ditentukan.
- 4) Memberi penyuluhan pada anggota keluarga pasien TB yang mempunyai gejala-gejala mencurigakan TB untuk segera memeriksakan diri ke Unit Pelayanan Kesehatan.

c. Beberapa pihak yang bisa menjadi PMO:

- 1) Petugas kesehatan (misalnya bidan desa, perawat, juru imunisasi)
- 2) Orang lain yang dikenal dan dipercaya untuk menjadi PMO (misalnya tokoh masyarakat, guru, atau pemuka agama)
- 3) Suami/Istri/Keluarga/Orang serumah

5. Strategi Untuk Patuh Minum Obat

Jangka waktu pengobatan untuk penyakit TB yang lama membutuhkan kepatuhan dan kestabilan niat yang tinggi dari pasien. Edukasi peningkatan kepatuhan pasien TB merupakan hal yang harus dilakukan untuk mempertahankan niat pasien TB untuk berperilaku patuh (Adiutama et al., 2021). Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh keluarga dalam membantu pasien TB untuk memelihara niat kepatuhan minum obat anti TB:

a. Inovasi Kotak Peningat Minum Obat (KOPI) TB:

Kotak pengingat minum obat (KOPI) TB merupakan inovasi yang dapat diterapkan oleh kerluarga penderita TB. Kotak pengingat minum obat dapat menjadi alat bantu untuk pemberian OAT. KOPI TB mempunyai desain dan warna menarik, tertutup rapat, ringan, mudah dibawa, dan dilengkapi label identitas pasien. KOPI TB mencantumkan nama hari dalam seminggu serta jumlah paket obat untuk sekali minum agar dapat memudahkan pasien serta membantu untuk mengingaktan agar minum secara teratur sesuai hari untuk mengurangi resiko lupa minum obat (Noor et al., 2021).



Gambar 4.1

Kotak Pengingat Minum Obat (KOPI) TB *sumber: internet*

b. Keluarga sebagai edukator

Keluarga yang menjadi pengawas minum obat harus mendapatkan edukasi dari tenaga kesehatan untuk lebih memahami cara merawat pasien dengan baik dan menjadi pengawas menelan obat yang tepat. Peran keluarga sebagai pengawas minum obat, dapat dengan efektif mengurangi resiko kegagalan pengobatan dan meningkatkan semangat serta percaya diri pasien untuk sembuh (Ulva & Hikmi, 2024).

c. Alarm Pengingat Minum Obat

Alarm pengingat minum obat, bisa menggunakan jam alarm biasa pada ponsel atau membuat jadwal rutin untuk meminum obat TB tepat waktu setiap hari. Jangan lupa untuk mengatur alarm sesuai dengan jadwal minum obat TB di waktu yang sama setiap harinya dan ikuti anjuran dari dokter (Lailaqodriana et al., 2025).

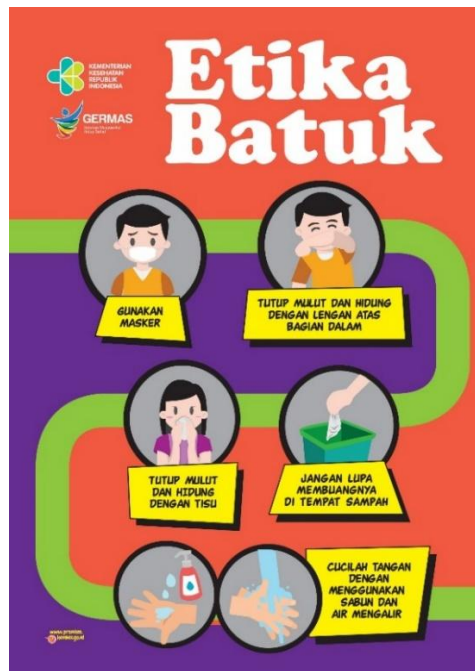
Lebih dari itu, kepatuhan minum obat pasien dapat meningkat apabila adanya dukungan dari keluarga yang baik. Disamping itu, keinginan atau motivasi untuk sembuh harus menjadi syarat penting bagi pasien. Dukungan keluargalah yang membuat pasien merasa nyaman dan lebih percaya diri dalam

menjalani pengobatan. Selain itu, dengan adanya dukungan keluarga yang baik menyebabkan pasien merasa lebih dicintai, diperhatikan, dihormati, dibantu dari sisi ekonomi, dan pasien merasa tidak terbebani dengan penyakit yang dideritanya (Siregar et al., 2019).

C. Etika Batuk

Sampai saat ini, tercatat bahwa Indonesia merupakan urutan kedua setelah India dengan kasus TB terbanyak di dunia. Negara berkembang biasanya memiliki tantangan yang serupa, seperti keterbatasan sumber daya kesehatan, rendahnya literasi kesehatan masyarakat, serta kesulitan pemantauan kepatuhan pasien (Ade et al., 2025). Meskipun berbagai upaya pengendalian TB telah dilakukan, namun penyakit ini masih menjadi ancaman besar di Indonesia (Gurusinga et al., 2024).

Etika batuk merupakan salah satu strategi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit TB. Etika batuk yang baik melibatkan kebiasaan menutup mulut dan hidung dengan tisu atau dengan lengan atas (siku bagian dalam) saat batuk atau bersin, serta segera mencuci tangan setelahnya. Cara ini dapat menjadi kebiasaan yang sangat baik untuk mengurangi penyebara bakteri TB di lingkungan sekitar. Sayangnya masih banyak yang belum tahu betapa pentingnya etika batuk yang benar (Gurusinga et al., 2024). Tujuan utama etika batuk adalah mencegah penyebaran suatu penyakit melalui udara bebas akibat *droplets* dan membuat kenyamanan pada orang sekitar. *Droplets* tersebut bisa saja mengandung kuman infeksius penyakit TB yang berpotensi menular ke orang lain disekitarnya melalui udara pernafasan (Yusuf et al., 2024).



Gambar 4.2
Etika Batuk (Kemenkes, 2024)

Etika batuk/ bersin yang benar yaitu (Birman et al., 2024):

1. Tutup hidung dan mulut saat batuk/ bersin menggunakan tisu atau lengan baju bagian dalam. Hal ini bertujuan supaya partikel virus/ bakteri tidak menyebar ke udara dan menularkan orang lain
2. Segera buang tisu yang telah dipakai ke tempat sampah
3. Cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau pencuci tangan berbasis alcohol
4. Gunakan masker

D. Nutrisi

Pada penderita TB, mereka mengalami gangguan sistem kekebalan tubuh. Gangguan sistem kekebalan tubuh pada kondisi yang parah akan menyebabkan penurunan status gizi yang dapat disebabkan oleh karena kurangnya asupan makanan yang disebabkan oleh anoreksia, malabsorpsi, dan meningkatnya penggunaan zat gizi dalam tubuh. Status gizi yang sering dialami oleh pasien TB adalah kehilangan *lean body mass* yang ditandai dengan penurunan berat badan. Umumnya, pada penyakit TB biasanya berhubungan dengan deficit kadar micronutrient serum seperti Zinc, Vitamin A, Vitamin C, Vitamin D, dan Vitamin E (Kemenkes, 2014).

Keadaan kekurangan gizi pada pasien TB dapat meningkatkan resiko hepatotoksik akibat kurang gizi yang menyebabkan hepar menjadi lebih lambat dalam proses metabolisme OAT yang kemudian toksisitas meningkat. Maka dari itu, manajemen nutrisi yang tepat sangat penting bagi pasien TB, karena banyak dari pasien TB yang tidak memperhatikan pola dan bahan yang dikonsumsi untuk kebutuhan fisik, melainkan mengonsumsi makanan apa adanya (Dewi et al., 2025).

Tuberkulosis merupakan *wasting/ consumption disease* yang disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor seperti penurunan nafsu makan dan perubahan metabolisme tubuh akibat respon inflamasi dan sistem pertahanan tubuh. Program pengobatan OAT dapat membantu peningkatan mekanisme pertahanan tubuh dengan mengurangi jumlah bakteri di dalam tubuh. Bila sistem kekebalan tubuh meningkat, maka status gizi juga akan meningkat yang mampu mempercepat kesembuhan bahkan mampu melawan infeksi penyakit di dalam tubuh (AM et al., 2024)

Zat gizi mikro yang penting bagi pasien TB adalah Vitamin A, C, D, B6, Zinc, Zat Besi, Kalsium. Untuk kebutuhan zat gizi mikro perlu disesuaikan dengan angka kecukupan gizi yang dianjurkan berdasarkan usia. Zat gizi mikro dapat diperoleh dari sumber vitamin pada bahan makanan seperti (Kemenkes, 2014):

1. Vitamin A: Diperoleh dari makanan sumber vitamin A seperti hati ayam, hati sapi, sayur berwarna hijau, dan buah berwarna jingga.
2. Vitamin C: Diperoleh dari makanan sumber vitamin C seperti sayur dan buah, misalnya jambu batu, pisang, pepaya, nanas, jambu, kelengkeng, tomat, bayam
3. Vitamin D: Diperoleh dari makanan sumber vitamin D seperti susu, makanan mengandung susu, misalnya biskuit
4. Vitamin B6: Dapat diperoleh dari suplementasi tablet vitamin B6 100mg. Juga bisa dari bahan makanan seperti kentang, kacang-kacangan, dan hati
5. Zinc: Diperoleh dari makanan sumber Zinc seperti lauk hewani dari hasil laut, sayur sawi putih
6. Zat besi (Fe): Diperoleh dari makanan sumber Fe seperti, hati, daging merah, ikan, sayuran hijau, kuning telur, kacang-kacangan. Sebaiknya tidak diberikan Fe dalam bentuk suplemen karena dapat menyebabkan multiplikasi kuman Tuberkulosis
7. Kalsium: diperoleh dari makanan sumber kalsium seperti susu dan hasil olahannya, dan buah seperti jeruk, pepaya, dan alpukat.

Pada pasien TB, selain menunjukkan penurunan berat badan, tetapi ada beberapa masalah lainnya seperti tidak nafsu makan, batuk dan sesak nafas,

demam, dan mual muntah. Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa anjuran penatalaksanaan yang berkaitan dengan asupan makanan (Kemenkes, 2014):

1. Tidak nafsu makan
 - a. Mulai dengan memberikan makanan favorit
 - b. Porsi kecil dan diberikan sering
 - c. Pilih makanan dengan densitas kalori yang tinggi
 - d. Hindari makanan dengan aroma yang menyengat
 - e. Ciptakan suasana makanan yang menyenangkan
2. Batuk dan sesak nafas
 - a. Porsi kecil diberikan sering
 - b. Memilih makanan berkuah dan bersuhu hangat
 - c. Menghindari makanan yang digoreng
 - d. Makan makanan yang lunak
 - e. Bisa sesak berat, kurangi jumlah karbohidrat dan diganti dengan sumber lemak (cth: santan, margarin, minyak)
 - f. Sumber karbohidrat diutamakan dari karbohidrat kompleks (cth roti, kentang, nasi, mie)
3. Demam
 - a. Berikan makanan yang kaya akan zat gizi misalnya sup yang isinya bervariasi
 - b. Perbanyak minum walaupun tidak haus
 - c. Penuhi kebutuhan gizi dengan derajat demamnya
4. Penurunan berat badan
 - a. Tingkatkan kualitas dan kuantitas makanan bergizi frekuensinya sering
 - b. Berikan makanan sumber protein tinggi seperti daging, telur, susu, kacang-kacangan
 - c. Mengupayakan asupan gizi secara optimal
5. Mual dan Muntah
 - a. Porsi kecil tapi sering setiap 2-3 jam
 - b. Makan secara perlahan dan hindari berbaring setelah makan. Beri jarak antara makan dan berbaring kurang lebih 20 menit
 - c. Mengurangi makanan yang memicu rasa mual, seperti makanan yang digoreng, bersantan kental, dll
 - d. Hindari kafein, makanan yang berbumbu tajam, dan alkohol
 - e. Beri makanan selingan berupa roti putih, biskuit
 - f. Jika muntah, harus banyak minum untuk ganti cairan yang hilang
 - g. Beri motivasi untuk makan sesering mungkin sesuai kemampuan

- h. Konsumsi makanan dengan jumlah banyak saat perut nyaman dan tidak mual
- i. Makan di lingkungan yang tenang dan sirkulasi udara baik
- j. Hindari aroma makanan yang dapat menimbulkan rasa mual
- k. Hindari aktivitas berat setelah makan

E. Ventilasi Rumah

Partikel bakteri *Mycobacterium tuberculosis* penyebab penyakit TB yang dikeluarkan, masih bisa menetap di udara bebas dengan waktu 1-2 jam tergantung ada atau tidaknya sinar ultraviolet, ventilasi yang buruk, dan kelembaban. Pasien TB dapat mengeluarkan sekitar 3000 percikan dahak saat batuk atau bersin. Faktor lingkungan (terutama lingkungan rumah) merupakan salah satu faktor yang berperan dalam penyebaran bakteri penyebab TB. Faktor lingkungan tersebut, di antaranya; suhu dalam rumah, ventilasi, pencahayaan rumah, kelembaban, kepadatan penghuni, dan lingkungan sekitar perumahan (Nasution & Freesia, 2025).

Jika luas rumah tidak sebanding dengan jumlah penghuni di dalamnya, maka akan mengakibatkan hunian tersebut *overcrowded*. Hal ini dapat menjadi resiko bila ada anggota keluarga yang menderita TB, maka akan mudah menularkan kepada anggota keluarga yang lain. Hal ini terjadi disebabkan karena hunian yang padat akan mempermudah perpindahan penyakit khususnya penyakit yang ditularkan melalui udara. Selain luas rumah, ventilasi rumah juga berpengaruh terhadap angka kejadian TB. Ventilasi rumah berfungsi untuk menjaga aliran udara dalam rumah tetap sejuk. Bila luas ventilasi kurang, akan menyebabkan kurangnya O₂ dan meningkatnya kadar CO₂ di rumah. Luas ventilasi yang kurang akan meningkatkan kelembaban udara karena terjadi proses penguapan cairan dari kulit. Sedangkan, kelembaban menjadi media yang digunakan bakteri pathogen untuk berkembang terutama bakteri penyebab penyakit tuberkulosis (Tatangindatu & Umboh, 2021).

Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh keluarga penderita TB berkaitan dengan ventilasi rumah, adalah (Sapriana et al., 2024):

1. Bukalah jendela dan pintu sesering mungkin, terutama di pagi dan sore hari
2. Pasang kipas angin di jendela untuk membantu mengeluarkan udara kotor
3. Pastikan tidak ada yang menghalangi aliran udara (seperti tirai tebal atau furnitur besar)
4. Jagalah kebersihan ventilasi udara, seperti kips angin agar bekerja dengan optimal

5. Tidak boleh ada yang merokok di dalam rumah
6. Baiknya di dapur ada ventilasi yang memungkinkan asap dapur keluar

Apabila tidak mampu untuk menggunakan sistem ventilasi mekanis yang terlalu mahal untuk dipasang dan pemeliharaannya, ruangan yang dirancang untuk secara alami menghasilkan aliran udara yang baik merupakan pilihan terbaik. Keuntungan lain bila menggunakan ventilasi alami adalah efisiensi biaya yang dapat diterapkan di rumah sakit bahkan di rumah pribadi (Escombe et al., 2007).

F. Simpulan

Penanggulangan penyakit Tuberkulosis (TB) di tingkat keluarga memerlukan strategi multikomponen yang mengintegrasikan aspek medis, perilaku, nutrisi, dan rekayasa lingkungan. Peran keluarga sebagai *caregiver* utama dan Pengawas Menelan Obat (PMO) menjadi faktor penentu keberhasilan pengobatan jangka panjang. Berikut adalah poin-poin inti dari strategi intervensi yang dapat dilakukan oleh keluarga:

1. Kepatuhan Minum Obat: Pengobatan TB membutuhkan waktu minimal 6 bulan melalui dua tahap (intensif dan lanjutan). Guna mengatasi kejenuhan pasien dan risiko putus obat, keluarga dapat memanfaatkan inovasi alat bantu seperti Kotak Pengingat Minum Obat (KOPI) TB dan Alarm Pengingat pada ponsel. Selain itu, keluarga harus memahami manajemen efek samping obat (baik ringan maupun berat) serta memberikan dukungan psikologis agar pasien merasa nyaman dan termotivasi untuk sembuh.
2. Penerapan Etika Batuk: Untuk memutus rantai penularan kuman melalui droplet di udara, keluarga wajib mengedukasi dan memastikan pasien menerapkan etika batuk yang benar. Kebiasaan ini meliputi penggunaan masker, menutup mulut/hidung dengan tisu atau lengan baju bagian dalam, langsung membuang tisu bekas ke tempat sampah, serta mencuci tangan secara teratur.
3. Manajemen Nutrisi: Pasien TB rentan mengalami penurunan status gizi akibat hilangnya massa tubuh (*wasting disease*). Keluarga perlu memenuhi kebutuhan zat gizi mikro (seperti Vitamin A, C, D, B6, Zinc, dan Kalsium) melalui bahan makanan sehari-hari. Keluarga juga harus menerapkan strategi pemberian makan khusus secara berkala (porsi kecil tapi sering) untuk mengatasi keluhan klinis pasien seperti mual, muntah, demam, sesak napas, dan penurunan nafsu makan.
4. Kondisi Ventilasi Rumah: Lingkungan rumah yang padat, lembap, dan minim pencahayaan memperpanjang masa hidup bakteri *Mycobacterium tuberculosis*

di udara. Keluarga disarankan memaksimalkan ventilasi alami dengan membuka pintu dan jendela sesering mungkin (terutama pagi dan sore hari), menjaga kebersihan rumah, melarang aktivitas merokok di dalam ruangan, serta memastikan aliran sirkulasi udara tidak terhambat oleh furnitur.

Kombinasi etika batuk, ventilasi rumah, pengobatan hingga tuntas, dan dukungan keluarga membentuk strategi pencegahan multikomponen yang efektif (Putri & Llismayanti, 2025).

G. Referensi

- Ade, M., Ardian, I., & Setyowati, W. E. (2025). Strategi Edukasi Interaktif Untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Kepatuhan Pendamping Minum Obat Tuberkulosis. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*.
- Adiutama, N. M., Fauzi, A. K., & Ellina, A. D. (2021). *INTERVENSI EDUKASI BERBASIS THEORY OF PLANNED BEHAVIOR UNTUK*.
- AM, F. A., Ladyani, F., Anggunan, A., & Sinaga, F. T. Y. (2024). GAMBARAN KARAKTERISTIK DAN STATUS GIZI PASIEN TUBERKULOSIS PARU FASE PENGOBATAN BARU DAN LANJUTAN DI PUSKESMAS KEDATON KOTA BANDAR LAMPUNG. In *Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan* (Vol. 11, Number 12). <http://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/kesehatan>
- Birman, Y., Rosmaini, R., & Efriza, E. (2024). PENYULUHAN ETIKA BATUK DI MESJID AL MUQARRABIN KOMPLEK KODAM KECAMATAN NANGGALO PADANG. *Jurnal Abdimas Saintika*. <https://jurnal.syedzasaintika.ac.id>
- Dewi, F. M., Susyanti, D., & Gea, H. V. (2025). MANAJEMEN NUTRISI PADA PASIEN TUBERKULOSIS PARU UNTUK MENINGKATKAN INDEKS MASSA TUBUH (IMT) DI RUMAH SAKIT TK II PUTRI HIJAU MEDAN. *Jurnal Riset Ilmiah*, 2(8), 3735–3747. <https://doi.org/10.62335>
- Escombe, A. R., Oeser, C. C., Gilman, R. H., Navincopa, M., Ticona, E., Pan, W., Martínez, C., Chacaltana, J., Rodríguez, R., Moore, D. A. J., Friedland, J. S., & Evans, C. A. (2007). Natural ventilation for the prevention of airborne contagion. *PLoS Medicine*, 4(2), 0309–0317. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0040068>
- Fitriani, D., Program, G. A., S1, S., Stikes, K., Dharma, W., Tangerang, H., Pajajaran No, J., Tangerang, P., & Banten, S. (2019). HUBUNGAN ANTARA PERAN KELUARGA SEBAGAI PENGAWAS MINUM OBAT (PMO) DENGAN TINGKAT KEPATUHAN PASIEN TB PARU TERHADAP PROGRAM PENGOBATAN DI WILAYAH PUSKESMAS SERPONG 1 KOTA TANGERANG SELATAN. In *Edudharma Journal* (Vol. 3, Number 2).
- Gurusinga, R., Yunus, A., & Putra, T. (2024). Education on Correct Cough Ethics in An Effort to Prevent the Transmission of Pulmonary TB Disease at

- Galang Health Center. *JURNAL PENGMAS KESTRA (JPK)*, 4(1), 52–56.
<https://doi.org/10.35451/jpk.v4i1.2179>
- Hostettler, K., Guglielmetti, L., Konstantynovska, O., Narayanan, N., & Huttner, A. (2025). Communicable Episode 20: Tuberculosis today. *CMI Communications*, 2(2), 105091.
<https://doi.org/10.1016/j.cmicom.2025.105091>
- Kemenkes. (2013). *Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Tuberkulosis*.
- Kemenkes. (2014). *Pedomen Pelayanan Gizi Pada Pasien Tuberkulosis*.
- Kemenkes. (2019). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Tuberkulosis*.
- Kemenkes. (2024). *Tahukah Kamu Pencegahan TBC Dapat Dimulai Dari Diri Sendiri?*
- Kemenkes RI. (2019). Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Tuberkulosis. *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/755/2019*, 139.
- Lailaqodriana, B. D., Anggraeni, N., Hasinuddin, M., & Susanti, E. (2025). INOVASI PENDAMPINGAN MINUM OBAT TB PARU MELALUI ALARM TERSETTING. *PREPOTIF Jurnal Kesehatan Masyarakat*.
- Made, N., Sukma, E., Kridawati, A., & Indrawati, L. (2022). Hubungan Peran Anggota Keluarga Dengan Kepatuhan Minum Obat Pasien Tuberkulosis di Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Denpasar Selatan Provinsi Bali Tahun 2022. 6(2), 155–167.
- Nasution, F. A. Z., & Freesia, A. (2025). THE RELATIONSHIP OF HOUSE VENTILATION CONDITIONS WITH THE INCIDENCE OF PULMONARY TB IN THE WORKING AREA OF THE TANJUNG MORAWA HEALTH CENTER. *Ibu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, 24(1).
- Noor, M. A. A., Yulita, L., & Srikartika, V. M. (2021). STUDI MANFAAT INOVASI PELAYANAN OBAT DENGAN KOPI TB (KOTAK PENGINGAT MINUM OBAT TB) DI PUSKESMAS BANJARMASIN INDAH KOTA BANJARMASIN. *Jurnal Insan Farmasi Indonesia*, 4(2), 221–226.
<https://doi.org/10.36387/jifi.v4i2.794>
- PDPI. (2021). *Tuberkulosis Pedoman Diagnosis dan Penatalaksanaan di Indonesia* (Vol. 001). Perhimpunan Dokter Paru Indonesia.
- Putri, R. M., & Llismayanti, L. (2025). Pengaruh Edukasi Etika Batuk yang Benar Upaya Mencegah Penyakit TB Paru. *Corona: Jurnal Ilmu Kesehatan*

Umum, Psikolog, Keperawatan Dan Kebidanan, 3(4), 286–292.
<https://doi.org/10.61132/corona.v3i4.1961>

- Rumokoy, C. B. M., & Rumokoy, D. G. M. (2026). Family Support As An Effort To Improve Tuberculosis Patient Rehabilitation: Systematic Review. In *Jurnal Keperawatan* (Vol. 14, Number 01).
- Sapriana, S., Sasmita, H., & Mustafa, M. (2024). Rekonstruksi Ventilasi Rumah Dengan Kasus Tuberculosis (TBC) Paru Di Wilayah Kerja Puskesmas Wani. *J.A.I: Jurnal Abdimas Indonesia*.
- Siregar, I., Siagian, P., & Effendy, E. (2019). Dukungan Keluarga meningkatkan Kepatuhan Minum Obat pada Penderita Tuberkulosis Paru di Kabupaten Tapanuli Utara. *Jurnal Kedokteran Brawijaya*, 30(4), 309–312.
<https://doi.org/10.21776/ub.jkb.2019.030.04.14>
- Tatangindatu, M. A., & Umboh, M. J. (2021). HOUSE PHYSICAL CONDITION FACTORS AND INCIDENCE OF PULMONARY TUBERCULOSIS IN COASTAL AREA. *Jurnal Ilmiah Sesebanua*, 5.
- Ulva, F., & Hikmi, N. (2024). Optimizing the Role of the Family as Supervisors of Drug Ingestion in Pulmonary TB Patients. *Jurnal Pengabdian Ilmu Kesehatan (JPIK)*, 3(1), 13–17. <https://doi.org/10.33757/jpik.v3i1.58>
- Yusuf Hanafiah, Linawati Togatorop, & Yuni Siharnida Lubis. (2024). Edukasi Etika Batuk yang Benar sebagai Upaya Preventif Penularan Tuberkulosis. *Sevaka: Hasil Kegiatan Layanan Masyarakat*, 2(2), 43–47.
<https://doi.org/10.62027/sevaka.v2i2.92>

H. Glosarium

TB: Tuberkulosis

OAT: Obat Anti Tuberkulosis

PMO: Pengawas Menelan Obat

KOPI TB: Kotak Peningat Minum Obat Tuberkulosis

Fe: Ferrum (Zat Besi)

CO₂: Karbondioksida

O₂: Oksigen

CHAPTER 5

PEMBERDAYAAN KELUARGA DALAM PENCEGAHAN PENULARAN DAN DUKUNGAN PEMULIHAN PASIEN TB PARU

Dr. Faisal Ibnu, S.Pd., S.Kep.NS., M.Kes

A. Pendahuluan

Tuberkulosis (TB) paru masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat terbesar di dunia, termasuk di Indonesia (World Health Organization, 2024). Penyakit ini disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis* yang menyerang paru-paru dan dapat menular melalui percikan droplet ketika penderita batuk, bersin, berbicara, atau meludah (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Indonesia termasuk negara dengan beban TB tertinggi di dunia sehingga upaya pencegahan dan pengendalian penyakit ini memerlukan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya tenaga kesehatan tetapi juga keluarga dan masyarakat (WHO, 2024).

TB paru bukan hanya persoalan medis, melainkan juga persoalan sosial, ekonomi, dan psikologis (Muliawati & Handayani, 2022). Pasien TB sering mengalami stigma, diskriminasi, penurunan produktivitas, gangguan psikologis, bahkan kesulitan menjalani pengobatan jangka panjang (Putri et al., 2023). Pengobatan TB membutuhkan waktu minimal enam bulan dan harus dilakukan secara teratur (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Ketidakpatuhan dalam pengobatan dapat menyebabkan kegagalan terapi, resistensi obat, hingga meningkatkan risiko penularan kepada anggota keluarga lainnya (WHO, 2024).

Dalam konteks tersebut, keluarga memiliki peran yang sangat penting. Keluarga merupakan lingkungan terdekat pasien yang berfungsi sebagai sistem pendukung utama dalam proses pengobatan dan pemulihan (Friedman, Bowden, & Jones, 2010). Keluarga dapat membantu memastikan kepatuhan minum obat, menjaga lingkungan rumah tetap sehat, memberikan dukungan emosional, serta melakukan langkah-langkah pencegahan penularan (Sari et al., 2022).

Pemberdayaan keluarga menjadi strategi penting dalam pengendalian TB paru. Pemberdayaan dimaknai sebagai proses meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesadaran, dan kemampuan keluarga agar mampu berperan aktif dalam menjaga kesehatan anggota keluarga yang menderita TB (Notoatmodjo,

2018). Dengan keluarga yang berdaya, diharapkan angka penularan dapat ditekan, kepatuhan pengobatan meningkat, dan kualitas hidup pasien menjadi lebih baik (Rahman et al., 2024).

Bab ini membahas secara komprehensif mengenai konsep pemberdayaan keluarga dalam pencegahan penularan dan dukungan pemulihan pasien TB paru. Pembahasan meliputi konsep dasar TB paru, faktor risiko penularan, peran keluarga, strategi pemberdayaan keluarga, bentuk dukungan pemulihan pasien, tantangan yang dihadapi, hingga rekomendasi implementasi di masyarakat.

B. Konsep Dasar TB Paru

1. Definisi TB Paru

Tuberkulosis paru adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis* yang terutama menyerang organ paru-paru (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Penyakit ini dapat menyerang semua kelompok usia, baik anak-anak maupun dewasa, terutama pada individu dengan daya tahan tubuh rendah (WHO, 2024).

TB paru ditularkan melalui udara ketika penderita TB aktif mengeluarkan percikan dahak yang mengandung bakteri TB paru saat batuk, bersin, atau berbicara. Orang yang berada di sekitar penderita dan menghirup udara yang telah terkontaminasi dapat tertular, terutama jika kontak terjadi dalam waktu lama di ruangan tertutup dengan ventilasi buruk (WHO, 2024).

2. Epidemiologi TB Paru

Tuberkulosis masih menjadi salah satu penyebab kematian akibat penyakit infeksi tertinggi di dunia. Laporan WHO tahun 2024 menyebutkan bahwa sekitar 10,8 juta orang mengalami TB paru dan 1,25 juta meninggal akibat penyakit ini pada tahun 2023 (WHO, 2024). Indonesia termasuk dalam negara dengan beban TB paru tertinggi di dunia bersama India dan Tiongkok (WHO, 2024).

Peningkatan kasus TB paru dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, kepadatan penduduk, malnutrisi, merokok, diabetes melitus, dan HIV/AIDS (Goletti et al., 2025). Selain itu, munculnya TB paru resisten obat menjadi tantangan besar dalam pengendalian TB global (WHO, 2024).

3. Tanda dan Gejala TB Paru

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, (2023) gejala utama TB paru adalah batuk berdahak selama dua minggu atau lebih. Gejala lain yang sering ditemukan meliputi batuk darah, demam, keringat malam, penurunan berat badan, sesak napas, serta penurunan nafsu makan (Widoyono, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka tanda dan gejala TB paru secara umum antara lain:

- a. Batuk lebih dari dua minggu.
- b. Batuk berdahak atau berdarah.
- c. Demam terutama pada malam hari.
- d. Berkeringat malam tanpa aktivitas berat.
- e. Penurunan berat badan.
- f. Nafsu makan menurun.
- g. Sesak napas dan nyeri dada.
- h. Tubuh lemah dan mudah lelah.

Apabila tanda dan gejala tersebut ditemukan, pasien TB paru perlu segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan. Diagnosis dini sangat penting untuk mencegah komplikasi dan memutus rantai penularan (WHO, 2024).

4. Pengobatan TB Paru

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, (2023) Pengobatan TB paru dilakukan menggunakan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dalam jangka waktu minimal enam bulan. Pengobatan terbagi menjadi dua tahap, yaitu:

- a. Tahap intensif.
- b. Tahap lanjutan.

Kepatuhan pasien dalam menjalani terapi menjadi faktor utama keberhasilan pengobatan (Rahman et al., 2024). Ketidakepatuhan pengobatan dapat menyebabkan resistensi obat dan meningkatkan risiko penularan di masyarakat (WHO, 2024).

C. Konsep Pemberdayaan Keluarga

1. Pengertian Pemberdayaan Keluarga

Pemberdayaan keluarga merupakan suatu proses yang bertujuan meningkatkan kemampuan keluarga agar mampu mengenali masalah kesehatan, mengambil keputusan, melakukan tindakan perawatan, serta memanfaatkan fasilitas kesehatan secara mandiri (Friedman, Bowden, & Jones, 2010). Dalam konteks kesehatan masyarakat, pemberdayaan keluarga menjadi pendekatan penting karena keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki pengaruh besar terhadap perilaku kesehatan anggota keluarga (Notoatmodjo, 2018).

Pemberdayaan keluarga tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga mencakup penguatan keterampilan, perubahan sikap,

peningkatan rasa percaya diri, dan kemampuan keluarga dalam menyelesaikan masalah kesehatan secara berkelanjutan (Kaakinen et al., 2018). Konsep ini menempatkan keluarga sebagai subjek aktif, bukan sekadar penerima layanan kesehatan pasif.

Dalam penanganan TB paru, pemberdayaan keluarga menjadi strategi penting karena proses pengobatan TB memerlukan waktu panjang, kedisiplinan tinggi, serta dukungan lingkungan yang sehat (World Health Organization, 2024). Keluarga yang diberdayakan mampu membantu pasien menjalani pengobatan secara teratur, mencegah penularan di rumah, serta memberikan dukungan psikososial selama masa pemulihan (Sari, Fitriani, & Nugroho, 2022).

Menurut teori Family Centered Care, keterlibatan keluarga dalam perawatan pasien dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mempercepat proses pemulihan pasien (Shajani & Snell, 2019). Pada pasien TB paru, keterlibatan keluarga terbukti berhubungan dengan peningkatan kepatuhan minum obat dan penurunan angka putus pengobatan (Rahman, Hidayat, & Kusuma, 2024).

2. Tujuan Pemberdayaan Keluarga

Pemberdayaan keluarga dalam penanganan TB paru memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

a. Meningkatkan Pengetahuan Keluarga

Pengetahuan yang baik mengenai penyebab, cara penularan, gejala, dan pengobatan TB sangat penting agar keluarga mampu melakukan tindakan pencegahan secara tepat (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Edukasi kesehatan terbukti meningkatkan kemampuan keluarga dalam mendukung pasien TB selama pengobatan (Pratiwi et al., 2022).

b. Meningkatkan Kemampuan Perawatan Mandiri

Keluarga diharapkan mampu melakukan perawatan dasar secara mandiri, seperti mengingatkan jadwal minum obat, menjaga kebersihan lingkungan, serta memantau kondisi pasien di rumah (Friedman et al., 2010).

c. Mencegah Penularan TB dalam Keluarga

Pemberdayaan keluarga bertujuan meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya ventilasi rumah, etika batuk, penggunaan masker, dan pemeriksaan kontak serumah untuk memutus rantai penularan TB (WHO, 2024).

d. Meningkatkan Kepatuhan Pengobatan

Kepatuhan pengobatan merupakan faktor utama keberhasilan terapi TB. Dukungan keluarga terbukti meningkatkan motivasi pasien dalam menjalani terapi jangka panjang (Rahman et al., 2024).

e. Mengurangi Stigma dan Diskriminasi

Pemberdayaan keluarga juga bertujuan mengurangi stigma negatif terhadap pasien TB. Sikap keluarga yang suportif dapat membantu pasien merasa diterima dan meningkatkan kesehatan mental pasien (Putri, Wahyuni, & Lestari, 2023).

3. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Keluarga

Terdapat beberapa prinsip dalam pemberdayaan keluarga antara lain:

a. Partisipatif

Keluarga harus dilibatkan secara aktif dalam proses perawatan pasien dan pengambilan keputusan kesehatan (Kaakinen et al., 2018). Pendekatan partisipatif membuat keluarga merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan pengobatan pasien.

b. Edukatif

Pemberdayaan dilakukan melalui proses pendidikan kesehatan yang berkesinambungan. Informasi yang diberikan harus mudah dipahami dan sesuai dengan kondisi sosial budaya keluarga (Notoatmodjo, 2018).

c. Kemandirian

Tujuan akhir pemberdayaan adalah terciptanya keluarga mandiri dalam menjaga kesehatan anggota keluarganya (Padila, 2013). Keluarga diharapkan tidak selalu bergantung pada tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan sederhana.

d. Holistik

Pendekatan pemberdayaan keluarga harus memperhatikan aspek biologis, psikologis, sosial, ekonomi, dan spiritual pasien (Friedman et al., 2010).

e. Berbasis Komunitas

Pemberdayaan keluarga akan lebih efektif jika didukung oleh masyarakat, kader kesehatan, dan lingkungan sekitar (WHO, 2024).

4. Dimensi Pemberdayaan Keluarga

Menurut teori keperawatan keluarga, pemberdayaan keluarga mencakup beberapa dimensi berikut:

a. Dimensi Pengetahuan

Pengetahuan keluarga mengenai TB sangat menentukan perilaku pencegahan dan kepatuhan pengobatan pasien (Sari et al., 2022).

b. Dimensi Sikap

Sikap positif keluarga terhadap pasien dapat meningkatkan kenyamanan dan motivasi pasien selama menjalani terapi (Putri et al., 2023).

c. Dimensi Keterampilan

Keluarga perlu memiliki keterampilan praktis seperti cara menjaga ventilasi rumah, mendampingi pasien kontrol, dan memantau efek samping obat (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

d. Dimensi Dukungan Sosial

Dukungan sosial keluarga berpengaruh terhadap kesehatan mental pasien dan keberhasilan pengobatan TB (Shajani & Snell, 2019).

e. Dimensi Spiritual

Pendekatan spiritual dapat membantu pasien lebih optimis dan kuat menghadapi penyakit kronis (Padila, 2013).

5. Bentuk Pemberdayaan Keluarga pada Pasien TB Paru

a. Edukasi Kesehatan

Edukasi kesehatan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman keluarga mengenai TB paru, cara penularan, pentingnya kepatuhan pengobatan, dan pola hidup sehat (WHO, 2024).

b. Pendampingan Pengobatan

Keluarga dapat berperan sebagai Pengawas Menelan Obat (PMO) yang membantu memastikan pasien meminum obat sesuai jadwal (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

c. Modifikasi Lingkungan Rumah

Keluarga diberdayakan untuk menciptakan lingkungan sehat melalui perbaikan ventilasi, pencahayaan, dan kebersihan rumah (Pratiwi et al., 2022).

d. Dukungan Nutrisi

Pemenuhan nutrisi yang baik membantu meningkatkan daya tahan tubuh pasien TB paru (WHO, 2024).

e. Dukungan Psikososial

Dukungan emosional keluarga membantu mengurangi stres, kecemasan, dan stigma yang dialami pasien (Putri et al., 2023).

6. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pemberdayaan Keluarga

Menurut Notoatmodjo, (2018) ada beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan pemberdayaan keluarga antara lain:

- a. Tingkat pendidikan keluarga.
- b. Kondisi ekonomi keluarga.
- c. Dukungan tenaga kesehatan.
- d. Akses pelayanan kesehatan.

- e. Dukungan sosial masyarakat.
- f. Budaya dan kepercayaan masyarakat.
- g. Literasi kesehatan keluarga (Notoatmodjo, 2018).

Keluarga dengan literasi kesehatan yang baik cenderung lebih mampu memahami instruksi pengobatan dan menerapkan perilaku pencegahan TB secara efektif (Rahman et al., 2024).

7. Strategi Pemberdayaan Keluarga dalam Pencegahan dan Pemulihan TB Paru

Strategi pemberdayaan keluarga dalam pencegahan dan pemulihan TB paru merupakan pendekatan penting dalam pengendalian tuberkulosis berbasis keluarga dan komunitas. Pendekatan ini menempatkan keluarga sebagai mitra utama tenaga kesehatan dalam mendukung keberhasilan pengobatan, mencegah penularan, serta meningkatkan kualitas hidup pasien TB (World Health Organization, 2022). Konsep tersebut sejalan dengan pendekatan *patient-centered care* dan *family-centered care* yang direkomendasikan WHO dalam strategi eliminasi TB global.

Menurut WHO, pemberdayaan keluarga dilakukan melalui penguatan edukasi kesehatan, dukungan psikososial, pendampingan pengobatan, serta peningkatan kemampuan keluarga dalam menciptakan lingkungan rumah yang sehat dan aman bagi pasien TB (WHO, 2022). Strategi ini juga menekankan pentingnya keterlibatan keluarga dalam deteksi dini dan pemeriksaan kontak serumah sebagai bagian dari upaya memutus rantai penularan TB.

a. Strategi Menurut WHO

WHO melalui *End TB Strategy* menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian TB memerlukan pendekatan pelayanan yang terintegrasi, berpusat pada pasien, dan melibatkan keluarga serta komunitas (*integrated patient-centered care and prevention*) (WHO, 2015). Beberapa strategi pemberdayaan keluarga menurut WHO meliputi:

1) Edukasi dan Konseling Keluarga

WHO merekomendasikan pemberian edukasi secara berkelanjutan kepada keluarga mengenai penyebab TB, cara penularan, pentingnya kepatuhan pengobatan, dan upaya pencegahan penularan di rumah (WHO, 2022). Edukasi kesehatan terbukti meningkatkan kemampuan keluarga dalam mendukung pasien menjalani terapi jangka panjang.

2) Pendekatan Family-Centered Care

WHO menekankan pentingnya pendekatan *family-centered care*, yaitu pelayanan kesehatan yang melibatkan keluarga dalam setiap proses

pengambilan keputusan dan perawatan pasien TB (WHO, 2022). Pendekatan ini mencakup dukungan emosional, sosial, ekonomi, dan spiritual bagi pasien maupun keluarga.

3) Pemeriksaan Kontak Serumah

WHO merekomendasikan skrining dan investigasi kontak serumah sebagai strategi utama pencegahan TB. Anggota keluarga yang tinggal serumah dengan pasien TB aktif perlu menjalani pemeriksaan untuk mendeteksi penularan sedini mungkin.

4) Dukungan Kepatuhan Pengobatan

WHO menyatakan bahwa dukungan keluarga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan TB. Bentuk dukungan dapat berupa pengawasan minum obat, pengingat jadwal kontrol, serta pemberian motivasi selama terapi berlangsung.

5) Dukungan Sosial dan Ekonomi

WHO juga menekankan pentingnya dukungan sosial dan ekonomi bagi keluarga pasien TB untuk mencegah beban finansial akibat penyakit TB (*catastrophic cost*) (WHO, 2015).

b. Strategi Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui *Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis* menekankan bahwa keluarga memiliki peran strategis dalam keberhasilan terapi TB dan pencegahan penularan di lingkungan rumah (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Adapun strategi pemberdayaan keluarga menurut Kemenkes (2023) meliputi:

1) Penguatan Peran Pengawas Menelan Obat (PMO)

Keluarga didorong menjadi Pengawas Menelan Obat (PMO) untuk memastikan pasien meminum Obat Anti Tuberkulosis (OAT) secara teratur hingga selesai pengobatan (Kemenkes RI, 2023).

2) Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Keluarga diedukasi untuk menerapkan PHBS seperti membuka ventilasi rumah, menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan masker, dan menerapkan etika batuk guna mencegah penularan TB. Strategi ini sangat penting terutama pada rumah dengan kepadatan hunian tinggi.

3) Edukasi Gizi Keluarga

Kemenkes menekankan pentingnya pemenuhan nutrisi pasien TB melalui konsumsi makanan bergizi tinggi protein dan kalori untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mempercepat pemulihan pasien.

4) Kunjungan Rumah dan Pendampingan Keluarga

Puskesmas bersama kader kesehatan melakukan kunjungan rumah untuk memberikan edukasi, pemantauan kepatuhan pengobatan, dan pendampingan keluarga pasien TB.

5) Pemberdayaan Kader dan Masyarakat

Kader kesehatan berperan sebagai penghubung antara tenaga kesehatan dengan keluarga pasien melalui penyuluhan, pelacakan kasus, dan pendampingan pasien TB di masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas bahwa strategi pemberdayaan keluarga dalam pencegahan dan pemulihan TB Paru menurut para ahli antara lain:

1) Friedman, Bowden, dan Jones (2010)

Friedman menyatakan bahwa keluarga memiliki fungsi perawatan kesehatan (*health care function*) yang meliputi kemampuan mengenali masalah kesehatan, mengambil keputusan, melakukan perawatan anggota keluarga sakit, mempertahankan lingkungan sehat, dan memanfaatkan fasilitas kesehatan. Dalam kasus TB, keluarga menjadi sistem pendukung utama pasien selama proses pengobatan jangka panjang.

2) Notoatmodjo (2018)

Notoatmodjo menjelaskan bahwa pemberdayaan keluarga dilakukan melalui promosi kesehatan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan keluarga dalam menjaga kesehatan anggota keluarga. Pendidikan kesehatan menjadi strategi utama dalam mengubah perilaku pencegahan penularan TB.

3) Kaakinen et al. (2018)

Kaakinen menjelaskan bahwa pendekatan *family nursing* menempatkan keluarga sebagai pusat intervensi kesehatan. Dukungan keluarga yang baik dapat meningkatkan kepatuhan terapi, mengurangi kecemasan pasien, serta meningkatkan kualitas hidup pasien penyakit kronis termasuk TB paru.

4) Rahman et al. (2024)

Hasil *systematic review* menunjukkan bahwa intervensi pemberdayaan keluarga efektif meningkatkan kepatuhan minum obat pasien TB, memperbaiki dukungan psikososial, dan menurunkan angka putus pengobatan. Pendekatan berbasis keluarga dinilai lebih efektif dibandingkan pendekatan individual semata.

5) Putri et al. (2023)

Penelitian Putri menemukan bahwa stigma sosial menjadi salah satu hambatan utama pengobatan TB. Dukungan keluarga yang positif dapat membantu pasien lebih percaya diri dan mengurangi stres psikologis selama menjalani terapi TB.

8. Bentuk Implementasi Pemberdayaan Keluarga di Masyarakat

a. Pendidikan dan Penyuluhan Kesehatan

Pendidikan kesehatan merupakan strategi utama dalam implementasi pemberdayaan keluarga. Penyuluhan bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai TB paru, cara penularan, pentingnya pengobatan teratur, dan pencegahan penularan dalam rumah tangga (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Kegiatan penyuluhan dapat dilakukan melalui:

- 1) Posyandu dan posbindu.
- 2) Kegiatan PKK.
- 3) Penyuluhan di sekolah.
- 4) Kegiatan keagamaan.
- 5) Pertemuan RT/RW.
- 6) Media sosial dan media digital.

Menurut WHO (2022), edukasi berbasis komunitas efektif meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap TB dan membantu menurunkan stigma terhadap pasien TB. Penelitian Pratiwi, Kurniawan, dan Lestari (2022) menunjukkan bahwa edukasi kesehatan berbasis keluarga dapat meningkatkan perilaku pencegahan penularan TB pada anggota keluarga serumah.

b. Kunjungan Rumah (*Home Visit*)

Kunjungan rumah merupakan salah satu bentuk implementasi pemberdayaan keluarga yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan kader kesehatan (Padila, 2013). Melalui kunjungan rumah, petugas kesehatan dapat:

- 1) Menilai kondisi lingkungan rumah pasien.
- 2) Memberikan edukasi langsung kepada keluarga.
- 3) Memantau kepatuhan pengobatan pasien.
- 4) Memberikan dukungan psikososial.
- 5) Mengidentifikasi hambatan pengobatan.

Pendekatan *home visit* dinilai efektif meningkatkan keterlibatan keluarga dalam perawatan pasien TB paru (Rahman, Hidayat, & Kusuma, 2024). WHO

(2024) merekomendasikan pendekatan berbasis rumah tangga sebagai bagian penting dalam strategi deteksi dini dan pencegahan penularan TB.

c. Pembentukan Kelompok Dukungan TB

Kelompok dukungan TB (*TB support group*) merupakan wadah bagi pasien dan keluarga untuk saling berbagi pengalaman, motivasi, dan informasi terkait pengobatan TB (Kaakinen et al., 2018).

Kelompok dukungan dapat membantu:

- 1) Mengurangi stigma terhadap pasien TB.
- 2) Meningkatkan motivasi pengobatan.
- 3) Meningkatkan dukungan sosial keluarga.
- 4) Membantu pasien mengatasi masalah psikologis.

WHO (2022) menyebutkan bahwa dukungan sosial berbasis komunitas dapat meningkatkan keberhasilan pengobatan TB dan menurunkan angka putus obat.

d. Pemberdayaan Kader Kesehatan

Kader kesehatan memiliki peran strategis dalam implementasi pemberdayaan keluarga di masyarakat karena kader merupakan bagian dari komunitas yang memahami kondisi sosial budaya masyarakat setempat (Notoatmodjo, 2018).

Peran kader kesehatan meliputi:

- 1) Memberikan penyuluhan tentang TB.
- 2) Mengidentifikasi suspek TB.
- 3) Mendampingi pasien selama pengobatan.
- 4) Memantau kepatuhan minum obat.
- 5) Membantu pelacakan kontak serumah.

Keterlibatan kader kesehatan terbukti membantu meningkatkan cakupan penemuan kasus dan keberhasilan terapi TB di masyarakat (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

e. Pelaksanaan Program Pengawas Menelan Obat (PMO)

Program Pengawas Menelan Obat (PMO) merupakan implementasi penting dalam pemberdayaan keluarga pasien TB. Anggota keluarga dapat berperan sebagai PMO untuk memastikan pasien meminum obat secara teratur hingga pengobatan selesai (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Keluarga sebagai PMO memiliki tugas:

- 1) Mengingat jadwal minum obat.
- 2) Memastikan obat diminum sesuai dosis.

3) Mengawasi efek samping obat.

4) Mendampingi pasien kontrol rutin.

Penelitian Sari, Fitriani, dan Nugroho (2022) menunjukkan bahwa dukungan keluarga sebagai PMO berhubungan signifikan dengan peningkatan kepatuhan pengobatan pasien TB paru.

f. Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Implementasi pemberdayaan keluarga juga dilakukan melalui pembiasaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan rumah dan masyarakat (Notoatmodjo, 2018).

Bentuk perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) meliputi:

1) Membuka ventilasi rumah setiap hari.

2) Menjaga kebersihan lingkungan.

3) Menggunakan masker saat batuk.

4) Menerapkan etika batuk.

5) Mengonsumsi makanan bergizi.

6) Tidak merokok di dalam rumah.

Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) membantu mengurangi risiko penularan TB dalam keluarga dan masyarakat (WHO, 2024).

g. Pemanfaatan Media Digital dan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi memungkinkan implementasi pemberdayaan keluarga dilakukan melalui media digital seperti:

1) Edukasi kesehatan online.

2) Grup WhatsApp pendampingan pasien.

3) Pengingat jadwal minum obat.

4) Konseling daring.

5) Media sosial edukasi TB.

WHO (2022) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat membantu meningkatkan kepatuhan pengobatan dan akses informasi kesehatan bagi pasien TB.

9. Faktor Pendukung Implementasi Pemberdayaan Keluarga

Keberhasilan implementasi pemberdayaan keluarga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

a. Dukungan Tenaga Kesehatan

Pendampingan tenaga kesehatan membantu keluarga memahami cara perawatan pasien TB secara benar (Padila, 2013).

b. Dukungan Sosial Masyarakat

Lingkungan masyarakat yang suportif membantu mengurangi stigma terhadap pasien TB (Putri, Wahyuni, & Lestari, 2023).

c. Literasi Kesehatan Keluarga

Keluarga dengan tingkat pengetahuan yang baik lebih mudah menerima edukasi dan menerapkan perilaku pencegahan TB (Notoatmodjo, 2018).

d. Kebijakan Pemerintah

Program nasional pengendalian TB mendukung implementasi pemberdayaan keluarga melalui pendekatan berbasis komunitas (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

10. Hambatan dan Dampak Dalam Implementasi Pemberdayaan Keluarga

Meskipun memiliki manfaat besar, implementasi pemberdayaan keluarga masih menghadapi berbagai hambatan, seperti:

- a. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.
- b. Stigma terhadap pasien TB.
- c. Keterbatasan ekonomi keluarga.
- d. Kepadatan hunian.
- e. Kurangnya tenaga kesehatan.
- f. Rendahnya kepatuhan pengobatan.
- g. Kurangnya akses informasi kesehatan.

WHO (2024) menyebutkan bahwa stigma dan hambatan sosial ekonomi masih menjadi tantangan utama dalam pengendalian TB di negara berkembang.

Adapun dampak implementasi pemberdayaan keluarga dalam penanggulangan TB paru, antara lain:

- a. Meningkatkan kepatuhan pengobatan pasien.
- b. Menurunkan angka putus obat.
- c. Mengurangi risiko penularan TB dalam rumah tangga.
- d. Meningkatkan kualitas hidup pasien.
- e. Mengurangi stigma masyarakat terhadap TB.
- f. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian TB.

Penelitian Rahman et al. (2024) menunjukkan bahwa intervensi berbasis keluarga efektif meningkatkan keberhasilan terapi dan memperkuat dukungan sosial pasien TB paru.

11. Peran Tenaga Kesehatan dalam Pemberdayaan Keluarga

Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam keberhasilan program pemberdayaan keluarga pada pasien TB paru. Pemberdayaan keluarga tidak

dapat berjalan optimal tanpa adanya dukungan, pendampingan, edukasi, dan fasilitasi dari tenaga kesehatan. Dalam pendekatan *family-centered care*, tenaga kesehatan berfungsi sebagai mitra keluarga dalam membantu pasien menjalani proses pengobatan dan pemulihan secara menyeluruh (Kaakinen et al., 2018).

Menurut World Health Organization (WHO, 2022), tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan TB yang berpusat pada pasien dan keluarga (*patient and family-centered care*). Pendekatan ini menempatkan keluarga sebagai bagian integral dalam proses pengobatan, pencegahan penularan, dan dukungan psikososial pasien TB paru. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2023) juga menegaskan bahwa tenaga kesehatan memiliki peran strategis dalam meningkatkan pengetahuan keluarga, membangun perilaku hidup sehat, meningkatkan kepatuhan pengobatan, dan memfasilitasi keluarga dalam menciptakan lingkungan rumah yang mendukung proses penyembuhan pasien TB.

Adapun bentuk peran tenaga kesehatan dalam pemberdayaan keluarga antara lain:

a. Sebagai Edukator

Peran utama tenaga kesehatan adalah sebagai edukator yang memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarga mengenai penyakit TB paru (Notoatmodjo, 2018). Edukasi kesehatan bertujuan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan keluarga dalam melakukan pencegahan serta perawatan pasien secara mandiri.

Materi edukasi kesehatan yang diberikan meliputi:

- 1) Penyebab dan cara penularan TB.
- 2) Gejala dan tanda TB paru.
- 3) Pentingnya kepatuhan minum obat.
- 4) Cara mencegah penularan di rumah.
- 5) Etika batuk dan penggunaan masker.
- 6) Pentingnya nutrisi dan pola hidup sehat.

Pendidikan kesehatan yang baik terbukti meningkatkan perilaku pencegahan TB dan kepatuhan pengobatan pasien (Pratiwi, Kurniawan, & Lestari, 2022). Menurut WHO (2022), edukasi keluarga merupakan komponen utama dalam pengendalian TB berbasis komunitas karena keluarga yang memiliki pengetahuan baik cenderung lebih aktif mendukung proses pengobatan pasien.

b. Sebagai Konselor

Pasien TB paru sering mengalami tekanan psikologis seperti rasa takut, malu, cemas, bahkan depresi akibat stigma sosial dan proses pengobatan yang panjang (Putri, Wahyuni, & Lestari, 2023). Dalam kondisi ini, tenaga kesehatan berperan sebagai konselor yang membantu pasien dan keluarga menghadapi masalah emosional maupun sosial.

Peran sebagai konselor meliputi:

- 1) Memberikan dukungan psikologis.
- 2) Membantu keluarga memahami kondisi pasien.
- 3) Mengurangi stigma terhadap pasien TB.
- 4) Membantu keluarga mengatasi konflik selama perawatan.
- 5) Memberikan motivasi agar pasien tetap menjalani pengobatan.

Pendekatan konseling yang baik dapat meningkatkan motivasi pasien dan memperkuat dukungan keluarga terhadap proses pemulihan (Kaakinen et al., 2018).

c. Sebagai Motivator

Pengobatan TB memerlukan waktu panjang sehingga pasien sering mengalami kejenuhan dan kelelahan selama terapi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu berperan sebagai motivator bagi pasien dan keluarga.

Motivasi dapat diberikan melalui:

- 1) Penguatan positif mengenai peluang kesembuhan TB.
- 2) Memberikan apresiasi terhadap kepatuhan pasien.
- 3) Mendorong keluarga tetap mendukung pasien.
- 4) Membantu pasien mempertahankan semangat pengobatan.

Penelitian Rahman, Hidayat, dan Kusuma (2024) menunjukkan bahwa dukungan motivasional dari tenaga kesehatan dan keluarga dapat meningkatkan keberhasilan pengobatan pasien TB paru.

d. Sebagai Fasilitator

Tenaga kesehatan berperan sebagai fasilitator yang membantu keluarga memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan dan sumber daya yang dibutuhkan pasien TB (Friedman, Bowden, & Jones, 2010).

Bentuk fasilitator meliputi:

- 1) Membantu akses pemeriksaan TB.
- 2) Menghubungkan keluarga dengan program bantuan kesehatan.
- 3) Memfasilitasi pemeriksaan kontak serumah.

- 4) Menyediakan informasi layanan rujukan.
- 5) Membantu keluarga mendapatkan dukungan sosial.

WHO (2022) menekankan pentingnya akses layanan kesehatan yang mudah dan terjangkau untuk meningkatkan keberhasilan program pengendalian TB.

e. Sebagai Advokat

Tenaga kesehatan juga berperan sebagai advokat dalam melindungi hak pasien TB dan keluarganya (Notoatmodjo, 2018). Peran advokasi dilakukan dengan cara:

- 1) Mengurangi diskriminasi terhadap pasien TB.
- 2) Memberikan edukasi kepada masyarakat.
- 3) Memperjuangkan akses pengobatan yang setara.
- 4) Mendukung kebijakan kesehatan berbasis keluarga.

Advokasi penting dilakukan karena stigma dan diskriminasi masih menjadi hambatan utama dalam penanggulangan TB di masyarakat (Putri et al., 2023).

f. Sebagai Koordinator Pelayanan Kesehatan

Dalam penanganan TB paru, tenaga kesehatan berperan mengoordinasikan berbagai layanan yang dibutuhkan pasien dan keluarga, baik pelayanan medis, psikososial, maupun kesehatan lingkungan (WHO, 2024).

Koordinasi dilakukan melalui:

- 1) Pemantauan kepatuhan pengobatan.
- 2) Kolaborasi dengan kader kesehatan.
- 3) Kunjungan rumah (*home visit*).
- 4) Pelaporan dan monitoring pasien TB.
- 5) Pendampingan keluarga selama terapi.

Pendekatan kolaboratif membantu meningkatkan keberhasilan program pemberdayaan keluarga dan pengendalian TB di masyarakat.

D. Simpulan

Tuberkulosis paru masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat utama di dunia, termasuk di Indonesia. Tingginya angka kejadian TB paru menunjukkan bahwa pengendalian penyakit ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya berfokus pada aspek medis tetapi juga melibatkan faktor sosial, psikologis, lingkungan, dan keluarga. Keluarga memiliki posisi strategis sebagai sistem pendukung utama dalam pencegahan penularan dan pemulihan pasien TB paru.

Pemberdayaan keluarga merupakan pendekatan penting dalam upaya pengendalian TB paru karena keluarga berperan langsung dalam mendukung kepatuhan pengobatan, menjaga lingkungan rumah yang sehat, memberikan dukungan emosional dan psikososial, serta membantu memenuhi kebutuhan dasar pasien selama proses terapi. Keluarga yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik mampu membantu memutus rantai penularan TB melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, etika batuk, penggunaan masker, serta pengawasan pengobatan pasien secara teratur.

Implementasi pemberdayaan keluarga di masyarakat dapat dilakukan melalui pendidikan kesehatan, kunjungan rumah (*home visit*), pembentukan kelompok dukungan TB, pemberdayaan kader kesehatan, pemanfaatan media digital, dan penguatan peran Pengawas Menelan Obat (PMO). Keberhasilan implementasi tersebut memerlukan dukungan tenaga kesehatan, pemerintah, masyarakat, dan berbagai sektor terkait agar keluarga mampu menjalankan fungsi perawatan kesehatan secara optimal.

Tenaga kesehatan memiliki peran penting sebagai edukator, konselor, motivator, fasilitator, advokat, dan koordinator pelayanan kesehatan dalam mendukung keberhasilan pemberdayaan keluarga. Pendekatan *family-centered care* dan *community-based care* menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan TB yang lebih holistik dan berkelanjutan.

Dengan pemberdayaan keluarga yang optimal, diharapkan angka penularan TB dapat ditekan, kepatuhan pengobatan meningkat, angka putus obat menurun, dan kualitas hidup pasien TB paru menjadi lebih baik. Pendekatan berbasis keluarga juga menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung tercapainya target eliminasi TB di Indonesia dan dunia.

E. Penutup

Pemberdayaan keluarga dalam pencegahan penularan dan dukungan pemulihan pasien TB paru merupakan salah satu strategi penting dalam pengendalian tuberkulosis yang berkelanjutan. Keluarga bukan hanya sebagai pendamping pasien, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam menciptakan lingkungan sehat dan mendukung keberhasilan terapi TB.

Melalui peningkatan pengetahuan, penguatan dukungan sosial, pendampingan pengobatan, dan keterlibatan aktif masyarakat, keluarga dapat berkontribusi besar dalam menurunkan risiko penularan TB serta meningkatkan kualitas hidup pasien selama masa pengobatan. Dukungan emosional, spiritual,

dan instrumental dari keluarga terbukti memberikan dampak positif terhadap motivasi dan keberhasilan terapi pasien TB paru.

Keberhasilan pemberdayaan keluarga memerlukan kolaborasi yang kuat antara tenaga kesehatan, pemerintah, kader kesehatan, institusi pendidikan, dan masyarakat. Edukasi yang berkesinambungan, pengurangan stigma terhadap TB, serta penguatan layanan kesehatan berbasis keluarga perlu terus dikembangkan agar upaya pengendalian TB dapat berjalan secara efektif dan merata.

Diharapkan book chapter ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi ilmiah bagi tenaga kesehatan, akademisi, mahasiswa, serta masyarakat dalam memahami pentingnya pemberdayaan keluarga dalam penanggulangan TB paru. Dengan sinergi dan kepedulian bersama, target eliminasi tuberkulosis bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai

F. Referensi

- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Friedman, M. M., Bowden, V. R., & Jones, E. G. (2010). *Family nursing: Research, theory, and practice*. New Jersey: Pearson Education.
- Goletti, D., Meintjes, G., Andrade, B. B., Zumla, A., & Lee, S. S. (2025). *Insights from the 2024 WHO Global Tuberculosis Report – More comprehensive action, innovation, and investments required for achieving WHO End TB goals*. International Journal of Infectious Diseases, 150, 107325. <https://doi.org/10.1016/j.ijid.2024.107325>
- House, J. S. (1981). *Work stress and social support*. Massachusetts: Addison-Wesley.
- Kaakinen, J. R., Coehlo, D. P., Steele, R., Robinson, M., & Hanson, S. M. H. (2018). *Family health care nursing: Theory, practice, and research* (6th ed.). Philadelphia: F.A. Davis Company.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Profil Kesehatan Indonesia 2023*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Muliawati, D., & Handayani, S. (2022). Psychological impact among pulmonary tuberculosis patients during long-term treatment. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 25(2), 115–123.
- Notoatmodjo, S. (2018). *Promosi kesehatan dan perilaku kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Padila. (2013). *Keperawatan keluarga*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Pratiwi, D., Kurniawan, B., & Lestari, P. (2022). Family-based tuberculosis prevention behavior in household contacts. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 17(2), 85–94.
- Putri, A. N., Wahyuni, T., & Lestari, D. (2023). Stigma and treatment adherence among tuberculosis patients in Indonesia. *International Journal of Public Health Science*, 12(1), 44–52.
- Rahman, F., Hidayat, R., & Kusuma, A. (2024). Family empowerment intervention in improving tuberculosis treatment adherence: A systematic review. *BMC Public Health*, 24(1), 1–12.
- Sari, N., Fitriani, D., & Nugroho, A. (2022). Family support and medication adherence among pulmonary tuberculosis patients. *Belitung Nursing Journal*, 8(3), 221–229.
- Shajani, Z., & Snell, D. (2019). *Wright & Leahey's nurses and families: A guide to family assessment and intervention*. Philadelphia: F.A. Davis.
- Widoyono. 2019. *Penyakit Tropis: Epidemiologi, Penularan, Pencegahan dan Pemberantasannya*. Jakarta: Erlangga.
- World Health Organization. (2015). *The End TB Strategy*. Geneva: WHO. <https://www.who.int/publications-detail-redirect/WHO-HTM-TB-2015.19>
- World Health Organization. (2022). *WHO operational handbook on tuberculosis: Module 4: Treatment – tuberculosis care and support*. Geneva: WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240053519>
- World Health Organization. (2024). *Global tuberculosis report 2024*. Geneva: WHO. <https://iris.who.int/handle/10665/379339>
- World Health Organization. 2023. *Global Tuberculosis Report*. Geneva: WHO.
- Zakaria, Y. 2021. *Manajemen Keperawatan Komunitas*. Bandung: Refika Aditama.

G. Glosarium

- Bakteri:** Mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit tertentu.
- Droplet:** Percikan cairan kecil yang keluar saat seseorang batuk, bersin, atau berbicara.
- Etika Batuk:** Tata cara batuk yang benar untuk mencegah penyebaran penyakit.
- Kepatuhan Pengobatan:** Kedisiplinan pasien dalam menjalani pengobatan sesuai anjuran.
- Koinfeksi:** Kondisi ketika seseorang mengalami lebih dari satu jenis infeksi secara bersamaan.

Mycobacterium Tuberculosis: Bakteri penyebab penyakit tuberculosi paru.

Obat Anti Tuberkulosis (OAT): Obat yang digunakan untuk mengobati penyakit TB paru.

Pemberdayaan: Proses meningkatkan kemampuan individu atau kelompok agar mandiri.

Pengawas Menelan Obat (PMO): seseorang yang dipercaya untuk memantau dan memastikan pasien Tuberkulosis (TBC) meminum obatnya secara teratur dan tuntas sesuai jadwal.

Resistensi Obat: Kondisi ketika obat tidak lagi efektif melawan bakteri.

Stigma: Pandangan negatif atau diskriminatif terhadap seseorang atau kelompok.

Tuberkulosis (TB): Penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis*.

Ventilasi: Sistem pertukaran udara dalam ruangan.

PROFIL PENULIS



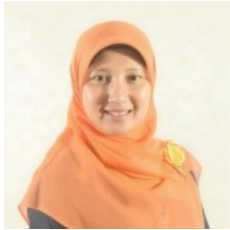
Nur Fadhilah, S.Kep., M.Kes., Ph.D., lahir di Gisting Kabupaten Tanggamus, 20 Juli 1975 dari seorang ayah bernama Khozin Abdullah dan ibu Fairah Marhamah. Menikah dengan M.Yusup dan dikarunia 2 orang putra (M. Haeqal Phasa & M. Zidane Al-Ghifarry) dan seorang putri (Keysha Yasmine Asshafira). Pendidikan terakhir S3 diselesaikan di Mahsa University Malaysia tahun 2023. Kariernya dimulai pada tahun 1998 sebagai perawat pelaksana di RSUAM Propinsi Lampung, di tahun yang sama penulis bekerja di Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Aktif sebagai dosen pengajar pada tahun 2000 sampai dengan sekarang dengan kekhususan Mata Kuliah; Keperawatan Komunitas, Keperawatan Keluarga, Keperawatan Gerontik, Promosi Kesehatan, dan Metode Penelitian. Sebagai bentuk dedikasi penulis dalam dunia pendidikan, penulis telah menghasilkan berbagai buku dan karya ilmiah, program penanggulangan TBC adalah satu aktivitas social yang dilakukan penulis berkoordinasi dengan dinas terkait. Saat ini penulis menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan PPNI Kabupaten Pringsewu, Kood. Indonesia Ramah Lansia (IRL) Kota, sebagai ketua Majelis Kesehatan PDA Kota Bandar Lampung, dan sebagai anggota MPKSDU PWM Lampung. Penghargaan Dosen Terinspirasi pernah diperoleh tahun 2024.

"Don't stop when you're tired, stop when you're done"



Ardila Lailatul Barik, S.Kep., Ns., M.Kep., Lahir di Jember, 07 Agustus 1992. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi S-1 Keperawatan dan Program Studi Profesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jember. Berangkat dari rasa keingintahuan yang tinggi terhadap pendidikan keperawatan, penulis melanjutkan studi magister di Program Studi Magister Keperawatan, Fakultas Keperawatan, Universitas Airlangga Surabaya dan lulus pada Tahun 2020. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2017 sebagai tenaga freelance enumerator untuk beberapa penelitian baik penelitian dari Kementerian Kesehatan RI maupun lembaga penelitian independen. Saat ini penulis bekerja di Program Studi D-III Keperawatan, Universitas Bondowoso mengampu mata kuliah komunitas dan keluarga serta mata kuliah keperawatan dasar lainnya. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku maupun publikasi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ardilabarik@gmail.com

PROFIL PENULIS



Anis Rosyiatul Husna, S.Kep., Ns., M.Kes., Lahir di Magetan, 31 Oktober 1981. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan, Universitas Airlangga tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sebelas Maret dan lulus pada tahun 2010. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2006 sebagai dosen di Prodi S1 Keperawatan FIK

Universitas Muhammadiyah Surabaya sampai sekarang dan mengampu mata kuliah Keperawatan Dasar, Pendidikan dan Promosi kesehatan, Keperawatan Komunitas dan Keperawatan Keluarga. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan internasional serta reviewer jurnal SINTA. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: anisrosyiatulhusna@um-surabaya.ac.id



Christine Bernadette Maria Rumokoy, S.Kep., Ns., M.Kep, Lahir di Tomohon, 26 Desember 1998. Penulis konsisten dan linear dalam menempuh dunia pendidikan Keperawatan. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners di Fakultas Keperawatan, Universitas Katolik De La Salle Manado lulus pada tahun 2021. Kemudian melanjutkan pendidikan Magister Keperawatan yang selesai pada tahun 2023 di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya dengan peminatan Keperawatan Medikal Bedah. Saat ini

penulis merupakan staff pengajar di Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Sam Ratulangi Manado. Penulis dapat dihubungi melalui email: crumokoy@gmail.com.

PROFIL PENULIS



Dr. Faisal Ibnu, S.Pd., S.Kep.Ns. M.Kes. Lahir di Lamongan, 15 Februari 1972. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu Program S1 Ilmu Pendidikan pada Universitas PGRI Adibuana Surabaya tahun 2002, Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kesehatan pada Universitas Airlangga Surabaya dan lulus tahun 2006. Ambil Program S1 Keperawatan dan Profesi Ners lulus tahun 2011. Selanjutnya menempuh program Doktoral Keperawatan, Universitas Indonesia lulus tahun 2020.

Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1997- 1999 bekerja sebagai perawat pelaksana di RSUD Sidoarjo, selanjutnya per 1 Maret 1999 sampai sekarang bekerja di Universitas Bina Sehat (UBS) PPNI Mojokerto. Saat ini penulis mengampu mata kuliah Keperawatan Komunitas, Keluarga, Gerontik, Metodologi Penelitian dan Biostatistik. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi ilmiah, seminar, dan sebagai nara sumber di berbagai instansi. Penulis juga aktif di organisasi profesi sebagai Sekretaris DPD PPNI Kab. Mojokerto dan pengurus Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia (IPKKI) Jawa Timur. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: faizubspni@gmail.com. **Motto:** "Never stop creating and enjoy your life"

Sinopsis

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga bunga rampai yang berjudul **“Asuhan Keperawatan Keluarga pada Keluarga dengan Anggota yang Menderita Tuberkulosis Paru”** ini dapat disusun dengan baik. Buku ini hadir sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan ilmu keperawatan keluarga, khususnya dalam upaya perawatan, pencegahan penularan, dan pemulihan pasien Tuberkulosis Paru di lingkungan keluarga.

Tuberkulosis Paru merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Penyakit ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisik penderita, tetapi juga memengaruhi aspek psikologis, sosial, ekonomi, serta kualitas hidup keluarga. Dalam konteks ini, keluarga memiliki peran yang sangat penting sebagai sistem pendukung utama bagi pasien, baik dalam membantu kepatuhan pengobatan, memenuhi kebutuhan nutrisi, menjaga kebersihan lingkungan, maupun mencegah terjadinya penularan kepada anggota keluarga lainnya.

Bunga rampai ini membahas berbagai aspek penting dalam asuhan keperawatan keluarga pada keluarga dengan anggota yang menderita TB Paru. Materi yang disajikan meliputi konsep keluarga dan Tuberkulosis, tugas kesehatan keluarga dalam perawatan anggota keluarga dengan TB Paru, pengkajian keperawatan keluarga dan kondisi lingkungan rumah, edukasi kepatuhan minum obat, etika batuk, nutrisi, serta ventilasi rumah. Selain itu, buku ini juga menguraikan pemberdayaan keluarga dalam pencegahan penularan dan dukungan terhadap pemulihan pasien TB Paru.

Penyusunan buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, serta masyarakat yang memiliki perhatian terhadap penanggulangan Tuberkulosis Paru berbasis keluarga. Melalui pemahaman yang komprehensif, keluarga diharapkan mampu menjalankan perannya secara optimal dalam mengenali masalah kesehatan, mengambil keputusan yang tepat, merawat anggota keluarga yang sakit, menciptakan lingkungan rumah yang sehat, serta memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan secara efektif.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan karya ini pada masa yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam penyusunan bunga rampai ini.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi sumbangan positif dalam penguatan praktik keperawatan keluarga, khususnya dalam perawatan pasien Tuberkulosis Paru dan pencegahan penularannya di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga bunga rampai yang berjudul "Asuhan Keperawatan Keluarga pada Keluarga dengan Anggota yang Menderita Tuberkulosis Paru" ini dapat disusun dengan baik. Buku ini hadir sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan ilmu keperawatan keluarga, khususnya dalam upaya perawatan, pencegahan penularan, dan pemulihan pasien Tuberkulosis Paru di lingkungan keluarga.

Tuberkulosis Paru merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Penyakit ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisik penderita, tetapi juga memengaruhi aspek psikologis, sosial, ekonomi, serta kualitas hidup keluarga. Dalam konteks ini, keluarga memiliki peran yang sangat penting sebagai sistem pendukung utama bagi pasien, baik dalam membantu kepatuhan pengobatan, memenuhi kebutuhan nutrisi, menjaga kebersihan lingkungan, maupun mencegah terjadinya penularan kepada anggota keluarga lainnya.

Bunga rampai ini membahas berbagai aspek penting dalam asuhan keperawatan keluarga pada keluarga dengan anggota yang menderita TB Paru. Materi yang disajikan meliputi konsep keluarga dan Tuberkulosis, tugas kesehatan keluarga dalam perawatan anggota keluarga dengan TB Paru, pengkajian keperawatan keluarga dan kondisi lingkungan rumah, edukasi kepatuhan minum obat, etika batuk, nutrisi, serta ventilasi rumah. Selain itu, buku ini juga menguraikan pemberdayaan keluarga dalam pencegahan penularan dan dukungan terhadap pemulihan pasien TB Paru.

Penyusunan buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, serta masyarakat yang memiliki perhatian terhadap penanggulangan Tuberkulosis Paru berbasis keluarga. Melalui pemahaman yang komprehensif, keluarga diharapkan mampu menjalankan perannya secara optimal dalam mengenali masalah kesehatan, mengambil keputusan yang tepat, merawat anggota keluarga yang sakit, menciptakan lingkungan rumah yang sehat, serta memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan secara efektif.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan karya ini pada masa yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam penyusunan bunga rampai ini.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi sumbangan positif dalam penguatan praktik keperawatan keluarga, khususnya dalam

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



Optimal
Untuk
Negeri



optimal



IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA

ISBN 978-634-7756-38-1 (PDF)



9

786347

756381